

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
Army Medical Field Service School

คู่มือ
การส่งกลับทางการแพทย์

แผนกวิชาการเสนารักษ์ กองการศึกษา
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

ตอนที่ ๑

ระบบการบริการทางการแพทย์ในสนาม

๑-๑ กล่าวทั่วไป

๑-๑-๑ วัตถุประสงค์ของระบบการบริการทางการแพทย์ในสนามคือ การอนุรักษ์กำลังรบ ทั้งในขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่ และขณะอยู่ในที่ตั้งปกติ ระบบการบริการทางการแพทย์ในสนามแบ่งออกเป็น สามระดับ ได้แก่ ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และ ยุทธวิธี ทำการสนับสนุนกองทัพบก โดยให้การสนับสนุนหน่วยกำลังรบ ที่มีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ หน่วยที่ทำการรบหนักหน่วง มีการรบในวงกว้าง หรือต่อเนื่องยาวนานที่อาจมีการสูญเสียชีวิตของกำลังพล การรบของกองกำลังในศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นการรบที่มีการกระจายกำลัง ซึ่งต้องสามารถจัดหน่วยได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติการได้รวดเร็ว สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วตามที่ต้องการ และมีการสื่อสารที่ฉับไว

๑-๑-๒ ผู้บังคับบัญชาหน่วยสายแพทย์จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล การส่งกลับ และถ้าเป็นไปได้ทำการส่งคืนไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว

๑-๒ ภัยคุกคาม

๑-๒-๑ เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง สัญญาณของการจัดระเบียบโลกใหม่ก็ปรากฏขึ้น เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่นปัญหาเรื่องเชื้อชาติ การแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลกระทบอย่างมากมาย การรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ทหารจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และ ปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม เป็นต้น

๑-๒-๒ สัดส่วนของภัยคุกคาม ที่กองทัพต้องเผชิญมีขนาดลดลง ทำให้มีผลต่อขนาดและขีดความสามารถของกองทัพในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ปรับให้มีขนาดเล็กลง มีอัตราการจัด และการฝึกที่ดีขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ปรับขีดความสามารถของกองทัพให้เข้ากับเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพด้วยอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย กำลังหลักสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยกำลังขนาดเล็ก มีกำลังพลที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ประเทศเหล่านี้ต่างสามารถผสมผสานระบบความก้าวหน้าของอาวุธเทคโนโลยีสูง เพื่อยกระดับพลังอำนาจให้สูงกว่าประเทศอื่นๆ ขณะที่อาวุธเทคโนโลยีสูงนี้สามารถหาได้ ด้วยการซื้อโดยตรง หรือผ่านคนกลาง แต่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะผู้ก่อความไม่สงบ หรือกลุ่มทหารรับจ้างก็ยังคงใช้อาวุธที่มีเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก หรือมีขีดความสามารถต่ำ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นภัยคุกคามในระดับต่ำ กองกำลังฝ่ายตรงข้าม จะมีขนาดเล็ก มีความอ่อนตัวในการใช้อาวุธ

๑-๒-๓ กรมแพทย์ทหารบก พิจารณาภัยคุกคามในสองมุมมองในการให้บริการทางการแพทย์ในสนาม มุมมองแรก คือ ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามซึ่งขัดขวางการบริการแพทย์ในสนาม และ

มุมมองที่สอง คือความรับผิดชอบของกรมแพทย์ในการอนุรักษ์กำลังรบจากความเจ็บป่วย และอันตรายจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย จัดเป็นภัยคุกคามทางการแพทย์

๑-๓ ภัยคุกคามทางการแพทย์ และ ข่าวกรองทางการแพทย์

๑-๓-๑ ภัยคุกคามทางการแพทย์ หมายถึงทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขีดความสามารถของข้าศึก รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลให้สมรรถนะของทหารในสมรภูมิลดลง ได้แก่ การบาดเจ็บ มีบาดแผล ความเครียด และอาการเจ็บป่วย ดังต่อไปนี้

- โรคระบาดในพื้นที่
- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(ความร้อน ความเย็น ความชื้น และความกดอากาศสูง)
- การบาดเจ็บจากการรบ
- สารเคมี ชีวะภาพ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.)
- การระเบิด
- ไฟไหม้หรือการลอบวางเพลิง
- สารพิษจากการอุตสาหกรรม
- ความเครียดที่เกิดจากการรบ

๑-๓-๒ เพื่อเป็นการพัฒนา แผน และระบบการบริการทางการแพทย์ ผู้วางแผนจะต้องหาข้อมูลด้านข่าวกรองทางการแพทย์ จากฝ่ายข่าวกรองทั่วไปหรือช่องทางอื่นๆ ข่าวกรองทางการแพทย์นี้จะได้มาจากการรวบรวมข้อมูล การประเมินค่า การวิเคราะห์ การบูรณาการ และการแปรผลข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั่วไป และข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และผู้วางแผนทางการแพทย์จะต้องให้ความสนใจกับข้อมูลสุขภาพของประชากรในท้องถิ่น และในยุทธบริเวณ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการจัดการทางด้านข่าวกรองระดับชาติก่อนนำมาใช้

๑-๔ การส่งกลับทางการแพทย์ และ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

๑-๔-๑ การส่งกลับทางการแพทย์เป็นการนำผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยออกจากพื้นที่ปฏิบัติการรบหรือพื้นที่ต่างๆไปยังสถานที่ให้การรักษาพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา โดยกำลังพลสายแพทย์ ทำการจัดเตรียมยานพาหนะและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการทำให้ผู้ป่วยเจ็บกลับสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น และ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะทุพลภาพที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว และต้องทำให้อาการของผู้ป่วยคงที่ก่อนการเคลื่อนย้าย

○ หน่วยแพทย์ที่มีขีดความสามารถสูงกว่าจะเป็นผู้ทำการส่งกลับให้แก่หน่วยแพทย์ที่มีขีดความสามารถต่ำกว่า เช่น หน่วยแพทย์ระดับสองจะรับผิดชอบการส่งกลับจาก หน่วยแพทย์ระดับที่หนึ่ง

○ การส่งกลับทางการแพทย์เริ่มขึ้น เมื่อกำลังพลสายแพทย์รับผู้ป่วยไว้ และดำเนินการส่งต่อไปในส่วนหลังเมื่อสภาพของผู้ป่วยเจ็บ หรือสถานการณ์ทางยุทธวิธีเอื้ออำนวย

๑-๔-๒ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เป็นคำที่ใช้ในการขนย้ายผู้บาดเจ็บโดยหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยสายแพทย์ โดยไม่ใช้ยานพาหนะทางการแพทย์

ข้อควรระวัง *การขนส่งผู้บาดเจ็บนี้ไม่ผ่านสายการแพทย์ ฉะนั้นหากสภาพของผู้ป่วยแย่ลง อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความพิการตามมาได้*

○ ถ้ายานพาหนะทางการแพทย์มีพร้อม ผู้ป่วยควรได้รับการส่งกลับทางการแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลทางการแพทย์

○ ในกรณีที่การส่งกลับทางการแพทย์มีจำนวนผู้ป่วยมาก (เช่นในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่) ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยที่สุดจะได้รับการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ซึ่งกำลังพลสายแพทย์ในพื้นที่จะเป็นผู้จัดลำดับความเร่งด่วนในการส่งกลับทั้งทางรถยนต์ และเครื่องบิน

หมายเหตุ *บนยานพาหนะที่มิใช่ยานพาหนะทางการแพทย์อาจจะไม่มีผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเจ็บ ด้วยวิธีการนี้การให้การช่วยชีวิตเบื้องต้นสามารถทำได้อย่างจำกัดโดยขึ้นกับปัจจัยต่างดังนี้*

- *ทักษะความชำนาญของผู้ให้การดูแล (นายสิบพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่ได้รับการฝึกการช่วยชีวิตฉุกเฉิน สามารถทำการรักษาพยาบาล ส่วนนายสิบพยาบาลกองร้อยได้รับการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น)*
- *สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือ*
- *จำนวนของผู้ป่วย*
- *การเข้าถึงตัวผู้ป่วยเจ็บเพื่อประเมินอาการ ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากอยู่บนรถที่ไม่ใช่รถพยาบาลและกำลังเคลื่อนที่ นายสิบพยาบาลจะไม่สามารถให้การดูแลปฐมพยาบาลได้ อาจจะต้องมีการหยุดรถเพื่อให้การปฐมพยาบาล*

๑-๕ นโยบายการส่งกลับในยุทธบริเวณ

๑-๕-๑ นโยบายการส่งกลับในเขตยุทธบริเวณ กำหนดเป็นจำนวนวัน ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่นานที่สุด สำหรับผู้ป่วยที่จะอยู่ในยุทธบริเวณ ผู้ป่วยที่คาดว่าจะไม่สามารถส่งคืนไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเวลาที่กำหนดในนโยบายการส่งกลับ จะได้รับการส่งกลับไปยังสถานที่ปลอดภัย แพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในการส่งกลับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทำให้อาการผู้ป่วยเลวลง ตัวอย่างเช่น ถ้านโยบายการส่งกลับเท่ากับ ๑๕ วัน ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะอยู่ในยุทธบริเวณ ๑๔ วัน จึงจะได้รับการส่งกลับ แต่หมายความ

ว่าผู้ป่วยจะต้องถูกส่งกลับเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าไม่สามารถส่งคืนไปปฏิบัติหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยแพทย์ระดับ ๓ หรือโรงพยาบาล

๑-๕-๒ กรณีที่ไม่ได้มีแผนสำหรับผู้ป่วยจำนวนมาก (เช่น ถูกโจมตีอย่างหนัก หรือเกิดโรคระบาด) อาจต้องลดเวลาของนโยบายการส่งกลับลงตามความจำเป็น การลดนโยบายการส่งกลับนี้เป็นการปรับตามจำนวนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเขตยุทธบริเวณ การปรับลดนโยบายการส่งกลับจะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสูงขึ้น เพื่อช่วยลดความคับคั่งของผู้ป่วยในเขตยุทธบริเวณ

๑-๕-๓ ระยะเวลาตามนโยบายการส่งกลับ เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลภายในเขตยุทธบริเวณ รวมเวลาที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานที่ให้การรักษาพยาบาลและเวลาอยู่ในโรงพยาบาล การคงอยู่ในยุทธบริเวณนี้จะต้องไม่ทำให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงหรือมีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล

๑-๕-๔ กำลังพลแต่ละเหล่าจะมีความเข้าใจนโยบายในการส่งกลับแตกต่างกันออกไป เช่น

- แพทย์ทำหน้าที่รักษาพยาบาลและตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข้าใจว่านโยบายในการส่งกลับคือเวลานานที่สุดในการรักษาพยาบาลในยุทธบริเวณ เพื่อให้สามารถส่งคืนผู้ป่วยสู่ สมรภูมิโดยเร็วที่สุด ถ้านโยบายการส่งกลับเป็น ๑๕ วัน เวลาโดยประมาณในการส่งคืนผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยจะคงอยู่ในโรงพยาบาลในยุทธบริเวณภายในห้วงเวลา ๑๕ วัน แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถส่งคืนได้ภายใน ๑๕ วัน ผู้ป่วยก็จะถูกส่งกลับเร็วที่สุดเท่าที่สภาพอาการของผู้ป่วยปลอดภัยเพียงพอ
- ผู้วางแผนการบริการทางการแพทย์สนับสนุนการรบ เข้าใจว่า เมื่อได้รับนโยบายการส่งกลับจะต้องคำนวณจำนวนเตียง มีการจำแนกประเภท และการกระจายเตียงไปตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตยุทธบริเวณ
- สำหรับฝ่ายส่งกำลัง หมายถึง การประมาณการในระบบการสนับสนุนทั้งหมด
- นายทหารยุทธการ การบริการทางการแพทย์ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยตามความต้องการ ในการออกปฏิบัติการของหน่วยแพทย์ หน่วยสามารถบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ในอัตราไปด้วย เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่คุ้มค่าและประหยัดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่

๑-๖ ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายการส่งกลับ

นโยบายการส่งกลับมีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยสายแพทย์ที่ให้การบริการทางการแพทย์ นายทหารยุทธการของหน่วยสายแพทย์จะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อนโยบายการส่งกลับดังต่อไปนี้

๑-๖-๑ ปัจจัยหลัก คือ ยุทธวิธีหรือลักษณะของปฏิบัติการ เช่น ระยะเวลาในการปฏิบัติการ การใช้กำลัง การใช้อาวุธที่มีอำนาจการทำลายสูง เช่น คชรน. หรือ เป็นเพียงการใช้อาวุธตามแบบ ประเภทของผู้ป่วย การเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากการรบ หรือ เกิดจากที่มิใช่จากการรบ

๑-๖-๒ จำนวนและประเภทของผู้ป่วยที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมทั้งอัตราการส่งคืนไปปฏิบัติหน้าที่ อัตราการรับผู้ป่วยไว้รักษาพยาบาลจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และปฏิบัติการทางทหารที่แตกต่างกัน

๑-๖-๓ เครื่องมือในการส่งกลับ หมายถึงจำนวน และ ประเภทของการขนส่งที่สามารถจัดหาได้จากเขตยุทธบริเวณเพื่อใช้ในการส่งกลับผู้ป่วยจากพื้นที่การรบมายังเขตภายใน

๑-๖-๔ ความสามารถในการทดแทน เมื่อมีการส่งกลับผู้ป่วยแต่ละคนไปยังเขตภายในแล้ว สามารถจัดกำลังที่ได้รับการฝึกอย่างดีไปทดแทนได้หรือไม่

๑-๖-๕ ทรัพยากรที่สามารถจัดหาได้ในเขตยุทธบริเวณ การจัดสรรและข้อจำกัดของสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในยุทธบริเวณ สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อนโยบายการส่งกลับ ข้อจำกัดยิ่งมากเท่าใดนโยบายการส่งกลับก็จะต้องยิ่งสั้นลงเท่านั้น

๑-๗ อิทธิพลของนโยบายการส่งกลับต่อการสนับสนุนบริการทางการแพทย์

๑-๗-๑ นโยบายการส่งกลับที่สั้นมีผลกระทบ ดังนี้

- จำนวนความต้องการเตียงในเขตยุทธบริเวณต่ำ
- ต้องการทรัพยากรในการส่งกลับทางอากาศในเขตยุทธบริเวณมากขึ้น
- ความต้องการการทดแทนกำลังสูงขึ้นเพื่อให้ทันกับการหมุนเวียนกำลังพล โดยเฉพาะในหน่วยปฏิบัติการรบ (ผลกระทบนี้จะมีผลต่อการขนส่งทั้งใน และนอกเขตยุทธบริเวณและความต้องการอื่นๆที่จะต้องได้รับการพิจารณา)

๑-๗-๒ นโยบายการส่งกลับที่ยาวนาน มีผลกระทบ ดังนี้

- มีการสะสมผู้ป่วยจำนวนมากและต้องการการปรับหน่วยสายแพทย์ในยุทธบริเวณ แต่ความต้องการเตียงในที่อื่นๆลดลง
- ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการปรนนิบัติบำรุงมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนการส่งกำลังที่ไม่ใช่สายแพทย์
- เพิ่มความต้องการโรงพยาบาล และการสนับสนุนด้านการช่างรวมทั้งความช่วยเหลือด้านอื่นๆในการจัดตั้งหน่วยรักษาพยาบาล(หมายถึงการสร้างโรงพยาบาลในหน่วยทหารขนาดใหญ่)
- สัดส่วนการส่งคืนผู้ป่วยกลับสู่หน้าที่ภายในยุทธบริเวณสูงขึ้นลดการสูญเสียกำลังพลที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

๑-๘ การปรับนโยบายการส่งกลับ

นโยบายการส่งกลับของหน่วยรักษาพยาบาลแต่ละระดับควรได้รับการปรับ เพื่อรักษาจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือการส่งคืนผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเพาะเจาะจงในโรงพยาบาล เมื่อมีการประมาณการว่าจำนวนเตียงจะเพิ่มขึ้นนโยบายการส่งกลับในยุทธบริเวณจะต้องได้รับการปรับเพื่อให้มีจำนวนเตียงที่คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ นั่นคือสัดส่วนผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับจากยุทธบริเวณไปยังโรงพยาบาลจะมากขึ้นกว่าในภาวะปกติ การแทนที่ของเตียงในโรงพยาบาลจะลดลงชั่วคราวดังนั้น ผู้ป่วยเจ็บจะถูกส่งกลับออกจากเขตหน้า ในระหว่างการจัดตั้งหน่วยใหม่ด้วย

๑-๙ การวางแผนทางการแพทย์ในยุทธบริเวณ

๑-๙-๑ ผู้นำหน่วยสายแพทย์จำเป็นต้องเข้าใจแผนของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถดำรงความมุ่งหมายในภารกิจอย่างต่อเนื่อง การวางแผนทางการแพทย์เป็นกระบวนที่สำคัญ ซึ่งผู้วางแผนจำเป็นต้องมีข้อมูลดังนี้

- หน่วยใดที่จะต้องให้การสนับสนุน
- เมื่อใดที่จะต้องปฏิบัติ
- จะต้องปฏิบัติอย่างไร
- ขีดความสามารถของหน่วยสายแพทย์ตามอัตราการจัดเป็นอย่างไร

๑-๙-๒ ผู้วางแผนฯจำเป็นต้องทำประมาณการเพื่อวางแผนการสนับสนุนทุกๆหน่วยด้วยความรับผิดชอบเต็มที่ โดยเตรียมแผนสนับสนุนตามการร้องขอของหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติการ อาทิ การส่งกลับสายแพทย์ การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การเวชกรรมป้องกัน การส่งกำลังทางการแพทย์ (การบริการเลือด พยาธิวิทยา ทันตกรรม การควบคุมความเครียดจากการรบ) รวมทั้ง การควบคุม บังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์และการข่าว)

๑-๙-๓ การวางแผนต้องเป็นการคิดล่วงหน้าไม่ใช่การทบทวนตามหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องสามารถจัดสรรทรัพยากร และสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์เพื่อให้สามารถสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

บทที่ ๒
ระบบการส่งกลับทางการแพทย์

๒-๑ กล่าวทั่วไป

ก. การส่งกลับทางการแพทย์ครอบคลุมทั้งการส่งกลับทหารจากจุดที่ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ และพร้อมที่จะให้การดูแลที่จำเป็นในพื้นที่ปฏิบัติการ และการส่งกลับออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้การรักษาเฉพาะทาง การฟื้นฟูสมรรถภาพและการพักฟื้น

ข. การส่งกลับทางการแพทย์ จะครอบคลุมด้านต่างๆดังนี้

- การรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ
- การคัดแยก
- การส่งกลับทางการแพทย์
- การให้การรักษาพยาบาล
- ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน ต้องสามารถทำการช่วยชีวิตฉุกเฉินได้

ค. ในสถานการณ์ที่รุนแรง การส่งกลับจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นเสมือนจุดที่เชื่อมต่อกับการให้การรักษาพยาบาล การส่งกลับทางการแพทย์จะกระทำทั้งในภาคพื้นดิน และ ทางอากาศ ซึ่งมีทั้งข้อดี และ ข้อเสียที่แตกต่างกันไป ซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพควรจะมีการส่งกำลังที่มีความประสานสอดคล้องกันเพื่อที่จะเสริมความสามารถในการทำงานซึ่งกันและกัน

ง. การให้การรักษาพยาบาลในเบื้องต้น จะกระทำที่ส่วนที่ให้การรักษาพยาบาล (ชุดรักษา / หมวดพยาบาล) ทหารจะถูกส่งกลับอย่างรวดเร็ว โดยทั้งนี้ขึ้นกับอาการ และ การส่งกลับทางการแพทย์ตามที่กำหนด ดังนี้

๑ ด่วนที่สุด

๒ ด่วนมาก

๓ ด่วน

๔ ตามปกติ / ตามความสะดวก

จ. ในสนามรบที่สถานการณ์รุนแรง การส่งกลับอาจจะกระทำได้อย่างลำบาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถทำการส่งกลับได้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้หน่วยและทรัพยากรในการส่งกลับเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ และ ดำรงความต่อเนื่องไว้ได้ ข้าศึกอาจจะทำการซุ่มยิงจากที่กำบัง และซ่อนพราง เราจะต้องลดความเสี่ยงในสถานการณ์เช่นนี้

๒-๒ การส่งกลับทางการแพทย์

ระบบการส่งกลับทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ จะมีประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้

- ลดอัตราการตาย โดยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บมายังที่ให้การรักษาพยาบาล ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ช่วยทำการต่อสู้ในสนามรบ ดำเนินยุทธวิธีได้ตามภารกิจ
- สร้างขวัญและกำลังใจของทหาร โดยให้การรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว เมื่อพวกเขาได้รับการบาดเจ็บ
- ให้การรักษาตามความจำเป็นและเหมาะสม

ก.หน่วยระดับที่สูงกว่าจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อทำการส่งกลับจากหน่วยระดับที่ต่ำกว่า

ข.การทำการส่งกลับจะต้องมีความสามารถในการเคลื่อนที่ใกล้เคียงหน่วยที่ให้การสนับสนุน

ค.ผู้บังคับบัญชาหน่วยแพทย์จะรับผิดชอบต่อการส่งกลับทางการแพทย์เป็นหลัก มีอำนาจสั่งการสำหรับการส่งกลับทางการแพทย์ทั้งหมด ผู้ที่ทำการส่งกลับต้องมั่นใจได้ว่ามีการส่งกลับที่เหมาะสมโดยขึ้นกับ สิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

๑)สภาวะอาการของผู้ป่วยเจ็บ

๒)ทรัพยากรในการทำการส่งกลับ

๓) สถานที่ให้การรักษาพยาบาล

๔) สถานการณ์ทางยุทธวิธี

ง.การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บโดยรถยนต์ และ ฮ. อื่นๆ ที่ไม่ใช้ รถยนต์พยาบาล และ ฮ.พยาบาล จะถูกพิจารณาในกรณีที่มีผู้ป่วยเจ็บเป็นกลุ่มก้อน เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เหล่าแพทย์ อาจจะถูกใช้ในการเสริมกำลังเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาล การเพิ่มเจ้าหน้าที่สายแพทย์ อาจจะได้รับจากกองร้อยเสนารักษ์ในกองพล หรือ กองพันเสนารักษ์ เมื่อกำลังพลสายแพทย์ไม่เพียงพอ การขนส่งผู่ป่วยเจ็บอาจจะต้องใช้ยานพาหนะของเหล่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล่าแพทย์

จ.ต้องมีดูแลรักษาในระดับที่เหมาะสมตลอดความต่อเนื่องของการดูแลผู้ป่วย เช่นการช่วยชีวิต การควบคุมความเสียหาย หรือการควบคุมความเสียหายต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของการสนับสนุนการดูแลที่สำคัญซึ่งเริ่มต้นที่สถานบริการทางการแพทย์ไปข้างหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้อาการของผู้ป่วยเหล่านี้แย่ลงในระหว่างการขนส่ง การดูแลที่เหมาะสมระหว่างเส้นทางจากพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม ถ้าเป็นไปได้สำหรับการดูแลระหว่างเส้นทางนี้ควรส่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ปัจจัยต่างๆ เอื้ออำนวย ได้แก่ ภารกิจ ข้าศึก ภูมิประเทศ และ สภาพอากาศ กองกำลัง เวลาที่มี และข้อพิจารณาด้านพลเรือน

๒-๓ ข้อพิจารณาเบื้องต้นการส่งกลับทางการแพทย์

ก. กล่าวทั่วไป

ปัจจัย METT-T จะมีผลต่อการปฏิบัติของหน่วยทั้งหมด ผู้บังคับบัญชาที่ทำการส่งกลับจะต้องพิจารณาหลักพื้นฐาน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการส่งกลับ ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่

- จำนวนผู้ป่วยเจ็บที่คาดการณ์ไว้
- พื้นที่ ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเจ็บหนาแน่น
- สภาวะของผู้ป่วยเจ็บ
- ทรัพยากรในการทำการส่งกลับ
- ที่ตั้ง และ ประเภทของสถานที่ให้การรักษาพยาบาล
- การป้องกันเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยเจ็บ หน่วยแพทย์ ยานพาหนะ ภายใต้สนธิสัญญาเจนีวา
- แผนควบคุมสั่งการของการบินทหารบก
- เครือข่ายถนน
- สภาพภูมิอากาศ

ข. การรับผู้ป่วยเจ็บ

(๑) หน่วยที่มีอุปกรณ์ส่งกลับทางการแพทย์อยู่ในอัตราจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ป่วยเจ็บ วิธีการปฏิบัติและ วิธีการส่งกลับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการ

(๒) หน่วยที่ไม่มีรถยนต์พยาบาล และ การส่งกลับในอัตรา จะได้รับการสนับสนุนการส่งกลับเป็นพื้นที่จากหน่วยในอัตรา และ จำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคที่จะช่วยให้การส่งกลับมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเจ็บในพื้นที่เขตหน้า การร้องขอการส่งกลับอย่างรวดเร็ว เทคนิคนี้ควรกำหนดไว้เป็นระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วย ซึ่งอย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ดังนี้

- การจัดยานพาหนะสำหรับนายสิบพยาบาล
- ยานพาหนะในการเคลื่อนย้าย และ การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ
- ขั้นตอนในการร้องขอการส่งกลับ(ในสถานการณ์ปกติ หรือ เมื่อมีผู้ป่วยจำนวนมาก)
- บทบาทหน้าที่ของจ่า จ่าประจำหมวด และ นายสิบพยาบาลกองร้อย/นายสิบกู้ชีพในการส่งกลับ

(๓) ปัจจัยต่อไปนี้ควรจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีการเลือกเส้นทางสำหรับรถยนต์พยาบาล

- ยุทธวิธีของภารกิจ
- แผนการประสานการส่งกลับ และ ปฏิบัติการกับนายทหารที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้าย
- เส้นทางการส่งกลับที่เป็นไปได้
- สภาพถนน และ เส้นทางระหว่างประเทศ
- ความหนาแน่นของการจราจร
- ปัจจัยด้านเวลาและระยะทาง
- เส้นทางที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นในกรณีที่ข้าศึกโจมตี

- เส้นทางรองสำหรับการขนย้ายผู้ป่วยเจ็บ

- การป้องกัน ซ่อนพราง หรือการกำบังที่สามารถหาได้ในการเคลื่อนที่หรือจอดอยู่กับที่ของยานพาหนะ

- แผนในการทำเครื่องกีดขวาง แผนการยิงสนับสนุน เพื่อให้แน่ใจว่าชุดส่งกลับทางการแพทย์จะไม่ถูกฆ่า และ ได้รับการระวังป้องกัน

(๔) วิธีการส่งกลับอาจจะเป็นการให้ผู้ป่วยเจ็บเดินไป การแบกหามโดยใช้เปล การใช้ยานพาหนะของหน่วยแพทย์ หรือหน่วยอื่นๆ การส่งกลับภายในกองพันทั้งนี้แล้วแต่สถานการณ์ทางยุทธวิธี โดยปกติใช้รถยนต์พยาบาลที่มีในอัตรา การส่งกลับทางอากาศจะขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ สภาพอาการของผู้ป่วยเจ็บ สถานการณ์ทางยุทธวิธี และ สภาพอากาศ

ก) ปกติชุดรถยนต์พยาบาล หรือ หมู่รถยนต์พยาบาล จะถูกส่งไปในตอนท้ายของขบวนกองร้อย ในพื้นที่ที่ไกลออกไปข้างหน้ามากที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย ภายใต้การควบคุมทางยุทธวิธีของนายทหารยุทธการ หรือจ่ากองร้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามจะยังคงอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการของหมวดพยาบาล

ข) นายทหารยุทธการจะต้องมั่นใจว่ารถยนต์พยาบาลจะอยู่ใกล้กับจุดรับส่งผู้ป่วยเจ็บมากที่สุด ชุดรถยนต์พยาบาลประกอบด้วย รถยนต์พยาบาลหนึ่งคัน และ นายสิบพยาบาล ๑นาย ให้การดูแลผู้ป่วยเจ็บขณะเดินทาง หนึ่งหรือสองทีมของชุดนี้จะให้การสนับสนุนโดยตรงกับกองร้อยดำเนินกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่ปฏิบัติการและ สถานการณ์ในสนามรบ ชุดจะดำรงการติดต่อกับกองร้อยในระหว่างการปฏิบัติการในสนามรบ การกำหนดให้มีรถพยาบาลไว้ใช้ในตลอดพื้นที่ของกองพัน หรือพื้นที่ของที่พยาบาลกองพัน

- ทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากที่พยาบาลกองร้อย จุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ หรือจุดแลกเปลี่ยนมายังที่พยาบาลกองพัน

- ทำการเพิ่มเติมกำลัง ในส่วนหน้า

- ทำหน้าที่เป็นกำลังสำรองในการสนับสนุนการรบ

ค) ชุดรถยนต์พยาบาลส่วนที่เพิ่มเติม เป็นการเตรียมเพื่อใช้เป็นการเตรียมเพื่อใช้ในการส่งกำลังออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังส่วนหน้า ณ ที่พยาบาลกองร้อย หรือจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ หรือ ที่พยาบาลกองพัน

ง) หลายครั้งที่รถยนต์พยาบาลไปพบผู้ป่วยเจ็บโดยไม่พบนายสิบพยาบาลกองร้อย ชุดรถยนต์พยาบาลจะทำหน้าที่ให้การดูแล และทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ

จ) ชุดรถยนต์พยาบาลจะได้รับมอบหมายให้ทำการสนับสนุนหน่วยรบ ในลักษณะของการขนส่งในสายการแพทย์ คือ ขนส่งผู้ป่วยเจ็บ เจ้าหน้าที่ และ สิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์

(๕) เมื่อสถานการณ์คงที่ และ ส่วนดำเนินกลยุทธ์ไม่ได้ปะทะกับข้าศึก หรือ อยู่ในระหว่างการสำรองกำลัง ชุดรถยนต์พยาบาลจะกลับไปยังที่พยาบาลกองพัน เพื่อทำการเพิ่มเติมกำลังให้กับหน่วยอื่นๆ อย่างไรก็ตามระหว่างการเคลื่อนย้ายชุดรถยนต์พยาบาลจะถูกส่งไปพร้อมกับหน่วย

สนับสนุน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บกลับไปยังจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าอื่นๆที่ไม่ใช่เหล่าแพทย์ หน้าที่เฉพาะของชุดรถยนต์พยาบาลคือ

- ดำรงการติดต่อหน่วยให้การสนับสนุน
- ค้นหา และ รวบรวมผู้ป่วยเจ็บ
- ให้การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
- ริเริ่ม หรือ บันทึกแผนบันทึกทางการแพทย์ให้เสร็จสมบูรณ์
- ส่งกลับผู้ป่วยไปยังที่พยาบาลกองพัน
- ให้คำแนะนำ และ ชี้ทางให้กับผู้ป่วยที่บาดเจ็บเล็กน้อยไปยังที่พยาบาลกองพัน
- สนับสนุนนายสิบพยาบาลเพิ่มเติม
- ทำหน้าที่คล้ายเป็นผู้จัดการทางการแพทย์

(๖) ระหว่างปฏิบัติการรุก จุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บอาจจะถูกใช้เป็นที่หลีกเลี่ยงการกีดขวางการเคลื่อนย้ายของหน่วยทางยุทธวิธี ในการเคลื่อนที่เร็วการวางแผนจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บจะรวมอยู่ในแผนการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บไว้หลายๆจุดในแต่ละช่วงเวลาของการปฏิบัติการ การเปลี่ยนหมุนเวียนจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บเป็นการหลีกเลี่ยงการโจมตีจากข้าศึก เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยการส่งกลับผู้ป่วยจากจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ หรือจุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาลอาจจะโดยอากาศยาน

(๗) ชุดรถยนต์พยาบาลจะใช้การกำบังซ่อนพราง ตามภูมิประเทศ และ หลีกเลี่ยงภูมิประเทศที่อาจจะตกเป็นเป้าหมาย เมื่อต้องหยุดเคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับรถถังให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(๘) เมื่อมีผู้ป่วยเจ็บในรถถัง หรือจากยานพาหนะของทหารราบ ชุดรถยนต์พยาบาลจะเคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับรถถังให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำการช่วยผู้ป่วยเจ็บออกมาจากยานพาหนะ และทำการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน ชุดรถยนต์พยาบาลจะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บไปยังที่พยาบาลกองพัน หรือจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ เพื่อรอคอยการส่งกลับ โดยปกตินายสิบพยาบาลจะอยู่ในขบวนของกองร้อย ซึ่งอาจจะถูกใช้อยู่ในพื้นที่ของกองร้อย หรือในการช่วยเหลือในชุดรถยนต์พยาบาล หรืออาจจะใช้ชุดรถยนต์พยาบาลให้ไปอยู่ในที่ตั้ง ณ ที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากชุดรักษาพยาบาล ในบางสถานการณ์ลูกเรือต้องช่วยชีวิตตนเอง หรือ ช่วยเพื่อน ก่อนที่นายสิบพยาบาลจะมาถึง

(๙) การส่งกลับทางการแพทย์ในพื้นที่จะร้องขอจากการบริการทางการแพทย์จากหน่วยทุกระดับที่ไม่มีอัตราของชุดส่งกลับ เช่น ทหารช่าง จะร้องขอการสนับสนุนการส่งกลับ ผู้ที่วางแผนทางการแพทย์จะต้องประมาณการความต้องการนี้ไว้ในแผนการปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริการทางการแพทย์ที่เพียงพอ และ การประสานงานล่วงหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นรวมทั้งการกำหนดจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ จุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาล ที่พยาบาลกองพันต้องสามารถกระจายไปในพื้นที่เหล่านั้น รวมทั้งการร้องขออื่นๆ

๒.๔ การแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์

ก. เมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยเจ็บถูกส่งกลับจากที่ให้การรักษาพยาบาลไปยังสถานที่อื่นๆ จากรถยนต์พยาบาล ไปสู่รถพยาบาลอีกคัน สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ผ้าห่ม เฝือก เปล สายรัดห้ามเลือด) จะติดตัวผู้ป่วยเจ็บไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยไม่จำเป็น สิ่งอุปกรณ์ และ เครื่องมือจึงต้องทำการแลกเปลี่ยนในทุกขั้นตอนของการทำการส่งกลับตลอดเวลา

ข. การแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์จะกระทำกับผู้ป่วยเจ็บของชาติพันธมิตร จะถูกส่งกลับไปยังชาตินั้นๆโดยทันทีถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ การแลกเปลี่ยนจะกระทำเช่นเดียวกันกับข้อ ก.

ค. ในกรณีที่มีสิ่งอุปกรณ์อย่างจำกัด จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับกองทัพอากาศ

๒-๕ เครื่องมือในการส่งกลับ

ปฏิบัติการทุกประเภทจำเป็นต้องมีแผนการส่งกลับ การวางแผน การประสานงาน และ การแจกจ่าย แผนทางการแพทย์ ซึ่งผู้วางแผนทางการแพทย์จะใช้สิ่งต่างๆดังนี้

(ก) จุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ เพื่อความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ ควรกำหนดจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บไว้ล่วงหน้า รวมทั้งเส้นทางการส่งกลับ การส่งกลับไปยังที่พยาบาลกองพัน นายสิบพยาบาล และ นายสิบพยาบาลกองร้อย/นายสิบกู้ชีพ หรือ กองกำลังจะทำการรวบรวมผู้ป่วยเจ็บมายังจุดที่กำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกในจุดนี้จะได้รับมาจากการสนับสนุนของรถยนต์พยาบาล ซึ่งจะเป็นการลดเวลาในการส่งกลับ เมื่อใช้ที่พยาบาลกองพันเป็นจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บจะช่วยในการดำรงการเคลื่อนที่ของที่พยาบาลกองพันเพื่อลดเวลาในการส่งกลับผู้ป่วยไปยังข้างหลัง กองพลจะกำหนดจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ ระดับของการให้บริการทางการแพทย์ เส้นทางการส่งกลับ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์พยาบาล นอกจากนี้ยังให้บริการทางการแพทย์กับหน่วยที่ไม่มีหน่วยแพทย์ในอัตราภายในพื้นที่ส่วนหน้า เมื่อกำหนดจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตัดสินใจว่าจะส่งกำลังพลสายแพทย์เข้าไปให้บริการในพื้นที่หรือไม่ การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการประเมินค่าความเสี่ยงกับกำลังพลที่สามารถจัดให้ได้ โดยทั่วไปการกำหนดระดับของการให้บริการทางการแพทย์จะกำหนดโดยฝ่ายอำนวยการ กำลังพลสายแพทย์อาจจะไม่ปรากฏในจุดเหล่านั้น ดังนั้นผู้ป่วยเจ็บอาการเล็กน้อยจึงต้องทำการช่วยเหลือตนเอง หรือ ใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน จุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บควรจะถูกกำหนดไว้บนแผ่นบริวาร

(ข) จุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาล ตำแหน่งของการแลกเปลี่ยนผู้ป่วยจากจุดที่ทำการส่งกลับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจะถูกกำหนดเป็นจุดแลกเปลี่ยน

(๑) จุดต่างๆเหล่านี้โดยปกติจะได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้า และเป็นส่วนหนึ่งในผนวกแผนปฏิบัติการ ในพื้นที่ส่วนหน้า ภัยคุกคามของข้าศึกที่ดำเนินการภาคพื้นดิน, อาวุธร้ายแรง, อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้อากาศยาน อาจจะถูกกำหนดไว้เป็นจุดนัดพบสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง

รวดเร็วจากจุดนัดพบไปยังสถานที่อื่นๆ ตำแหน่งของจุดแลกเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องการโจมตีจากข้าศึก

(๒) จุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาลจะได้รับการจัดขึ้นมาด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น หมวดรถยนต์พยาบาลของกองพลหลัก กองร้อยเสนารักษ์จะมีทั้งรถยนต์พยาบาล และรถถังพยาบาล ซึ่งถูกจัดไว้เพื่อการรักษาสถานการณ์ทางยุทธวิธี ยานพาหนะเหล่านี้จะทำการลำเลียงผู้ป่วยจากที่พยาบาลกองพันมายังจุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาลซึ่งเป็นที่รถยนต์พยาบาลจะรับผิดชอบเรื่องการส่งกลับผู้ป่วยไปยังส่วนหลัง จุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาลไม่จำกัดไว้เพียงแค่การส่งกลับภาคพื้นดินเท่านั้น แต่ในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้ทางอากาศยานในกรณีนี้ ฮ.พยาบาลไม่สามารถทำการบินไปในพื้นที่ส่วนหน้าได้ไกลไปกว่าที่พยาบาลกองพัน จุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาลควรจะอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ส่วนหลังมาก แต่ยังคงอยู่ในพื้นที่ส่วนหน้าของพื้นที่สนับสนุนกองพลน้อย รถยนต์พยาบาล รถถังพยาบาลควรจะส่งต่อผู้ป่วยมายังที่ทำการส่งกลับทางอากาศ เพื่อเป็นการลดเวลาในการส่งกลับ

(๓) การใช้จุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาล ทำให้การส่งคืนชุดต่างๆไปยังหน่วยที่สนับสนุนทำได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับ เช่นเดียวกับการส่งคืนลูกเรือ เครือข่ายถนน และการสนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธี การส่งกลับทางอากาศจะมีความจำเป็นเพื่อการบูรณาการไปยังระบบ การบังคับบัญชา และการควบคุมห้วงอากาศของกองทัพบก ในแต่ละระดับ และ เป็นการทำเพื่อให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม และเป็นการป้องกันทางอากาศยาน

(ค) ระบบการหมุนเวียนรถพยาบาล ระบบหมุนเวียนรถพยาบาล เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ และ เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่น ในการส่งรถยนต์พยาบาลในระหว่างทำการสู้รบ ในส่วนนี้จะประกอบด้วยรถยนต์พยาบาลตั้งแต่หนึ่งคันขึ้นไปในการรับส่ง การผลัดเปลี่ยน และเมื่อยามจำเป็นจุดควบคุม ทุกระดับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจากหน่วยหลักของรถยนต์พยาบาล ตามที่ตั้งกองร้อย หรือจุดผลัดเปลี่ยนตามแต่สถานการณ์

๒.๖ การสนับสนุนการส่งกลับของปฏิบัติการรุก และ การตั้งรับ

(๑) การรุกเป็นการทำสงครามที่ต้องการชัยชนะ และ ต้องการทำลายข้าศึก ดังนั้นการรุกนี้จะทำการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติการในทางลึก และ ห้าวหาญดุดัน และ มีความสามารถในการต่อสู้ป้องกันตัวเองได้

(๒) เมื่อพิจารณาแผนการส่งกลับในการสนับสนุนปฏิบัติการเชิงรุก ผู้วางแผนจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆด้วยกัน อาทิ รูปแบบทางยุทธวิธี ความสามารถของข้าศึก สภาพผู้ป่วยเจ็บ เวลา และสถานที่ จะถูกนำมาวิเคราะห์กำหนดภาระงาน การแจกจ่ายทรัพยากรทางการแพทย์ ที่ตั้งทางการแพทย์ รวมทั้งการทำงานร่วมกัน

(๓) การสนับสนุนปฏิบัติการเชิงรุกมีสิ่งจำเป็นต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างด้วยกัน เช่น เป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บในพื้นที่ไปยังสถานที่ให้การ

รักษาพยาบาลที่ทำการสนับสนุน ซึ่งเส้นทางการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บอาจยาวมากขึ้น การรวบรวมผู้ป่วยเจ็บระหว่างที่มีการปะทะกับข้าศึก ซึ่งมีอุปสรรคทั้งทางภูมิประเทศ และ ทางยุทธวิธี ระหว่างการปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด การกำหนดภาระงานที่แน่นอนโดยผู้วางแผนเป็นสิ่งจำเป็นถ้ามีการส่งกลับทางการแพทย์

(๔) พื้นที่ที่จะมีผู้ป่วยอยู่จำนวนมากของกองพลจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการปะทะ หรือในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายดังนั้น จึงเป็นความเร่งด่วนเป็นอันดับแรกของการบรรจุกำลังรบ การกำหนดกำลังรบจะได้แนวทางอย่างคร่าวๆจากพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของผู้ป่วยมาก ตามกฎโดยทั่วไปสถานที่ให้การรักษาพยาบาลทั้งหมดในกองพล จะอยู่ในพื้นที่ส่วนหน้าของกองพล ซึ่งในพื้นที่นี้จะมีการอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด ก่อนการทำการส่งกลับ ก่อนที่กองกำลังจะถูกส่งไปแทนที่ในส่วนหน้า

(๕) การรบในแนวลึกที่ใช้อาวุธที่มีอำนาจในการทำลายล้างสูงเพื่อการดูแลผู้บาดเจ็บจำนวนมากจะต้องอยู่ในเขตหลัง

(๖) การเตรียมกำลังไว้ล่วงหน้า จะช่วยการควบคุมในส่วนหน้า และทำให้การสนับสนุนหน่วยแพทย์เพื่อการดูแลผู้ป่วยได้ทันเวลา สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะมีไว้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากสนามรบ และ เป็นการช่วงเวลาที่สำคัญในการให้การรักษา ในปฏิบัติการรุก ปัญหาที่สำคัญสองประการในการให้การสนับสนุนการส่งกลับ ประการแรกคือ ดำรงการติดต่อกับหน่วยที่ให้การสนับสนุน ความรับผิดชอบสำหรับการติดต่อในระบบการส่งกลับจะเป็นจากในส่วนหลังไปยังส่วนหน้า การติดต่อจะกระทำโดยการส่งทรัพยากรในการส่งกลับทั้งทางพื้นดิน และทางอากาศ ประการที่สองคือ การเคลื่อนที่ของสถานที่ให้การรักษาพยาบาลในการสนับสนุนจะต้องยังคงมีอยู่ ในแต่ละช่วงเวลา กองร้อยเสนารักษ์กองพล รถศัลยกรรมเคลื่อนที่ และ โรงพยาบาลสนับสนุนการรบ ต้องทำให้ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถถูกส่งไปข้างหน้าได้ ความต้องการนี้จะต้องพร้อมสำหรับการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากที่ให้การรักษาพยาบาลในส่วนหน้าไปยังที่ให้การรักษาพยาบาลในแต่ละระดับได้เป็นอย่างดี

(๗) ประเภทของการส่งกลับ ในปฏิบัติการรับ

(ก) การเคลื่อนที่เข้าปะทะ การสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ในการเข้าปะทะเป็นหัวใจสำคัญของแผนทางยุทธวิธี ก่อนที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ควรเตรียมทรัพยากรให้พร้อม

(ข)การขยายผล และ ไล่ติดตาม การสนับสนุนปฏิบัติการนี้จะอยู่ในย่อหน้า ๒-๗ก ในปฏิบัติการขยายผลและไล่ติดตามจะไม่มีการวางแผนรายละเอียด การส่งกลับทางการแพทย์จะต้องอาศัยงานทางด้านการข่าว โดยทั่วไปปฏิบัติการเช่นนี้จะมีลักษณะ ดังนี้

- แยกการควบคุม
- การส่งกลับทางพื้นดินอาจจะไม่ปลอดภัย
- อาจจะมีระยะทางการส่งกลับที่ยาวนาน
-รูปขบวนอาจจะยาวมากขึ้น และ มีการใช้ ฮ.พยาบาล

(ค) การเข้าปะทะ จะมีในย่อหน้า ๒-๖ก

การสนับสนุนการรับ มีด้วยกัน ๓ รูปแบบ การตั้งรับแบบยึดพื้นที่ การตั้งรับ

แบบคล่องตัว และ การร่นถอย การตั้งรับแบบยึดพื้นที่เป็นการตั้งรับที่ไม่ยอมให้ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่ได้ ส่วนการตั้งรับแบบคล่องตัวอาจจะยอมให้ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่แต่จะมีการจู่โจม และ ต่อสู้ด้วยการยิงของกองกำลัง ส่วนรูปแบบของการร่นถอยเป็นการเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหลังห่างออกจากข้าศึก รูปแบบของการร่นถอย มีด้วยกัน ๓ แบบ คือ การรบหน่วงเวลา การถอนตัว และ การถอย

(๑) การสนับสนุนทำได้ยากในปฏิบัติการตั้งรับ อัตราการเจ็บป่วยจะน้อย แต่ว่าอาจจะมีมากขึ้นในเขตด้านหน้า กำลังพลเหล่าทหารแพทย์มีเวลาเพียงเล็กน้อยในการเข้าถึงตัวผู้ป่วยเจ็บเพื่อให้การดูแลอย่างฉุกเฉิน ตรวจสัญญาณชีพ และ ทำการเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่การรบ จำนวนผู้ป่วยเจ็บที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้การรักษาและการส่งกลับทางการแพทย์ล่าช้า ในช่วงเริ่มปะทะต้องคาดการณ์ถึงการใช้อาวุธปืนใหญ่และ อาวุธ คชรน. ที่ข้าศึกอาจจะนำมาใช้ ในภาวะสงคราม คชรน. และ การโจมตีด้วยการยิงจะทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเจ็บจำนวนมากเกิดขึ้นและอาจจะทำให้มีความล่าช้าในการนำส่งผู้ป่วยเจ็บมายังหน่วยที่ให้การรักษาพยาบาล การรบในทางลึก และ การกระจายกำลังจะทำให้เกิดปัญหาด้านระยะเวลาและระยะทางในการส่งกลับ หน่วยรบอาจจะถอนตัวและทิ้งผู้ป่วยเจ็บไว้ด้านหลัง การโจมตีของข้าศึกในช่วงแรกจะทำให้มีผู้ป่วยเจ็บหนาแน่น การส่งกลับที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมการส่งกลับทางอากาศไว้ด้วย การใช้ ฮ.พยาบาลจะต้องอยู่ทั้งในผนวกของ คำสั่งยุทธการ และ การควบคุมบังคับบัญชาห้วงอากาศ แผ่นบริวารแสดงไว้ในรูป (๒) การสนับสนุนการร้องขอในการร่นถอยอาจจะมีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับแผนทางยุทธวิธี การกระทำของข้าศึก และ ปัจจัย METT-TC ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาคือ

- การร้องขอการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด และ การรักษาแผนการเคลื่อนที่
- ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายผู้อพยพที่อาจจะมีผลต่อการส่งกลับทางการแพทย์ที่กระทำในพื้นที่ฝ่ายเรา
- การบูรณาการเส้นทางการส่งกลับและ สิ่งกีดขวาง
- อุปสรรคในการควบคุม และ การประสานงานการเคลื่อนย้ายของหน่วย ซึ่งอาจจะทำให้ตกเป็นเป้าของข้าศึก
- การเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน หรือ ที่ที่มองเห็นได้อย่างจำกัด
- เวลา และ วิธีที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บออกมาจากสนามรบ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คงที่และได้เปรียบ เวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ในห้วงเวลาของการร่นถอยเวลายิ่งมีค่ามากขึ้น ถ้ามีเวลาน้อยลงผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลในทุกระดับจะต้องประเมินความสามารถในการเก็บรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ ให้การรักษา และ ทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ
- เส้นทางการส่งกลับทางการแพทย์จะเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายของกองกำลัง และยุทโธปกรณ์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บในสถานการณ์การร่นถอยจะมีความยากมากกว่าการรบแบบอื่นๆ การควบคุม สั่งการ การสื่อสาร อาจจะถูกรบกวนจากข้าศึก ความสำเร็จในการส่งกลับทางการแพทย์ต้องการลำดับความเร่งด่วนในการใช้รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ การแนะนำ

ให้กับหน่วยรอง ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ และ การส่งกลับทางการแพทย์ ควรมีทำการคัดแยกผู้ป่วยเจ็บก่อนที่จะทำการส่งกลับ

- เมื่อผู้ป่วยเจ็บมากเกินกว่าที่จะทำการส่งกลับได้ ผู้บังคับบัญชาควรจะตัดสินใจในการทิ้งผู้ป่วยเจ็บไว้ข้างหลัง นายทหารเหล่าทหารแพทย์จะต้องบอกให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ทันเวลา ควรมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์อยู่กับผู้ป่วยเจ็บที่ไม่สามารถทำการส่งกลับได้

๒-๗ การส่งกลับทางการแพทย์สำหรับการดำเนินกลยุทธ์ด้วยวิธีต่างๆ

ก.วิธีดำเนินกลยุทธ์

๑) ตีตรงหน้า กลยุทธ์นี้ การโจมตีจะผ่านแนวรับหลักของข้าศึก ทำให้เกิดช่องว่าง หลังจากนั้นจะเข้าทำลายกำลังของข้าศึก การปฏิบัติการรุกด้วยวิธีนี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและมีการส่งกลับมากที่สุด ผู้ป่วยเจ็บจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่โจมตี เส้นทางการส่งกลับจะยาวนานออกไปตามสถานการณ์การสู้รบ การดำเนินกลยุทธ์ด้วยวิธีนี้จะต้องมีการเตรียมการยิงเป็นอย่างมาก ทำให้ข้าศึกมีการยิงโต้ตอบ ทำให้สถานที่ทำการส่งกลับต้องอยู่ไกลออกไป การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บอาจจะกระทำได้อย่างช้าๆ เนื่องจากถนนได้รับความเสียหาย หรือ การเข้าไม่ถึงตัวผู้ป่วยเจ็บ ปัญหาการสนับสนุนจะเกิดขึ้นมาก ณ จุดที่ทำการเข้าตี เมื่อมีช่องว่างในแนวรับของข้าศึก หน่วยหลักจะเข้าติดตามไล่ล่าข้าศึก หน่วยที่ให้การรักษาจะต้องอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่ทำการเข้าตี การส่งกลับทางรถยนต์พยาบาลอาจจะกระทำไม่ได้บนถนนหลักที่มีการสู้รบ นอกจากนี้ในพื้นที่นั้นยังเป็นเป้าหมายของกำลังรบหลัก และ อาวุธ คชรน.

๒) การตีตลบ การตีตลบจะทำการล้อมข้าศึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการยึดเป้าหมาย โดยทำลายในส่วนขนาบข้างและส่วนหลัง เพราะว่ากลยุทธการตีตลบจะไม่กระทำในส่วนแนวป้องกันหลักของข้าศึก ดังนั้นการส่งกลับทางการแพทย์อาจจะไม่ต้องรับภาระมากในระยะแรก รถยนต์พยาบาลในแต่ละระดับการบริการทางการแพทย์จะถูกส่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ ณ จุดที่เกิดเหตุ การเคลื่อนที่ของหน่วยพยาบาลทำการรักษาพยาบาลในระหว่างการส่งกลับ เพื่อลดความล่าช้าในการรักษา หลังจากที่ทำการคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ และ ทำการรักษาพยาบาลแล้ว ผู้ป่วยเจ็บอาจจะถูกส่งกลับไปยังสถานพยาบาลในกองทัพน้อย เมื่อนำผู้ป่วยออกมาจากพื้นที่ทำการรบ และพร้อมจะทำการส่งกลับมายังที่รักษาพยาบาล ในกรณีฉุกเฉินอาจจะมีการใช้รถยนต์ของหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยพยาบาล เมื่อต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บภายในส่วนที่ทำการตีตลบ ผบ.หน่วยแพทย์อาจจะใช้พื้นที่เพื่อทำการรวบรวม และ การปฏิบัติเป็นระยะๆ และ ทำการป้องกันรถยนต์พยาบาลผ่านพื้นที่อันตราย นอกจากนี้ ผบ. อาจจะใช้การยิงป้องกัน และการต่อสู้อากาศยาน หรือ การใช้เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางในการเคลื่อนย้าย

๓) การแทรกซึม

ก) การแทรกซึม เป็นทางเลือกที่ใช้ในระหว่างการรุก กองพลสามารถโจมตีหลังจากการแทรกซึม หรือ ใช้งานด้านข่าวกรอง การสร้างความรำคาญให้กับข้าศึก ซึ่งจะใช้เพียงบางส่วนของหน่วยเท่านั้น

ข) การบริการทางการแพทย์ในปฏิบัติการนี้ จะถูกจำกัดด้วยจำนวนอุปกรณ์ การส่งสิ่งอุปกรณ์ และ อุปกรณ์การขนส่งที่จะถูกนำส่งไปยังพื้นที่ปะทะ ไม่มีการส่งบริการทางการแพทย์ระดับสองโดยปราศจากยานพาหนะในอัตรา การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วยควรจะมียานพาหนะในอัตรา รถพยาบาลควรจะมีความเร่งด่วนเป็นอันดับแรก อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์จากที่พยาบาลกองพันไปเพื่อให้การรักษาทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน การรักษาอาการบาดเจ็บขั้นสูง เมื่อหน่วยออกไปปฏิบัติการโดยไม่มีรถพยาบาลอาจจะต้องมีการใช้เปลเสริมกำลังหมวดเสนารักษ์จากกองพล กองทัพน้อย หรือ จัดหาชุดเปลจากหน่วยรบ ผู้ป่วยเจ็บจะถูกส่งกลับจากที่พยาบาลกองพัน และมีการส่งสิ่งอุปกรณ์ และ ชุดเปล ทั้งนี้ขึ้นกับระยะทาง และ ระดับชั้นความลับตามที่ร้องขอ

ค) เมื่อมีการใช้พลร่ม และ หน่วยจู่โจมทางอากาศ หน่วยแทรกซึมอาจจะตกอยู่ในพื้นที่ของข้าศึก และต้องเดินทางด้วยเท้าไปยังพื้นที่การปะทะ การเคลื่อนที่ของหน่วยแพทย์จะถูกจำกัด ผู้ป่วยเจ็บจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังหน่วยรถพยาบาล ไปยังจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ หรือ ที่พยาบาลกองพัน หลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังที่พยาบาลกองพล เมื่อหน่วยรบเข้าถึงที่หมายไม่จำเป็นต้องรักษาความลับอีกต่อไป ควรจะแยกหน่วยแพทย์ออกจากหน่วยพลร่ม หรือ การจู่โจมทางอากาศ

๔) Turning movement ผู้ที่เข้าโจมตีจะหลีกเลี่ยงส่วนป้องกันหลัก ผู้ที่โจมตีจะมองหาพื้นที่เป้าหมาย ภูมิประเทศที่สำคัญ ลึกเข้าไปในพื้นที่ส่วนหลังของข้าศึก ต้องพบกับการคุกคามทางด้านหลัง ศัตรูจะออกจากที่ตั้ง วิธีนี้ช่วงเริ่มต้นการรบอาจจะไม่หนักหน่วง แต่ช่วงของการบุกจะเริ่มมีผู้ป่วยเจ็บอย่างมากมาย ในพื้นที่ที่มีการสู้รบที่กรุงโซล มีผู้ป่วยเจ็บเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากการขาดแคลนผู้ที่ให้บริการทางการแพทย์ จะทำให้มีพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากที่เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือการบริการทางการแพทย์จากหน่วยทหารของสหรัฐอเมริกา

- การสนับสนุนการส่งกลับทางการแพทย์ในปฏิบัติการนี้จะคล้ายกับปฏิบัติการตีตลบ ซึ่งจะเป็นการเข้าด้านหลังข้าศึก เส้นทางการสื่อสาร และการส่งกลับอาจจะไม่ปลอดภัยเป็นผลให้มีความล่าช้าในการส่งกำลัง และการส่งกลับ ตัวอย่างในอินชอน เรือพยาบาลจะอยู่ใกล้กับชายฝั่งเพื่อทำการรับผู้ป่วยเจ็บจากการสู้รบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ที่ล่อแหลม การส่งกลับอาจจะล่าช้าเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน การส่งหน่วยแพทย์ออกไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องกระทำอย่างรวดเร็ว ในการนำผู้ป่วยเจ็บออกจากพื้นที่การรบ จะทำการส่งผู้ป่วยเจ็บจากส่วนหน้าไปยังส่วนหลังจนกว่าเส้นทางการส่งกลับจะได้ถูกสร้างขึ้น

ข. Enabling Operations

๑) Passage of line

เส้นทางการเคลื่อนที่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน จะเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้ที่ทำการวางแผนหน่วยที่ทำการส่งกลับจะมีรถยนต์พยาบาลจำนวนมาก โดยมีเครือข่ายการส่งกลับทางภาคพื้นดิน และ

ทางอากาศ การประสานงาน และ ความสอดคล้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ควรหลีกเลี่ยงความสับสน หรือ การส่งกลับที่มากเกินความจำเป็น ข้อมูลที่ต้องการในการปฏิบัติงานของกองพลจะรวมสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

- คลื่นความถี่ และ รหัสวิทยุ
- แผนปฏิบัติการ และ ระเบียบปฏิบัติประจำ
- ที่ตั้งของสถานที่บริการทางการแพทย์
- สถานที่ตั้งของจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ และ จุดแลกเปลี่ยนรถยนต์พยาบาล
- เส้นหลักการส่งกำลัง จุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และ อาวุธ และข้อมูลการบังคับบัญชาและการควบคุมห้วงอากาศของกองทัพบก

๒) การรักษาความปลอดภัย

กำลังคุ้มกันจะขึ้นอยู่กับการจัดหน่วยในอัตราจะพบหมวดเสนารักษ์ ในกองพันดำเนินกลยุทธ์สำหรับการปฏิบัติการเริ่มต้น ระดับของการควบคุมสั่งการกำลังป้องกัน (กองพล กองทัพน้อย) กำหนดความรับผิดชอบไว้ในแผนส่งกลับที่ตามมา ในการป้องกันระดับกองทัพน้อย ตัวอย่างโครงสร้างการบริการทางการแพทย์ กองทัพน้อยมีความรับผิดชอบสำหรับการสร้าง และ การส่งกลับทางการแพทย์ ในการสนับสนุนกำลังกองทัพน้อยที่ส่งออกไปในแนวหน้า การใช้จุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บ จุดแลกเปลี่ยน และ การใช้ยานพาหนะที่มิใช่ของหน่วยแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ กำลังป้องกันจะมีความเสี่ยง ผู้ป่วยเจ็บจะมาก ใช้ระยะเวลายาวนาน และ ประสิทธิภาพของการส่งกลับจะขึ้นอยู่กับการใช้ ฮ.พยาบาลของกองทัพน้อย ร่วมในการทำการส่งกลับ

๓) ส่วนหน้า ขนาบข้าง และ ส่วนหลัง กองกำลังเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนการส่งกลับจากชุดส่งกลับที่ขึ้นสมทบ ชุดส่งกลับจะกำหนดจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บไว้ล่วงหน้า โดยจะกำหนดไว้ใกล้กับเส้นทางหลัก หรือจุดที่ใกล้กับการให้บริการทางการแพทย์ การส่งกลับทางอากาศจะกระทำด้วยความรวดเร็ว และมีความอ่อนตัวในการปฏิบัติ

๔) การข้ามแม่น้ำ การบริการทางการแพทย์ในปฏิบัติการนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย การปฏิบัติการข้ามแม่น้ำจะสร้างปัญหาให้กับการบริการทางการแพทย์ การสนับสนุนควรกระทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือ ตามแต่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย

๕) การลาดตระเวน เป็นการตรวจตราหากองกำลังของข้าศึก ในบางครั้งจะทำการทดสอบหาตำแหน่ง และ ความแข็งแกร่งของข้าศึก นอกจากนี้ยังต้องทำการข่าวกรองด้วย โดยปกติกองพลจะมีหน่วยรบหลายๆหน่วย (ขนาดจำกัด) มีกำลังสำรองเพียงพอที่จะส่งออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อทำการค้นหาจุดอ่อนของข้าศึก เทคนิคในการบริการทางการแพทย์ได้บรรยายไว้ในย่อหน้า ๔-๖ก การกำหนดตำแหน่งรถยนต์พยาบาลจะถูกกำหนดไว้ทั้งในระดับหน่วย ระดับกองพล รถพยาบาลจะถูกเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนอย่างเป็นความลับ ระดับชั้นในการจัดรถพยาบาลจะขึ้นกับตำแหน่งที่ข้าศึกจะทำการโจมตีเพราะว่าต้องมีการทดแทนเป็นจำนวนมาก ที่พยาบาลกองพลจะยังไม่จัดขึ้นจนกว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเจ็บมากเพียงพอ ผู้ป่วยเจ็บที่เกิดจากการลาดตระเวนจะถูกส่งกลับจากที่

พยาบาลกองพันไปยังที่พยาบาลกองพลอย่างเร็วที่สุด หรือ ตามแต่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย การใช้ ฮ.พยาบาลจะใช้ในกรณีที่ระยะทางไกลมาก หรือ ไม่สามารถทำการส่งกลับทางพื้นดินได้

๖) การปฏิบัติการร่วม โดยส่วนมากจะพบในการปฏิบัติการร่วม/ นานาชาติ ผู้วางแผนจะต้องกำหนดแผนเริ่มต้น และ กำหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการส่งกลับ ไม่ควรมีการกำหนดแผนซ้ำซ้อนขึ้น ควรมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อทำการส่งกลับเป็นรายบุคคลไปยังประเทศศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน

๒-๘ การส่งกลับทางการแพทย์ในปฏิบัติการดำรงสภาพ

ก. ภาพรวมของการปฏิบัติการ

(๑) การปฏิบัติการนี้จะใช้กำลังทหารที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม การดำเนินการทางการทูต การขัดขวางจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย พวกเขาจะพัฒนาหนทางปฏิบัติและปฏิบัติการกดดันให้รัฐบาลทำการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน การกดดันจะกระทำอย่างระมัดระวังด้วยการจำกัดกำลัง และ ภัยคุกคามของกำลังเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ประเภทของกิจกรรมที่กระทำในปฏิบัติการนี้คือ

- การรักษาสันติภาพ
- ปฏิบัติการทางการทูต
- ต่อสู้กับภัยการก่อการร้าย
- การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพย์ติด
- การอพยพพลเรือน
- การควบคุมอาวุธ
- การช่วยเหลือระดับชาติ และนานาชาติ
- การสนับสนุนการก่อความไม่สงบ
- การสนับสนุนการต่อต้านความไม่สงบ
- แสดงกำลัง

(๒) ขณะที่แต่ละปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีข้อกำหนด ๗ ประการที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการพัฒนาปฏิบัติการ และ ภาพของการปฏิบัติการ มีดังต่อไปนี้

- เน้นที่การคุ้มกัน
- เน้นการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร
- ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆให้มากที่สุด และ ร่วมปฏิบัติการหลายๆชาติ
- แสดงความสามารถในการใช้กำลังโดยปราศจากการข่มขู่
- เข้าใจศักยภาพของผลกระทบจากใช้กำลังเป็นรายบุคคล หรือ กลุ่ม
- เลือกใช้กำลังอย่างเหมาะสม
- มีความเด็ดขาดในการเพิ่มการป้องกัน

ข.การสนับสนุนการส่งกลับทางการแพทย์

(๑) การส่งกลับทางการแพทย์สนับสนุนกำลังที่ส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่การดำรงสภาพจะขึ้นอยู่กับประเภทของการปฏิบัติการ การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า จำนวนของกำลังที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายการส่งกลับในยุทธบริเวณ อัตราการจัดกำลัง ความเสี่ยง ในเกือบทุกสถานการณ์การสนับสนุนการส่งกลับทางการแพทย์จะติดตามกำลังรบ ถ้ามีนโยบายการส่งกลับในเขตยุทธบริเวณสั้นมีอัตรากำลังพลจำกัด และ การรับไว้รักษาพยาบาลจำกัดภายในพื้นที่ปฏิบัติการ หน่วยจัดในอัตราและการสนับสนุนโดยตรง จะได้รับจากจุดที่ได้รับบาดเจ็บมายังที่ให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์ระดับ หนึ่ง และสอง เมื่อผู้ป่วยเจ็บมีอาการคงที่พอที่จะทำการส่งกลับได้

(๒) ระหว่างการส่งกลับหน่วยที่มิใช่หน่วยรบ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ/ป่วย จะได้รับการรักษาจากหน่วยที่มิใช่หน่วยรบ เมื่ออาการคงที่จะทำการส่งกลับโดยหน่วยนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต้องมีการคุ้มกันด้วยกำลังของหน่วยนั้นระหว่างที่ทำการส่งกลับ เจ้าหน้าที่สายแพทย์จะร่วมปฏิบัติการให้การดูแลผู้ป่วยเจ็บระหว่างทางที่ทำการส่งต่อไปยังสถานที่ให้การรักษาพยาบาลต่อไป

(๓) ระหว่างการต่อสู้กับภัยการก่อการร้าย ข้อพิจารณาในการวางแผนสำหรับการส่งกลับทางการแพทย์มีดังนี้

- การใช้กำลังพลสายแพทย์ และ ที่มิใช่สายแพทย์ในการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บในสถานการณ์ผู้ป่วยเจ็บเป็นกลุ่มก้อน ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ของหน่วยที่มิใช่สายแพทย์ควรมีการวางแผนมีเจ้าหน้าที่สายแพทย์ในระหว่างที่ทำการส่งกลับระหว่างทาง

- การส่งกลับภายใต้การปฏิบัติการของข้าศึก หรือ ภูมิประเทศที่แย่ หรือต่ำกว่าระดับพื้นดิน (อ้างในย่อหน้า ๕-๑๐)

- การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย (สร้างจุดตรวจ ตรวจสอบบุคคล และ อุปกรณ์เบื้องต้น จำกัดพื้นที่ในสถานที่ให้การรักษาพยาบาล)

(๔) การให้ความช่วยเหลือระดับชาติ และ การสนับสนุนการก่อความไม่สงบ และ การสนับสนุนการต่อต้านความไม่สงบ การส่งกลับทางการแพทย์อาจจะต้องทำการร้องขอความช่วยเหลือจากชาติอื่นๆ กลุ่มองค์กรอื่นๆ ในการให้การดูแลรักษา เพื่อให้การสนับสนุนตั้งแต่จุดที่ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งถึงสถานที่ให้การรักษาพยาบาล

๒-๙ แผนส่งกลับทางการแพทย์

แผนการส่งกลับทางการแพทย์ที่ครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งกลับทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้บาดเจ็บทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บและป่วยในพื้นที่ปฏิบัติการ แผนการส่งกลับทางการแพทย์ของกองทัพบกจะมาจากคำแนะนำและเจตนาของผู้บัญชาการรบ รวมถึงภารกิจและภารกิจทั้งหมดที่กำกับโดยผู้บัญชาการ จะสำเร็จและตรงกับการสนับสนุนการส่งกลับทางการแพทย์และหน่วยสนับสนุน ในบางสถานการณ์กองทัพอากาศและหน่วยส่งกลับบนพื้นดินอาจได้รับการสนับสนุนเพื่อให้บริการของหน่วยรอง กองกำลังนานาชาติและกองกำลังของประเทศเจ้าภาพ

หากได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา อาจมีการมอบหมายทรัพยากรเพื่อการส่งกลับทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกองกำลังทหารอื่นๆ ภารกิจสนับสนุนเพิ่มเติมเหล่านี้ จะได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในแผนและคำสั่งยุทธการ แพทย์ใหญ่ในเขตยุทธบริเวณ พร้อมด้วยคำแนะนำของผู้วางแผนการส่งกลับทางการแพทย์ระดับสูงจะประสานงาน และทำให้การสนับสนุนเหล่านี้สอดคล้องกับผู้บังคับบัญชาหน่วยรบ เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๓
การส่งกลับด้วยมือ

๓-๑ กล่าวทั่วไป

การส่งกลับด้วยมือ เป็นขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บด้วยมือ เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องใช้เปลหรือการเคลื่อนย้ายด้วยวิธีการอื่นๆในการส่งกลับ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายด้วยวิธีการอื่นๆ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บด้วยวิธีนี้จะสิ้นสุดลง ยกตัวอย่างเช่น การส่งกลับด้วยมือจะสิ้นสุดลงเมื่อสามารถใช้ เปล ยานพาหนะ ยวดยานต่างๆ

๓-๒ การอุ้ม

ก. การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บด้วยการใช้มือเปล่าจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการอุ้ม การอุ้มด้วยท่าที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บได้รับการบาดเจ็บมากขึ้น ควรจะมีการจัดเตรียมหน่วยงาน และ ทำอย่างเป็นระบบ ในทุกขั้นตอนของการเคลื่อนย้าย การยก หรือ การเคลื่อนที่ผู้ป่วยเจ็บต้องทำด้วยความนุ่มนวลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ป่วยเจ็บไม่ควรจะถูกเคลื่อนย้ายก่อนที่จะมีการประเมินอาการ และ ต้องให้การปฐมพยาบาลก่อน (การช่วยตัวเอง เพื่อนช่วยเพื่อน หรือ การใช้นายสิบกู้ชีพ) และ การให้การรักษาพยาบาลอย่างฉุกเฉินจากนายสิบพยาบาล

หมายเหตุ *ข้อยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัย เช่น มีผู้ป่วยเจ็บอยู่บนพื้นใกล้กับรถที่กำลังเกิดไฟไหม้ อาจมีความจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยเจ็บออกไปให้ห่างจากยานพาหนะ ในสถานการณ์เช่นนี้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บออกไปเพื่อทำการปฐมพยาบาล หรือ ให้การพยาบาลอย่างฉุกเฉิน แต่เป็นการเคลื่อนย้ายเพียงเพื่อให้ห่างจากพื้นที่ที่เป็นอันตราย*

ข. มาตรการในการช่วยชีวิต จะกระทำก่อนที่จะมีการส่งกลับ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน จะมีการประเมินประเภทของการบาดเจ็บก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้าย โดยมีการตรวจสิ่งต่างๆ ดังนี้

- การเปิดทางเดินหายใจ การรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจ
- การห้ามเลือด
- การป้องกัน และควบคุมการช็อค
- การปกป้องบาดแผลจากการปนเปื้อน

ค. เมื่อสงสัยว่ามีกระดูกหัก ควรทำการเข้าเฝือก ต้องมีความระมัดระวังกระดูกที่แตก หรือร้าวนั้นจะไปทิ่ม หรือ ตัด กล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาท หรือ ผิวหนัง

ง. เมื่อผู้ป่วยเจ็บมีบาดแผลที่รุนแรง ต้องทำการตกแต่งแผลก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยมือ

๓-๓ กฎทั่วไปของการใช้ผู้อุ้ม

ก. การส่งกลับด้วยมือเปล่า ผู้ป่วยเจ็บแต่ละคนจะถูกส่งต่อด้วยการใช้ผู้อุ้ม การอุ้มด้วยท่าที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นผลให้ผู้ป่วยเจ็บได้รับการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการบาดเจ็บ การตึงของกล้ามเนื้อ การเคล็ดขัดยอก ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการส่งกลับ ควรปฏิบัติตามกฎดังนี้

- ใช้ร่างกายในการยก ในระดับที่เหมาะสม ขณะเคลื่อนย้าย
- รู้ขีดความสามารถและ ข้อจำกัดของร่างกายตนเอง
- รักษาความมั่นคงของการก้าวเท้าเมื่อทำการยก และ ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ
- เมื่อมีการยกของจากที่ต่ำกว่าใช้กล้ามเนื้อขา (อย่าใช้กล้ามเนื้อหลัง)
- การใช้กล้ามเนื้อ ไหล่ และ ขา (ไม่ใช้หลัง) เมื่อยก และ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ หรือ การประคองในท่ายืน
- รักษาหลังให้ตรง ใช้แขน และ ไหล่ ดึงผู้ป่วยเจ็บ
- ผู้อุ้มควรทำการยกโดยพร้อมเพรียงกัน และ ทำการเคลื่อนย้ายอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- เมื่อต้องทำการเคลื่อนย้ายของหนัก ใช้การผลัก หรือ การม้วน แทนที่การยก
- ในขณะที่ทำการขนส่งผู้ป่วยเจ็บ พักให้บ่อยเท่าที่ต้องการ หรือ เท่าที่เป็นไปได้

ข. โดยทั่วไป อาวุธของผู้ป่วยเจ็บจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปกับสายการส่งกลับ อาวุธจะถูกส่งไปที่พยาบาลกองพัน หรือ ที่พยาบาลกองพล เพื่อส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดผ่านไปตามสายการส่งกำลังบำรุง อุปกรณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันสารพิษ จะยังคงติดตัวผู้ป่วยเจ็บไป

๓-๔ การอุ้มด้วยมือ

การอุ้มด้วยมือของผู้อุ้ม อาจจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บได้รับการบาดเจ็บมากขึ้น ในบางกรณี มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาชีวิตผู้ป่วยเจ็บ เมื่อไม่สามารถหาเปลได้ หรือ ในสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่ทำให้การขนส่งด้วยวิธีอื่นไม่สามารถทำได้ การทำการขนส่งด้วยผู้อุ้มอาจจะเป็นหนทางเดียวที่ทำเพื่อการส่งผู้ป่วยเจ็บ ไปยังนายสิบพยาบาลเพื่อทำการรักษาพยาบาล ระยะทางในการขนส่งด้วยผู้อุ้มจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้

- ความแข็งแรง ทนทานของผู้อุ้ม
- น้ำหนักของผู้ป่วยเจ็บ
- ประเภทของการบาดเจ็บ
- สิ่งกีดขวางในระหว่างการเคลื่อนย้าย

๓-๕ ตำแหน่งของผู้ป่วยเจ็บ

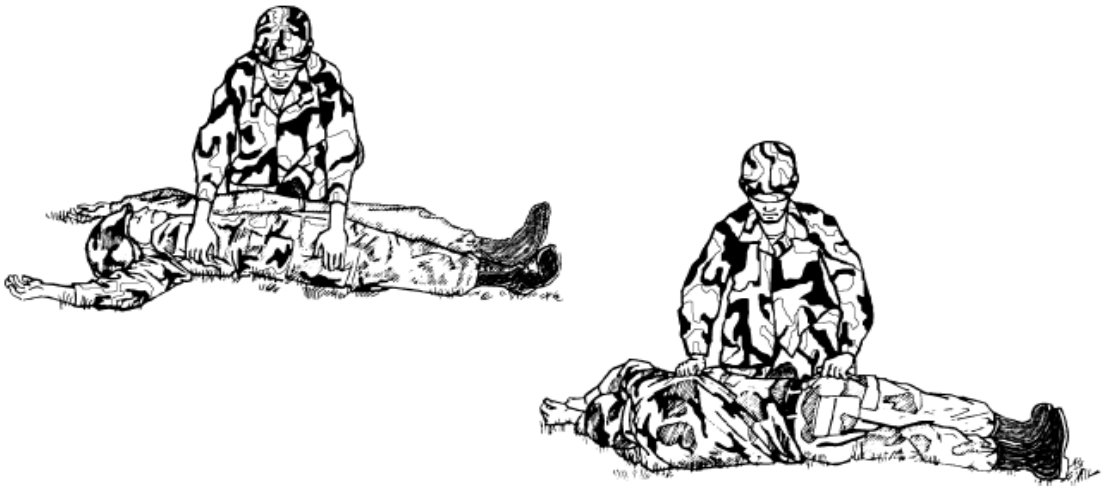
ในขั้นแรกของการอุ้มด้วยมือคือ ตำแหน่งของการยกผู้ป่วยเจ็บ ถ้าผู้ป่วยมีสติควรบอกให้ผู้ป่วยเจ็บทราบถึงท่าทาง และ การเคลื่อนย้าย เพื่อลดความรู้สึกหวาดกลัวได้ และ ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเจ็บ อาจจะมีความจำเป็นต้องพลิกตัวในการนอนคว่ำหรือหงาย

ก. การพลิกตัวผู้ป่วยเจ็บให้นอนคว่ำ ผู้อุ้มคุกเข่าที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บ

(๑) วางแขนผู้ป่วยเจ็บไว้เหนือศีรษะ จับข้อเท้าข้างที่อยู่ห่างจากตัวม้วนพลิกเข้ามาหาตัว

(๒) วางแขนไว้บนที่ไหล่ข้างที่ห่างจากตัว ส่วนมืออีกข้างวางไว้ที่สะโพก หรือ ต้นขาของผู้ป่วยเจ็บ

(๓) ทำการพลิกอย่างนุ่มนวลให้ผู้ป่วยนอนคว่ำที่ ตามภาพที่ ๓-๑



ภาพที่ ๓-๑ การจัดท่าผู้ป่วยเจ็บด้านหน้าท้อง

ข. พลิกผู้ป่วยเจ็บตามขั้นตอน ก. หลังจากนั้นจัดท่าด้านหลังผู้ป่วยเจ็บ

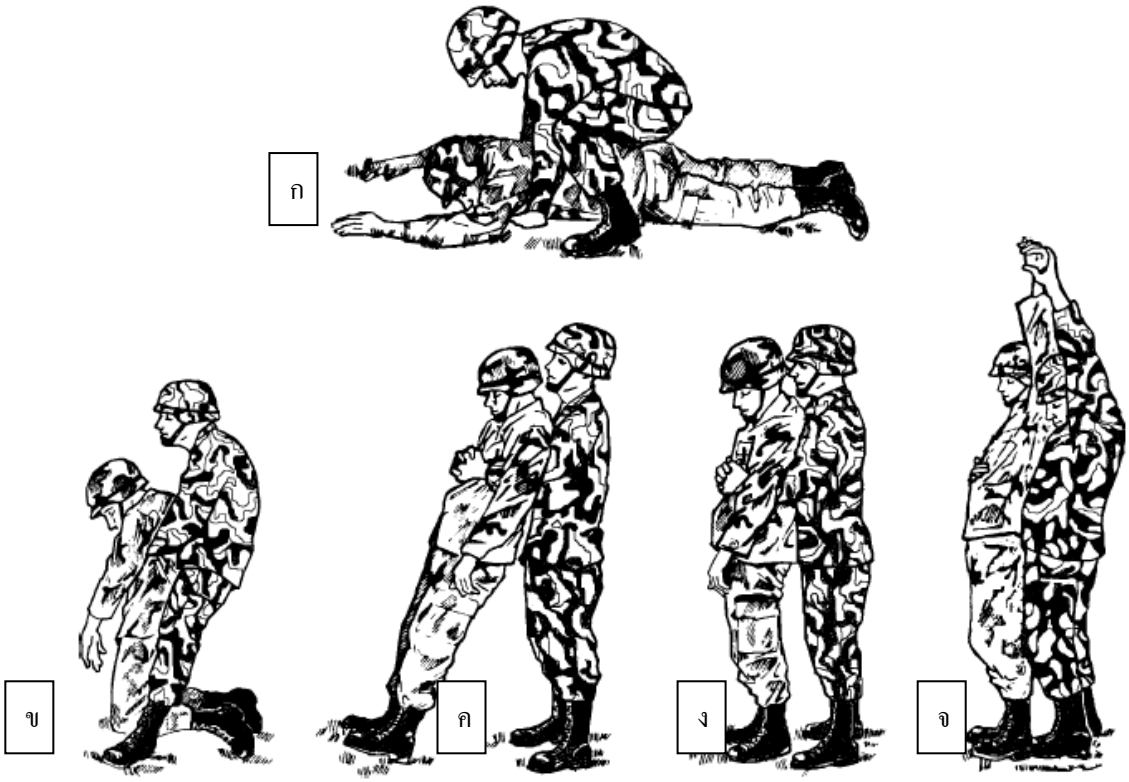


ภาพที่ ๓-๒ การจัดท่าด้านหลังผู้ป่วยเจ็บ

๓-๖ ประเภทของการอุ้มด้วยมือเปล่า

ก. การอุ้มด้วยคนคนเดียว (อุ้มเดี่ยว) ใช้เมื่อมีผู้อุ้มเพียงคนเดียว สามารถทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ

(๑) อุ้มแบก ตามภาพที่ ๓-๓ เป็นการอุ้มด้วยคนๆเดียว ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเคลื่อนย้าย หลังจากที่ทำการจัดท่าของผู้ป่วยเจ็บที่หมดสติตามภาพที่ ๓-๑ แล้ว จึงทำการยกขึ้นจากพื้นและประคองในท่าต่างๆ



(ก) หลังจากจัดท่าให้ผู้ป่วยเจ็บนอนคว่ำแล้ว ผู้อุ้มนั่งคร่อมตัวผู้ป่วยเจ็บ สอดมือเข้าไปใต้หน้าอก และจับมือทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกัน

(ข) ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นมาในท่าคุกเข่า คล้ายกับการเคลื่อนไปข้างหลัง

(ค) ค่อยยกตัวผู้ป่วยขึ้นจนขาเหยียดตรง และ ทำการล็อกเข่าไว้

(ง) เดินไปข้างหน้า ให้ผู้ป่วยเจ็บอยู่ในตำแหน่งยืน เอนตัวผู้ป่วยเจ็บไปทางด้านหลังเพียงเล็กน้อย

(จ) ประคองผู้ป่วยเจ็บไว้ในอ้อมแขน ส่วนแขนข้างที่เหลือใช้จับที่ข้อมือของผู้ป่วยเจ็บยกแขนของผู้ป่วยเจ็บให้สูงไว้เหนือศีรษะของผู้อุ้มลอดผ่านใต้วงแขนของผู้ป่วยเจ็บ

(ฉ) หมุนตัวเองอย่างรวดเร็ว หันหน้าเข้าหาผู้ป่วยเจ็บ และ สอดแขนไว้ใต้เอวของผู้ป่วยเจ็บนำตัวของผู้ป่วยเจ็บผ่านขึ้นบนไหล่ ในระหว่างนั้นให้สอดแขนไว้ที่ระหว่างขาของผู้ป่วยเจ็บ

(ช) จับที่เอวของผู้ป่วยเจ็บ และ ยกแขนให้สูงผ่านศีรษะของผู้อุ้ม

(ช) ก้มตัวลง และ ดึงแขนของผู้ป่วยเจ็บ อยู่ให้อยู่บน และ ล่างของไหล่ นำลำตัวของผู้ป่วยเจ็บผ่านไหล่ของผู้อุ้ม ในขณะเดียวกันสอดแขนไว้ที่ระหว่างขาของผู้ป่วยเจ็บ



ภาพ ๓-๓ ท่าอุ้มแบก (ต่อ)

(ด) จับที่ข้อมือของผู้ป่วยเจ็บด้วยมือหนึ่งข้าง และ วางมืออีกข้างหนึ่งที่เข่าเพื่อการประคอง

(ต) ยกลำตัวของผู้ป่วยเจ็บให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มืออีกข้างจะว่างสามารถใช้งานอย่างอื่นได้

(๒) ท่ายกตัวผู้ป่วยเจ็บจากพื้น อีกวิธีตามที่แสดงในภาพ ๓-๔ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาว่าผู้ป่วยเจ็บปลอดภัยจากการอุ้มนี้ ตามลักษณะและตำแหน่งของบาดแผล ผู้ป่วยเจ็บต้องได้รับการดูแลอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ ในขั้นตอนการยกจากพื้น ไม่ว่าจะเป็นการอุ้มด้วยคนคนเดียวหรือ อุ้มแบก



ภาพ ๓-๔ วิธียกตัวผู้ป่วยเจ็บขึ้นจากพื้น

(ก) ผู้อุ้มคุกเข่าข้างเดียวลงข้างๆศีรษะของผู้ป่วยเจ็บหันหน้าไปทางปลายเท้า สอดมือเข้าไปใต้รักแร้ เลื่อนต่ำลง และ เมื่อพาดอยู่ที่กลางหลัง

(ข) ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่ในท่าคุกเข่า ตรวจความเรียบร้อยส่วนล่างแล้วจึงทำการยกผู้ป่วยเจ็บให้อยู่ในท่ายืนและทำการล็อกเข่าไว้

(๓) อุ้มพยุง (ตามภาพ ๓-๕) ท่าอุ้มแบบนี้ผู้ป่วยเจ็บต้องสามารถเดินได้ หรือ พยุงได้ด้วยขาอีกหนึ่งข้าง โดยใช้ผู้อุ้มคล้ายกับการประคอง การอุ้มแบบนี้อาจจะใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บในระยะทางไกลได้เท่าที่ผู้ป่วยเจ็บสามารถเดิน หรือ พยุงตนเองได้



ภาพ ๓-๕ ท่าอุ้มพยุง



ภาพ ๓-๖ อุ้มกอดหน้า

(ก) ยกผู้ป่วยเจ็บจากพื้น ให้อยู่ในตำแหน่งท่ายืน โดยการอุ้มแบก

(ข)จับข้อมือและยกแขนของผู้ป่วยเจ็บและพาดอ้อมไปทางด้านหลังลำคอของผู้อุ้ม

(ค) โอบเอวของผู้ป่วยเจ็บไว้เพื่อพยุงให้ผู้ป่วยเจ็บสามารถเดิน หรือ ประคองตนเองได้โดยมีผู้อุ้มเป็นเครื่องพยุง

(๔) อุ้มกอดหน้า ตามภาพ ๓-๖ ใช้ได้ดีในการอุ้มผู้ป่วยเจ็บในระยะทางสั้นๆ ประมาณ ๕๐ เมตร ก่อนนำไปวางไว้บนเปล

(ก) ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นมากจากพื้นในท่ายืน ให้เหมือนกับวิธีการอุ้มแบก

(ข) สอดแขนข้างหนึ่งที่ใต้รักแร้ของผู้ป่วยเจ็บ และ แขนอีกข้างอยู่ที่ด้านหลัง

(ค) ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้น

(ง) ยกผู้ป่วยเจ็บให้สูงระดับอกขึ้นเพื่อลดความเมื่อยล้า

(๕) อุ้มกอดหลังใช้เฉพาะผู้ป่วยเจ็บที่รู้สึกตัวดีเท่านั้น ตามภาพ ๓-๗ เพราะว่าผู้ป่วยต้องช่วยจับที่หลังของผู้อุ้ม ตามขั้นตอนดังนี้



ภาพ ๓-๗ ท่าอุ้มกอดหลัง

(ก) ยกผู้ป่วยเจ็บให้อยู่ในท่ายืน ให้เหมือนกับวิธีการอุ้มแบก

(ข) ใช้แขนโอบประคองรอบเอวของผู้ป่วยเจ็บให้ผู้ป่วยเจ็บใช้แขนโอบที่รอบคอของผู้อุ้ม แล้วค่อยๆเคลื่อนตัวมาอยู่ด้านหน้า

(ค) แขนของผู้ป่วยเจ็บโอบข้ามไหล่ทั้งสองข้างผู้อุ้มอย่างหลวมๆ

(ง) โน้มตัวไปข้างหน้า ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่บนหลังของผู้อุ้ม และ ผู้อุ้มสอดมือไปกอดต้นขาของผู้ป่วยเจ็บไว้

(๖) อุ้มทาบหลัง ตามภาพ ๓-๘ ท่าอุ้มนี้น้ำหนักของผู้ป่วยส่วนที่เหลืออยู่อยู่บนหลังของผู้อุ้ม ให้ง่ายในการเคลื่อนที่ ในระยะทางใกล้ๆ (๕๐ ถึง ๓๐๐ เมตร) เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่แขนของผู้ป่วยเจ็บ ผู้อุ้มควรจับมือผู้ป่วยไว้ที่ในท่าที่ปล่อยให้แขนลงมา



ภาพ ๓-๘ อุ้มทาบหลัง

(ก) ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นจากพื้น ในท่ายืน คล้ายกับการอุ้มแบก

(ข) ใช้แขนประคองรอบๆตัวผู้ป่วยเจ็บ และ จับที่ข้อมือผู้ป่วยเจ็บไว้ใกล้กับตัวเรา

(ค) ยกมือผู้ป่วยขึ้นให้อยู่เหนือศีรษะของผู้อุ้ม ให้แขนพาดผ่านไหล่ทั้งสองข้างของผู้อุ้ม

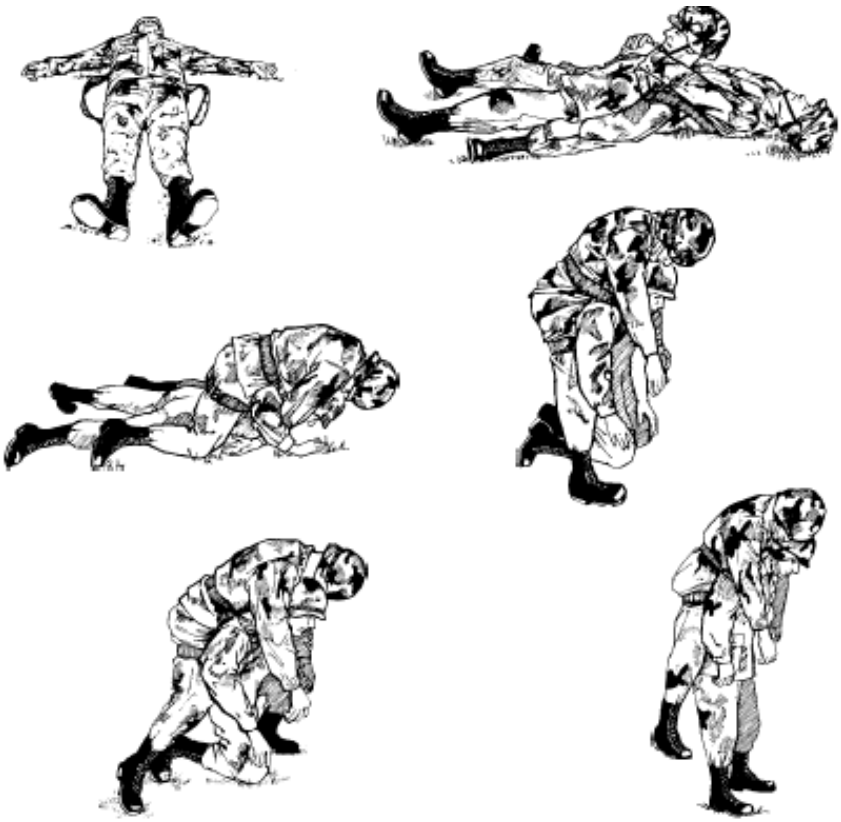
(ง) เคลื่อนไปข้างหน้า ในขณะที่ยังคงประคองน้ำหนักให้อยู่บนหลัง

(จ) จับที่แขนอีกข้างหนึ่งและ วางไว้ที่ไหล่ของผู้อุ้ม

(ฉ) โน้มไปข้างหน้า และ ยก ผู้ป่วยเจ็บที่อยู่บนหลังให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้น้ำหนักอยู่บนหลังของผู้อุ้ม

หมายเหตุ *เมื่อยกผู้ป่วยเจ็บในท่ายืนบนหลังของผู้อุ้ม ผู้อุ้มจะต้องยืนให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้การป้องกันอาการตึงกล้ามเนื้อ หรือ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่หลัง*

(๗) อุ้มด้วยเข็มขัดปืนพก ตามภาพ ๓-๙ เป็นท่าที่ดีที่สุดสำหรับการอุ้มด้วยคนๆเดียวในระยะทางไกล มากกว่า ๓๐๐ เมตร ผู้ป่วยเจ็บจะได้รับการประคองให้อยู่บนไหลโดยการใช้เข็มขัด มือทั้งสองข้างของผู้อุ้ม และ มือของผู้ป่วยเจ็บ (ที่รู้สึกตัวดี) ใช้ในการจับอาวุธ หรือ ปืนป่ายข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง และจับ หรือ สามารถคลานผ่านพุ่มไม้เตี้ยได้โดยผู้ป่วยเจ็บอยู่ในท่าปลอดภัย



ภาพ ๓-๙ อุ้มด้วยเข็มขัดปืน

ก) ต่อเข็มขัดสองเส้นเข้าไว้ด้วยกัน (หรือถ้าจำเป็นอาจใช้สามเส้น) โดยทำเป็นห่วง วางสายไว้ใต้ต้นขา และ ส่วนหลัง ให้ห่วงออกมาด้านนอกข้างลำตัว

หมายเหตุ *ถ้าไม่มีเข็มขัดรัดอาจใช้สายอื่นๆ เช่น สายสะพายปืน สายรัดเปล หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม*

ข) จัดให้ผู้ป่วยเจ็บนอนหงาย กางขาออก สอดแขนผ่านห่วง จับมือของผู้ป่วยเจ็บและขากางเกงข้างที่บาดเจ็บไว้

ค) ผู้อุ้มพลิกตัวไปที่ด้านข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ ของผู้ป่วยเจ็บในท่านอนคว่ำ พลิกตัวของผู้ป่วยเจ็บขึ้นอยู่บนหลัง แล้วปรับสายรัด (ถ้าจำเป็น)

ง) ผู้อุ้มยกตัวขึ้นในท่าคุกเข่า สายรัดหรือเข็มขัดจะรัดตัวผู้ป่วยเจ็บอยู่บนหลังผู้อุ้ม

จ) ผู้อุ้มวางมือข้างหนึ่งลงบนเข่า เพื่อประคองตัวและ ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่ในท่ายืน (ผู้ป่วยเจ็บจะได้รับการประคองอยู่บนไหล่ของผู้อุ้ม)

ฉ) ผู้อุ้มสามารถอุ้มผู้ป่วยเจ็บโดยมือทั้งสองข้างสามารถ ใช้ในการปีนป่าย หรือ ข้ามสิ่งกีดขวาง

(๘) อุ้มลากด้วยเข็มขัดปืน ตามภาพ ๓-๑๐ เช่นเดียวกับการลากอื่นๆ โดยทั่วไป ใช้สำหรับระยะทางสั้นๆ (๕๐) เมตร การลากด้วยวิธีนี้จะเป็นประโยชน์ในสนามรบ เนื่องจากผู้ลาก และ ผู้ป่วยเจ็บยังคงอยู่ บนพื้นด้วยกันมากกว่าการลากด้วยวิธีอื่นๆ



ภาพ ๓-๑๐ อุ้มลากด้วยเข็มขัดปืน

ก) ขยายสายรัด หรือ วัสดุที่คล้ายกัน ให้ได้ความยาวมากที่สุด และผูกต่อเข้าด้วยกัน เพื่อทำเป็นห่วง

ข) จัดท่าให้ผู้ป่วยเจ็บนอนหงาย ให้เหมือนกับการอุ้มแบก

ค) สอดห่วงทางศีรษะของผู้ป่วยเจ็บ และ เลื่อนห่วงให้พาดขวางบนอกและใต้รักแร้ของผู้ป่วยเจ็บบิดห่วงที่เหลือเป็นรูปเลขแปด

ง) นอนคว่ำลงข้างๆโดยหันหน้าเข้าหาผู้ป่วยเจ็บ

จ) เลื่อนห่วงผ่านศีรษะของผู้อุ้มไปใต้แขน และ ช่วงท้อง ซึ่งจะทำให้สามารถลากตัวผู้ป่วยเจ็บได้ในขณะที่ผู้อุ้มทำการคลาน

(๙) อุ้มลากด้วยคอ (ตามภาพ ๓-๑๑) เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์มากในสนามรบ เพราะว่าผู้อุ้มสามารถทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บได้เสมือนกำลังคลานอยู่ข้างหลังกำแพงต่ำ พุ่มไม้เตี้ย ใต้ยานพาหนะ หรือ ผ่านท่ออุโมงค์ ถ้าผู้ป่วยหมดสติ ต้องระวังให้ศีรษะยกสูงจากพื้น การลากด้วยวิธีนี้ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยเจ็บแขนหัก



ภาพ ๓-๑๑ อุ้มลากด้วยคอ

หมายเหตุ *ถ้าผู้ป่วยเจ็บรู้สึกตัวดี ให้ใช้แขนทั้งสองข้างโอบรอบคอผู้อุ้มไว้*

ก) ผูกบริเวณข้อมือทั้งสองข้างของผู้ป่วยเจ็บไว้

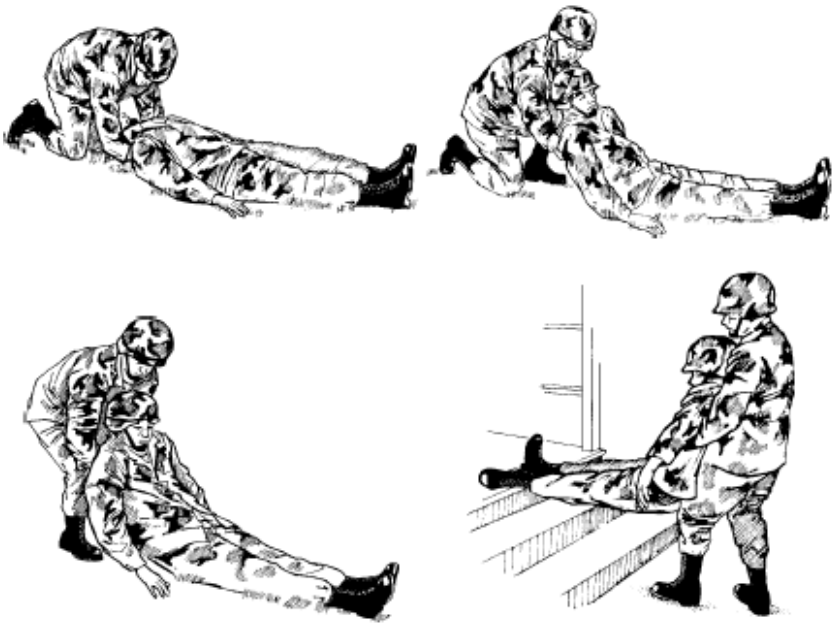
ข) ผู้อุ้มถ่างขาคร่อมตัวผู้ป่วยไว้หันหน้าเข้าหากัน

ค) จับมือผู้ป่วยเจ็บไว้ให้เป็นห่วง คล้องไว้กับที่คอของผู้อุ้ม

ง) ผู้อุ้มคลานไปข้างหน้าพร้อมกับลากตัว ผู้ป่วยเจ็บ

หมายเหตุ *ถ้าผู้ป่วยเจ็บหมดสติ ระวังศีรษะให้สูงจากพื้น*

(๑๐) อุ้มลากด้วยมือ (ตามภาพ ๓-๑๒) วิธีนี้จะเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บในทิศทางขึ้นหรือ ลงบันได



ภาพ ๓-๑๒ อุ้มลากด้วยมือ

ก) คุกเข่าลงที่ด้านศีรษะของผู้ป่วยเจ็บ(ผู้ป่วยเจ็บนอนหงาย) ผู้อุ้มหงายฝ่ามือขึ้นแล้วสอดเข้าไปใต้ไหล่ของผู้ป่วยเจ็บ และ จับไว้ให้แน่น

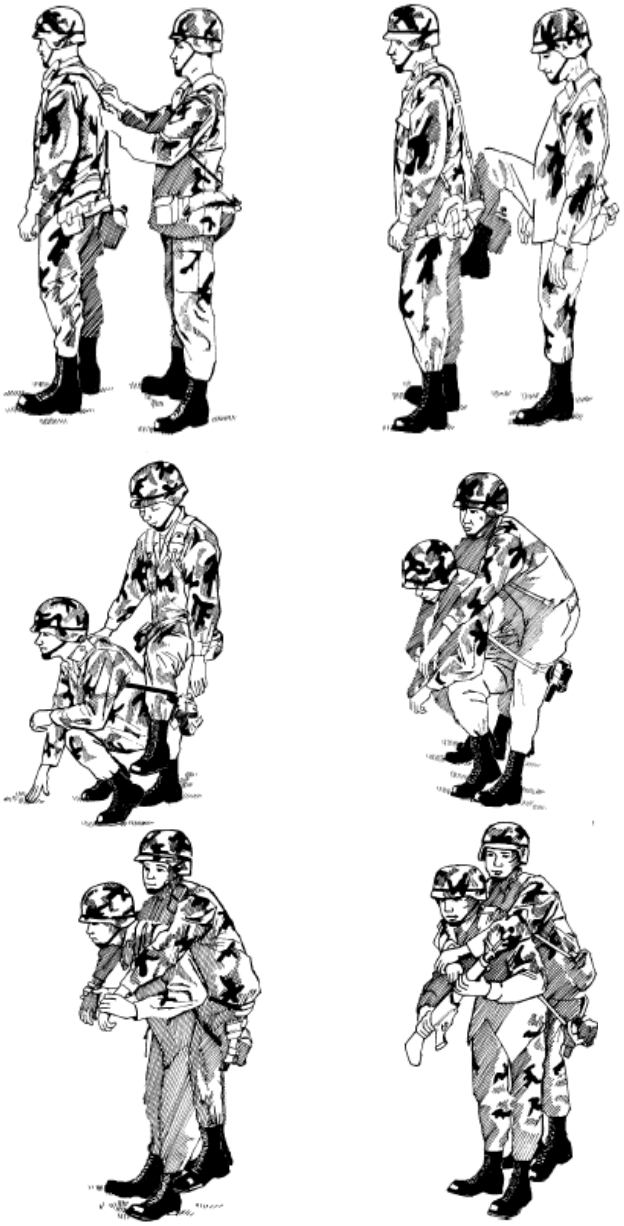
ข) ยกขึ้นเล็กน้อย ประคองศีรษะส่วนหัวของผู้ป่วยเจ็บไว้ด้วยแขน ข้างหนึ่งของผู้อุ้มหรือให้ข้อศอกข้อศอกชิดกันช่วยรองศีรษะของผู้ป่วยเจ็บไว้บนแขนของผู้อุ้ม

ค) ยก และ ลากผู้ป่วยเจ็บไปข้างหลัง (ผู้ป่วยเจ็บอยู่ในท่ากึ่งนั่ง)

ง) ถอยหลังมาหนึ่งก้าว ประคองศีรษะ และ ส่วนลำตัวของผู้ป่วยเจ็บปล่อยให้สะโพก และ ขาค่อยๆหล่นลงมาที่ละขั้น

หมายเหตุ *ถ้าต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บขึ้นข้างบน ควรหันหลังขึ้นบันได และใช้ขั้นตอนเดียวกัน*

(๑๑) การใช้สายโยงบ่า จะใช้ในกรณีผู้ป่วยมีสติ (ตามภาพ ๓-๑๓)



ก) ปลดอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากสายโยงบ่า
ข) สอดขาของผู้ป่วยเจ็บข้างหนึ่งลงในห่วงของสายโยงบ่าของผู้อุ้ม
ค) คุกเข่าลงข้างหน้าผู้ป่วยเจ็บ และให้ผู้ป่วยเจ็บสอดขาอีกข้างลงในห่วง
ง) ผู้ป่วยเจ็บวางแขนพาดลงบนไหล่ของผู้อุ้มโน้มตัวไปข้างหน้าบนหลังของผู้อุ้ม และ จับมือไว้ด้วยกัน
จ) ผู้อุ้มยืนขึ้นและเอียงตัวไปข้างหน้าในท่าที่สบาย
ฉ. ปฏิบัติภารกิจต่อไป

ภาพ ๓-๑๓ การอุ้มแบกด้วยสายโยงบ่า

(๑๒) การใช้ สายโยงบ่า กับผู้ป่วยหมดสติ/ผู้ที่ไม่สามารถยืนได้ (ตามภาพ ๓-๑๔)

ก) ให้ผู้ป่วยเจ็บนอนราบบนพื้นเรียบ

ข) ปลดสายโยงบ่า ขยายสายรัด

ค) ยกขาของผู้ป่วยเจ็บ วางสอดไปในห่วงซึ่งเตรียมไว้ ทีละข้าง เลื่อนสายโยงบ่าขึ้นจนกระทั่งสายรัดที่อยู่ต้นขาของผู้ป่วยเจ็บ

ง) ผู้อุ้มนอนลงระหว่างขาของผู้ป่วยเจ็บ สอดแขนแต่ละข้างเข้ากับสายโยงบ่า

จ) จับมือของผู้ป่วยเจ็บข้างที่บาดเจ็บ และพลิกตัวผู้ป่วยเจ็บไปทางด้านที่ไม่ได้บาดเจ็บ

ฉ) ยกเข่าขึ้นข้างหนึ่ง และ ลุกขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งยืน

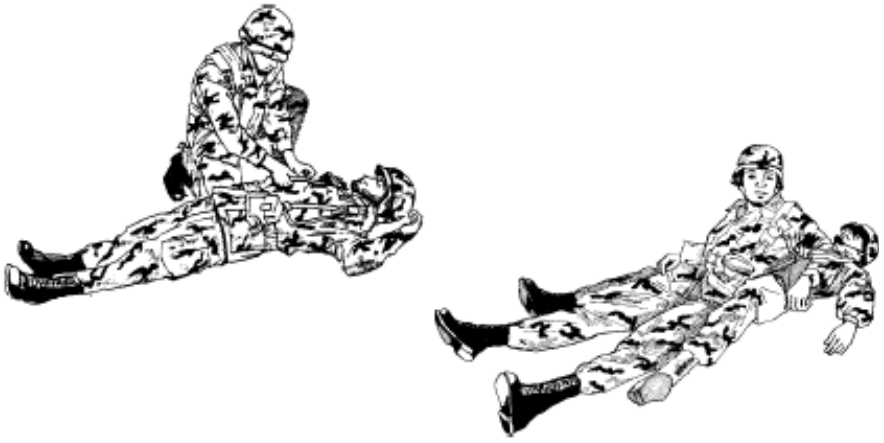
ช) วางแขนผู้ป่วยเจ็บพาดอยู่บนไหล่ของผู้อุ้ม จับมือของผู้ป่วยเจ็บไว้และประคองผู้ป่วยปลอดภัยในกรณีที่ผู้ป่วยหมด สำหรับผู้ป่วยเจ็บที่รู้สึกตัวดี และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปล่อยให้ผู้ป่วยเจ็บประสานมือ และ วางไว้ที่ข้างหน้าของผู้อุ้ม

ซ. ผู้อุ้มโน้มตัวไปข้างหน้า ในตำแหน่งที่สบาย และปฏิบัติภารกิจต่อไป

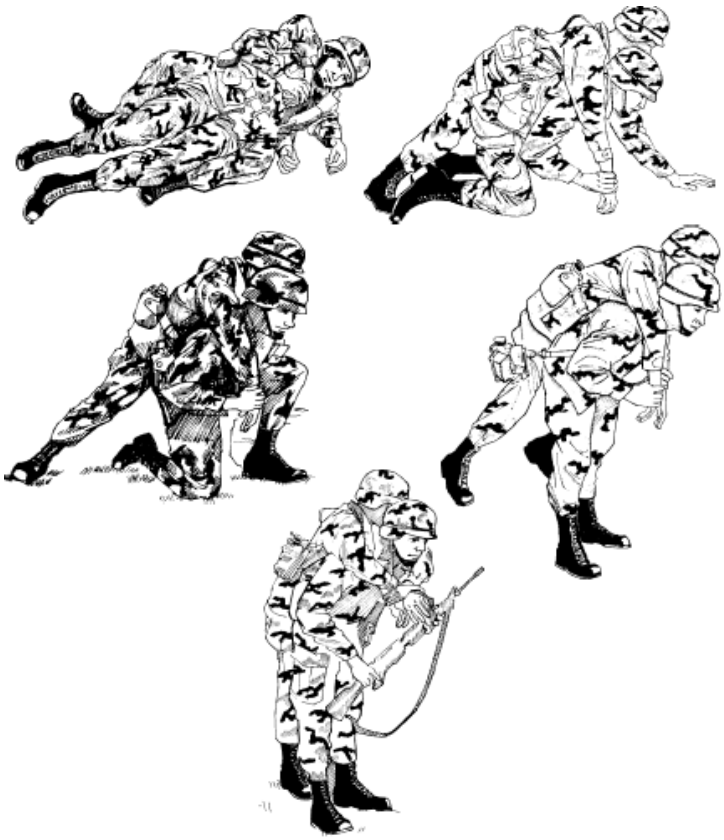


ภาพ ๓-๑๔ อุ้มแบกด้วยสายโยงบ่า (ผู้ป่วยหมดสติ)

(๑๓) การใช้สายโยงบ่าของผู้ป่วยเจ็บ (ตามภาพ ๓-๑๕) สามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเจ็บที่มีสติและ หมดสติ



ภาพ ๓-๑๕ อุ้มแบกด้วยสายโยงบ่า



ภาพ ๓-๑๕ อุ้มแบกด้วยสายโยงบ่า

ก) ให้ผู้ป่วยเจ็บไว้นอนหงาย ขณะที่ยังใส่สายโยงอยู่

ข) คลายสายโยงบ่าด้านหน้าของผู้ป่วยเจ็บ

ค) ผู้อุ้มนอนลงระหว่างขาของผู้ป่วยเจ็บสอดแขนเข้าในสายโย่งบ่าด้านหน้าของผู้ป่วยเจ็บ

ง) จับแขนของผู้ป่วยเจ็บออกจากสายโยงบ่า

จ) จับมือผู้ป่วยเจ็บข้างที่ได้รับบาดเจ็บจับตัวผู้ป่วยพลิกคว่ำโดยพลิกข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ

ฉ) คุกเข่าขึ้นหนึ่งข้าง แล้วจึงขยับเป็นท่ายืน

ช) จับมือผู้ป่วยเจ็บไว้ และ ประคองให้ผู้ป่วยปลอดภัยในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติ ผู้ป่วยมีสติ ให้ผู้ป่วยจับมือไว้ในทางด้านหน้าของผู้อุ้ม

ซ. โน้มตัวไปข้างหน้าให้อยู่ในท่าที่สบาย และ ปฏิบัติภารกิจต่อไป

ข. การอุ้มด้วยคนสองคน (อุ้มคู่)

ควรใช้เมื่อสามารถทำได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยเจ็บ และเป็นการทำให้ผู้อุ้มเหนื่อยน้อยลง มีวิธีการอุ้มที่แตกต่างกัน ๕ วิธี

(๑) การใช้คนสองคนช่วยประคอง (ตามภาพ ๓-๑๖) สามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยมีสติ และ หมดสติ ถ้าผู้ป่วยเจ็บสูงกว่าผู้อุ้มอาจจะต้องยกขาของผู้ป่วยเจ็บขึ้น และ ให้ผู้ป่วยเจ็บนั่งลงบนท่อนแขนของผู้อุ้ม มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้



ภาพ ๓-๑๖ อุ้มคู่พยุง

ก. ช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บยืน และ ใช้แขนประคองโดยโอบรอบเอวไว้

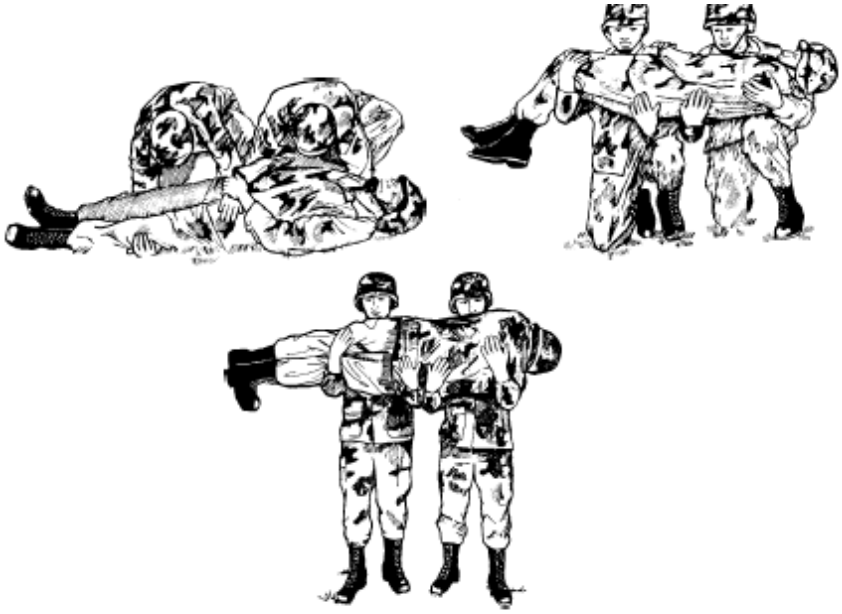
ข. จับข้อมือผู้ป่วยเจ็บโอบรอบไหล่ คอ ของผู้อุ้ม

(๒) การอุ้มด้วยแขนสองคน (ตามภาพ ๓-๑๗) จะเป็นประโยชน์มาก สำหรับการเคลื่อนที่ระยะทางปานกลาง (๕๐-๓๐๐ เมตร) และ การวางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้อุ้ม ควรยกผู้ป่วยเจ็บให้อยู่สูง ใกล้ระดับหน้าอกให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไม่มีเวลาที่ใช้แผ่นกระดานช่วยประคองผู้ป่วยเจ็บ การอุ้มแบบนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บที่มีการบาดเจ็บที่หลัง ถ้าเป็นไปได้ผู้อุ้มควรจะรักษาระดับของศีรษะ และขาไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกับลำตัว ตามขั้นตอนจะปฏิบัติดังนี้

ก. คุกเข่าข้างเดียวที่ด้านข้างของผู้ป่วยเจ็บ สอดแขนลงที่ใต้หลังผู้ป่วยเจ็บบริเวณ
เอว สะโพก และ เข่า

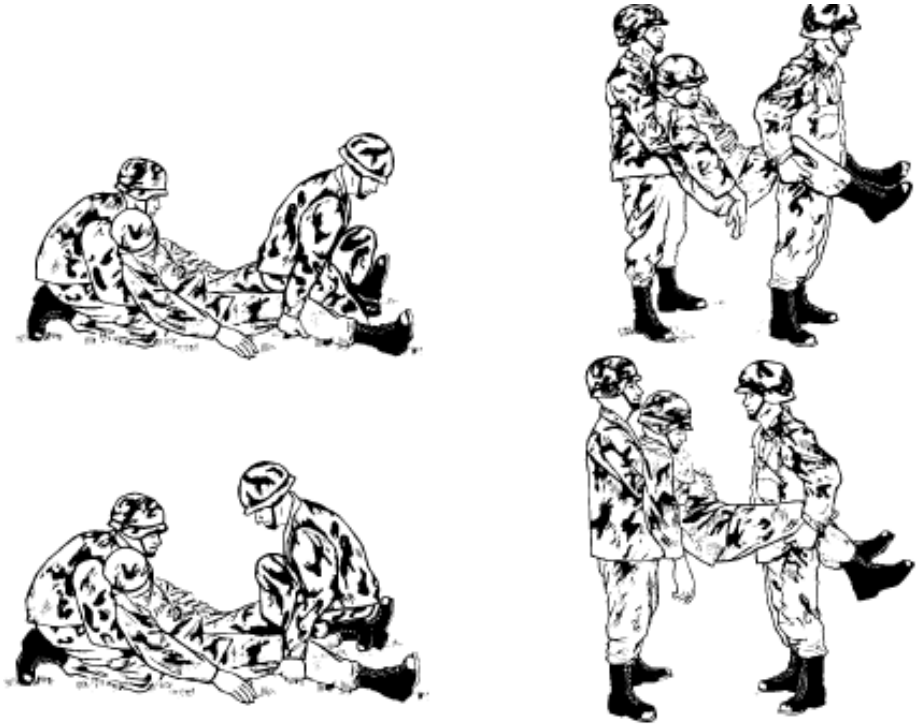
ข. ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นวางบนเข่าของผู้อุ้ม

ค. พลิกตัวผู้ป่วยเจ็บเข้าหาหน้าอกของผู้อุ้ม ขณะลุกยืน และ ยกผู้ป่วยให้อยู่ในระดับสูงเพื่อลดความเหนื่อยล้า



ภาพ ๓-๑๗ อุ้มคู่กอดหน้า

(๓) อุ้มคู่กอดหลัง (ตามภาพ ๓-๑๘) การอุ้มแบบนี้จะเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายในระยะทางไกล มากกว่า ๓๐๐ เมตร ผู้อุ้มที่มีความสูงมากกว่าควรจะอยู่ทางด้านศีรษะของผู้ป่วยเจ็บ เมื่อจะเปลี่ยนท่าการอุ้มเพื่อวางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล ผู้อุ้มจะหันหน้าเข้าหากัน



ภาพ ๓-๑๘ อุ้มคู่กอดหลัง

ก. ผู้อุ้มคนหนึ่งจะแยกขาของผู้ป่วยเจ็บออก และ คุกเข่าลงระหว่างขา หันหลังให้ผู้ป่วยเจ็บ สอดมือไว้ที่ใต้ขาผู้ป่วยเจ็บ ผู้อุ้มอีกคนจะคุกเข่าลงด้านศีรษะของผู้ป่วยเจ็บ สอดมือของผู้ป่วยเจ็บขึ้นที่ใต้รักแร้ผ่านไปทางหน้าอก และ ประสานมือเข้าไว้ด้วยกัน

ข.ผู้อุ้มทั้งสองคน ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นพร้อมกัน

(๔) อุ้มคู่ประสานแคร่ (ตามภาพ ๓-๑๙) ใช้กับผู้ป่วยเจ็บที่มีสติ เพราะผู้ป่วยเจ็บต้องประคองตัวเอง โดยใช้แขนโอบรอบไหล่ของผู้อุ้ม เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ และ ขา ในระยะทางปานกลาง และ เหมาะในการยกผู้ป่วยเจ็บวางในเปล



ภาพ ๓-๑๙ อุ้มคู่ประสานแคร่ และวิธีการประสานมือ

(๕) อุ้มคู่จับมือ (ตามภาพ ๓-๒๐) ใช้ในการอุ้มผู้ป่วยเจ็บในระยะทางสั้นๆไม่เกิน ๕๐ เมตร และ วางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล ผู้ป่วยเจ็บอยู่ในท่านอนหงาย ผู้อุ้มคุกเข่าลงคนละข้างของผู้ป่วยเจ็บบริเวณสะโพก ผู้อุ้มแต่ละคนสอดแขนใต้ต้นขา และ หลังของผู้ป่วยเจ็บ และ จับข้อมือซึ่งกันไว้ แล้วทำการยกผู้ป่วยเจ็บขึ้น

ก. ผู้อุ้มทั้งสองจับข้อมือแต่ละข้างของกันและกัน (ภาพ ๓-๑๙) เพื่อทำเป็นที่นั่ง

ข. ผู้อุ้มทั้งสองย่อตัวต่ำพอที่จะให้ผู้ป่วยเจ็บนั่งลงบนแคร่ที่ประสานมือไว้ แล้วให้ผู้ป่วยเจ็บใช้แขนทั้งสองข้างโอบไหล่ผู้อุ้ม และทั้งคู่ยืนขึ้นพร้อมกัน



ภาพ ๓-๒๐ อุ้มคู่จับมือ

บทที่ ๔
การเคลื่อนย้ายด้วยเปล

๔-๑ กล่าวทั่วไป

หลังจากพลเปล รับผู้ป่วยออกจากเขตหน้าแล้ว ผู้ป่วยจะถูกส่งกลับไปยังเขตหลังซึ่งอยู่ไกลออกไป ตามสภาพความเจ็บป่วยและสถานการณ์ทางยุทธวิธี ทั้งทางภาคพื้นดิน หรือทางอากาศ ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลนอน

๔-๒ ชนิดของเปล

เปลเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีบรรจุอยู่ในอัตรา ซึ่งกองทัพจะมีเปลมาตรฐานหลายชนิด เพื่อให้สามารถส่งกลับผู้ป่วยด้วยยานพาหนะได้หลายๆแบบ เป็นการประหยัดเวลาอันมีค่า และลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วย

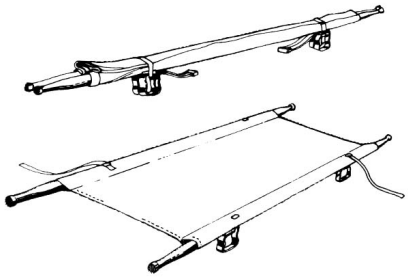
เปลมาตรฐาน เป็นเปลที่สร้างขึ้นมา พร้อมกับชิ้นส่วนต่างๆ

(๑) เปลมาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุด คือเปลพับตามยาว (ภาพที่ ๔-๑)ประกอบด้วย

- คานเปลแข็งน้ำหนักเบา ๒ ข้าง ส่วนปลายทำด้วยอลูมิเนียม
- ผ้าเปลทำด้วยผ้าฝ้ายถัก
- ด้ามเปลทำด้วยไม้สวมติดกับส่วนปลาย
- มีห่วงเหล็ก (โกลน) ๔ อัน ติดไว้ใกล้กับส่วนปลายของคานใช้ตั้งเปลเมื่อต้องวางบนพื้น
- มีขาถ่างเปล ๒ อันติดอยู่ส่วนปลายใกล้ห่วงเหล็ก เมื่อกางออกจะขึงผ้าเปลให้ตึง
- มีสายรัดเปล ๒ เส้น ติดอยู่ใกล้ห่วงเหล็กข้างละเส้น ไว้สำหรับรัดเปลเมื่อพับเก็บ
- ชิ้นส่วนอื่นๆ ได้แก่ สายรัดผู้ป่วย ๔เส้น

(2) ขนาดของเปลเมื่อพับเก็บ

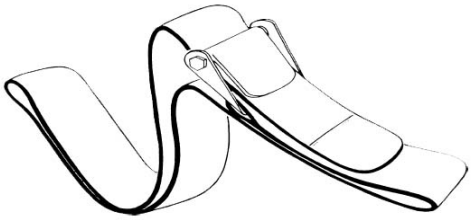
- ความยาว ๙๐นิ้ว
- ความกว้างโดยรวม ๒๒ ๗/๘ นิ้ว
- ความยาวของผ้าใบ ๗๒นิ้ว
- ความกว้างของผ้าใบ ๒๒ ๗/๘ นิ้ว
- น้ำหนัก๑๕ปอนด์



ภาพ ๔-๑ เปลมาตรฐาน ขณะพับเก็บ และกางออก

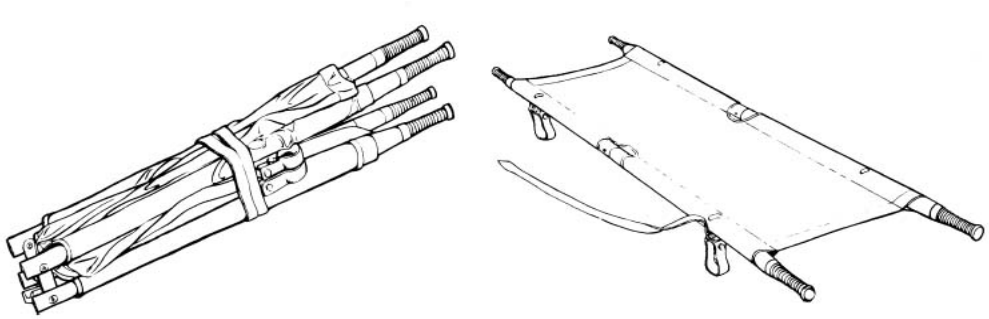
หมายเหตุ *เปลมาตรฐานพับได้นี้ จะต้องได้รับการทดแทนด้วยเปลพับได้แบบเดียวกัน เปลพับเก็บได้รุ่นใหม่หนัก ๒๕ปอนด์ ยาว ๙๑.๑นิ้ว ด้ามเปลสามารถปรับได้ ๙๐-๙๔.๔นิ้ว ขาถ่างเปลและห่วงเหล็กมีที่ล็อก ส่วนปลายเป็นอลูมิเนียม มีด้ามจับเป็นไนล่อน และมีปลอกเป็นพลาสติกโพลีโพรพิลีน เปลชนิดนี้เคลือบด้วยสารเคมี และสามารถนำไปใช้ในการล้างพิษได้*

(๒) สายรัดผู้ป่วย (ภาพ ๔-๒) ได้รับการออกแบบให้มีขนาดพอดีกับเปลมาตรฐาน หรือเปลอลูมิเนียมพับได้ ทำด้วยผ้าถัก ยาว ๖ ฟุต กว้าง ๒นิ้ว ส่วนปลายมีหัวเข็มขัดที่เป็นสปริง ใช้ในการยึดตรึงผู้ป่วยติดกับเปลเพื่อความปลอดภัย มีจำนวน เปลละ ๔ เส้น



ภาพ ๔-๒ สายรัดตัวผู้ป่วย

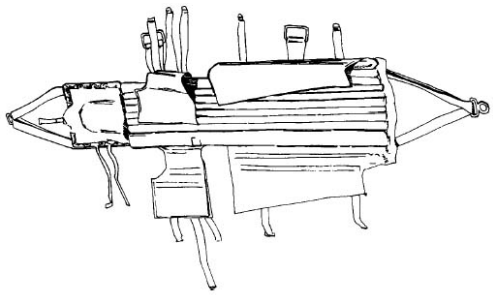
(๓) เปลมาตรฐานอื่นๆ เมื่อกางออกจะมีขนาดเท่ากับเปลอลูมิเนียมพับได้ มีด้ามเปลเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา และสามารถพับเก็บครึ่งหนึ่งได้เมื่อยังไม่ใช้งาน (ภาพ ๔-๓)



ภาพ ๔-๓ เปลอลูมิเนียมพับครึ่งขณะพับเก็บ และกางออกใช้งาน

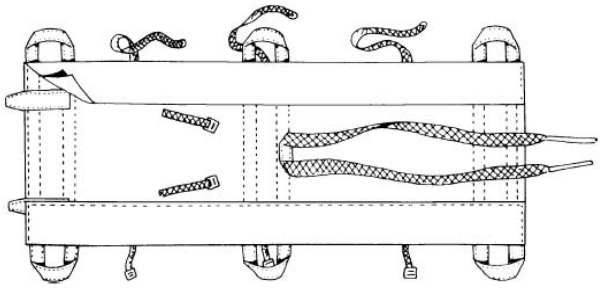
(๔) เปลไม่มีด้ามกึ่งแข็ง (ภาพ ๔-๔) มีประโยชน์มากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเรือหรือในพื้นที่ป่า ภูเขา สามารถยกผู้ป่วยในท่าที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในทางดิ่ง ขนาดของเปล คือ ยาว ๘๓ ๓/๔นิ้ว กว้าง ๒๒ ๓/๔ นิ้ว และหนัก ๑๘ ๓/๔ปอนด์ ประกอบด้วย

- ตัวเปลเป็นโครงไม้ และผ้าฝ้ายทอกึ่งแข็ง
- มีสายรัดเป็นผ้า ๔ เส้น อยู่ส่วนปลายข้างละ ๒ เส้น ใช้ในการยกเปลด้วยพลเปล ๔ นาย
- มีห่วงสำหรับสอดคานเพื่อใช้ยกเปล ๔ ห่วง
- แผ่นประคองศีรษะ
- สายยึดตรึงผู้ป่วย ๗ เส้น เพื่อใช้ยึดตรึงผู้ป่วยติดกับเปล



ภาพ ๔-๔ เปลไม่มีด้ามกึ่งแข็ง

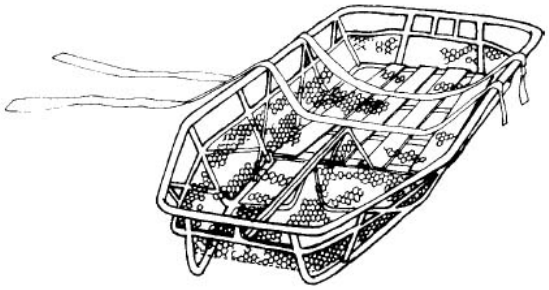
(๕) เปลแบบอ่อนไม่มีด้าม (ภาพ ๔-๕) เปลชนิดนี้ นายสิบพยาบาลเป็นผู้บรรทุกติดตัวไป สามารถม้วนและใช้คานสอดได้ เมื่อจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระยะทางไกลๆ มีห่วงที่ใช้คล้องเพื่อยก ผู้ป่วยขึ้น – ลง และมีสายรัดสำหรับยึดตรึงผู้ป่วยติดกับเปล (ดูรายละเอียดใน ผนวก จ -๓๔- จ-๓๗)



ภาพ ๔-๕ เปลแบบอ่อนไม่มีด้าม

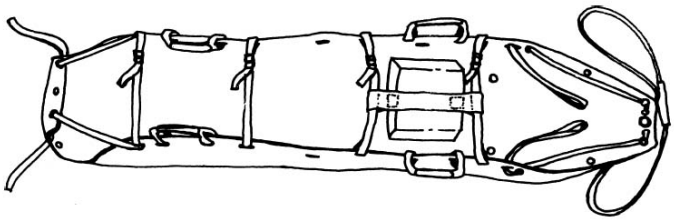
(๖) เปลสโตก Stokes litter (ภาพ ๔-๖) เปลนี้ มีความปลอดภัยสูงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ลาดเอียง (ดูรายละเอียดเพิ่มใน ผนวก จ- ๓๐ – จ - ๓๓) มีส่วนประกอบดังนี้

- โครงเป็นท่ออลูมิเนียม พื้นเป็นเส้นลวดถัก และมีแผ่นไม้สำหรับประคองส่วนหลังของผู้ป่วย
- ส่วนล่างแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อรองรับขาของผู้ป่วย
- มีสายรัดผู้ป่วยจำนวน ๔ เส้น
- มีเชือก สายเคเบิ้ล หรือห่วงโลหะที่จะสามารถยึดติดกับเปล เมื่อต้องการให้ผู้ป่วยอยู่ในแนวตั้ง
- ขนาด ยาว ๘๔นิ้ว กว้าง ๒๓นิ้ว หนัก ๓๑ ½ ปอนด์



ภาพ ๔-๖ เปลสโตก (Stokes litter)

(๗) เปล SKED (ภาพ ๔-๗) เป็นเปลที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้ในการส่งกลับผู้ป่วยข้ามประเทศ หรือในการช่วยผู้ที่อยู่ในน้ำ (ดูรายละเอียดในผนวก จ-๒๖ - จ-๒๙)



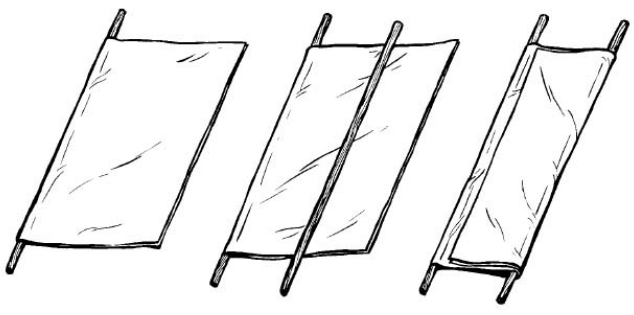
ภาพ ๔-๗ เปล SKED

๔-๒-๒ เปลแสวงเครื่อง เปลแสวงเครื่องทำจากอุปกรณ์หลายๆชนิดเท่าที่จะหาได้ในพื้นที่เขตหน้า

● เมื่อต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และไม่มีเปลมาตรฐาน ระยะทางจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บ กระดูกหัก โดยเฉพาะที่คอ หลัง สะโพก หรือต้นขา การเคลื่อนย้ายด้วยมือเปล่า อาจเป็นอันตรายมากขึ้น ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้อาจต้องทำเปลขึ้นมาจากสิ่งอุปกรณ์ใกล้มือต่างๆที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถส่งกลับผู้ป่วยได้ด้วยความปลอดภัย และเปลี่ยนไปใช้เปลมาตรฐานทันทีในโอกาสแรกที่ทำได้

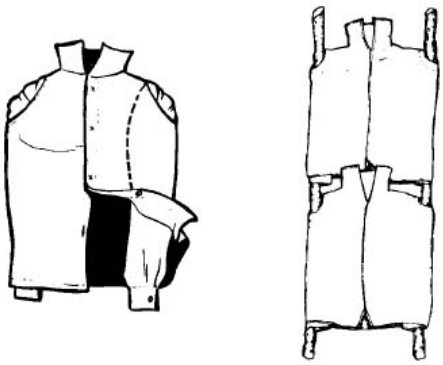
● เปลแสวงเครื่องมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับสิ่งอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ เช่นการใช้คานสอดเข้าไปในผ้าห่ม หรือผ้าปันโจพับครึ่ง (ภาพ ๔-๘) tarpaulin ผ้าปูที่นอน เสื้อแจ็คเกท เสื้อเชิ้ต (ภาพ ๔-๙) หรือ bedticks ถุง และsacks (ภาพ ๔-๑๐) คานควรทำจากกิ่งไม้ที่มีความแข็งแรง เช่น เสาเต็นท์ ขาสกี ท่อยาวๆหรือวัตถุอื่น แต่ถ้าไม่สามารถหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ อาจใช้ผ้าห่ม หรือผ้าปันโจ ม้วนจากด้านข้างเข้ามาตรงกลางใช้หามผู้ป่วยได้ (ภาพ ๔-๑๑) นอกจากนั้นวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบส่วนใหญ่มักนำมาใช้ทำเปลแสวงเครื่องได้ เช่น บานประตู บานหน้าต่าง ไม้กระดาน ม้านั่ง บันได เตียง และเก้าอี้ เป็นต้น

1) ขั้นตอนการทำเปลแสวงเครื่องด้วยผ้าห่ม
   - คลี่ผ้าห่มออก วางคานอันที่หนึ่งตามขวางตรงกึ่งกลางของผ้าห่ม พับผ้าห่มทับคาน
   - วางคานอันที่สองที่กึ่งกลางตามขวางของผ้าห่มที่พับไว้
   - พับขอบผ้าห่มข้างที่เหลือทับคานไม้อันที่สองไปจนชิดคานอันที่หนึ่ง



ภาพ ๔-๘ เปลแสวงเครื่องทำจากผ้าห่มและคานไม้

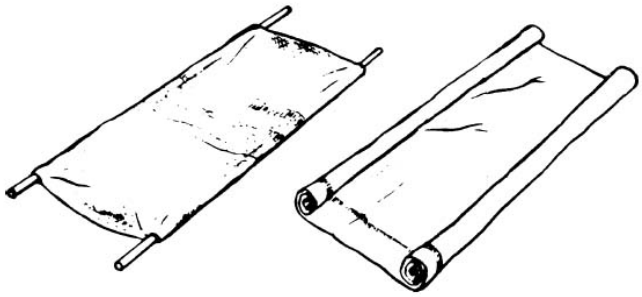
2) การทำเปลแสวงเครื่องจากเสื้อเชิ้ต และ เสื้อแจ๊คเกท กลัดกระดุมเสื้อแล้วกลับเอาด้านในออก ปล่อยให้แขนเสื้อยังคงอยู่ด้านใน และสอดคานไม้เข้าไปในแขนเสื้อทั้งสองข้าง



ภาพ ๔-๙ เปลแสวงเครื่องทำจาก เสื้อแจ๊คเกท

3)การทำเปลแสวงเครื่องจากผ้าปู ถุง และคาน เปิดมุมผ้าห่ม หรือถุงสองข้าง แล้วสอดคานไม้เข้าไป

4)ถ้าไม่มีคานไม้ ให้ม้วนขอบผ้าห่มทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางประมาณครึ่งผืนใช้แทนคานไม้ โดย ยึดขอบที่ม้วนเพื่อยกผู้ป่วย



ภาพ ๔-๑๐ เปลแสวงเครื่องทำจากผ้าห่ม และคานหาม

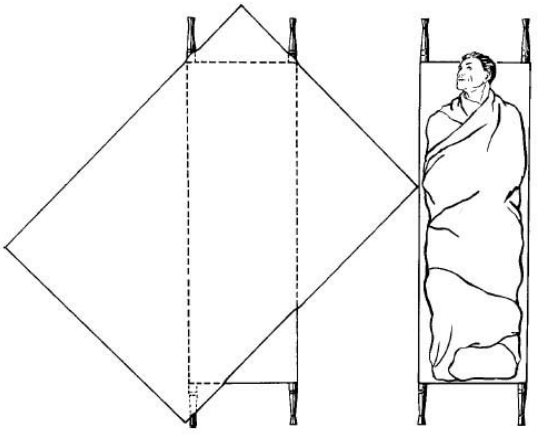


ภาพ ๔-๑๑ เปลแสวงเครื่องทำจากม้วนผ้าห่ม

๔-๓ การหุ้มเปล

การหุ้มเปลอาจใช้ผ้าห่ม ๑-๓ ผืน เพื่อให้ความอบอุ่น ให้ความสุขสบาย ป้องกันอันตราย และป้องกันอาการช็อก (ภาพ ๔-๑๒ – ๔-๑๔) ในสถานการณ์ คชรน. เปลจะต้องหุ้มด้วยผ้ากันการดูดซึม เช่นผ้าปันโจที่เป็นยาง หรือวัตถุที่คล้ายกัน และใช้ผ้านี้คลุมตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี ถ้าไม่มีผ้ากันซึมอาจใช้ผ้าห่มแทน

๔-๓-๑ การหุ้มเปลด้วยผ้าผืนเดียว (ภาพ ๔-๑๒) เริ่มจากวางผ้าห่ม ทแยงมุมบนเปล แล้ววางผู้ป่วยลง พับผ้าจากมุมด้านข้างข้ามตัวผู้ป่วยไปเหน็บอีกข้างหนึ่งทั้งด้านศีรษะและเท้า

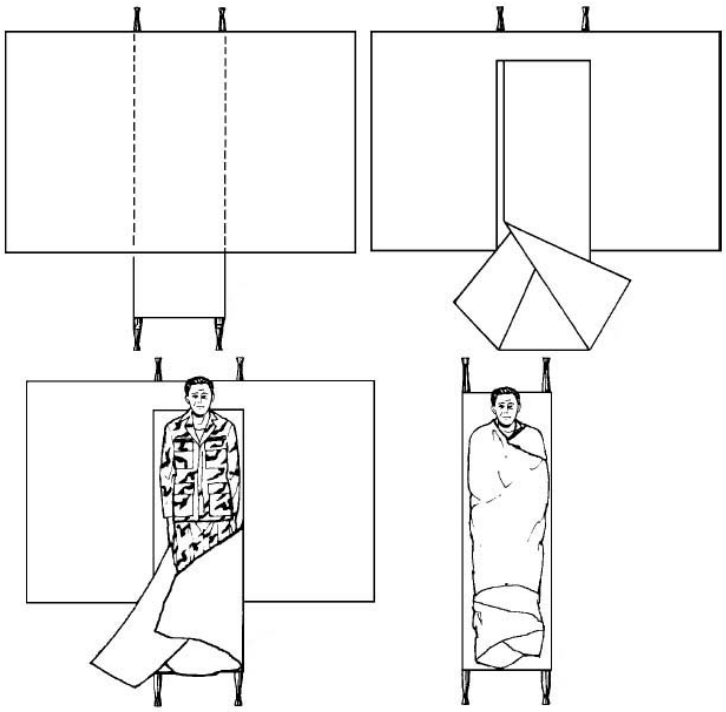


ภาพ ๔-๑๒ การหุ้มเปลด้วยผ้าห่มผืนเดียว

๔-๓-๒ การหุ้มเปลด้วยผ้าห่ม สองผืน (ภาพ ๔-๑๓) วางผ้าห่มผืนแรกตามยาวขวางเปล ให้ขอบของผ้าชิดด้านศีรษะของเปล พับผ้าห่มผืนที่สองตามยาวเป็น สาม ส่วน วางทับลงบนผ้าผืนแรก โดยให้ขอบบนอยู่ต่ำกว่าขอบบนของผ้าผืนแรก ๑๐นิ้ว เปิดด้านปลายของผ้าผืนที่สองขึ้นไปประมาณ

๒ ฟุต เมื่อวางผู้ป่วยลงบนเปลแล้วพับผ้าด้านปลายเท้าขึ้นคลุมเท้าของผู้ป่วย โดยจีบผ้าระหว่างเท้าทั้งสองข้างเล็กน้อย พับขอบผ้าทั้งสองข้างให้ชิดกับขาและเท้าของผู้ป่วย เปิดส่วนบนของผ้าผืนที่สองขึ้นหุ้มเท้าของผู้ป่วยประมาณ ๒ ฟุตจากปลายเท้า ให้ผ้ามีรอยย่นเล็กน้อยระหว่างเท้าทั้งสองข้าง พับขอบข้างของผ้าทั้งสองข้างรอบขาและเท้า และสุดท้ายห่อตัวผู้ป่วยด้วยผ้าผืนที่หนึ่งจากขอบข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง

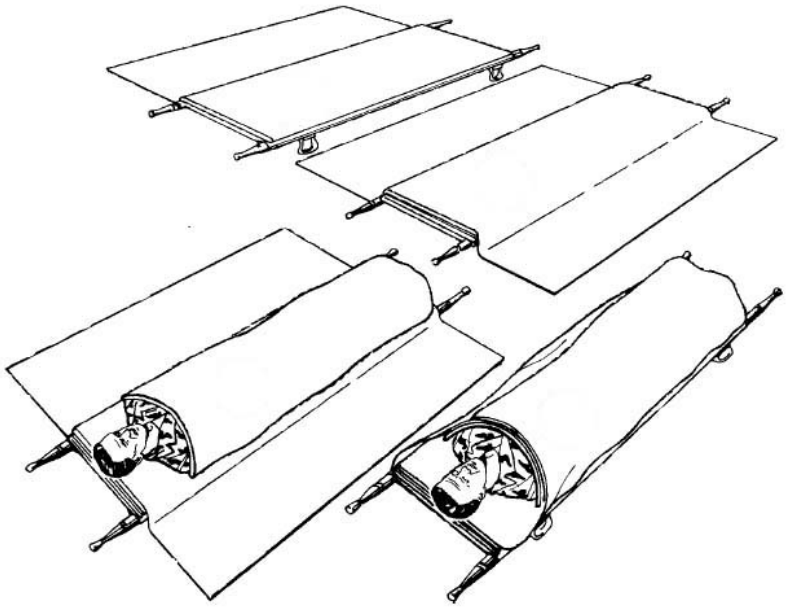
หมายเหตุ *ถ้าผู้ป่วยตัวสูงมาก ให้วางผ้าห่อต่ำลง*



ภาพ ๔-๑๓ การหุ้มเปลด้วยผ้าห่มสองผืน

๔-๓-๓ การหุ้มเปลด้วยผ้าสามผืน (ภาพ ๔-๑๔) วางผ้าห่มตามยาวให้ขอบชิดขาเปลด้านไกลตัว ขอบด้านบนอยู่แนวเดียวกับขอบผ้าใบ พับผ้าทบกลับให้ขอบชนขอบขาเปลข้างใกล้ตัว จะเหลือผ้าห่มอีกส่วน วางผ้าห่มผืนที่สองเช่นเดียวกับผ้าผืนแรกแต่ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งจะทำให้มีผ้าส่วนที่เหลืออยู่อีกคนละด้านของผ้าผืนแรก เมื่อวางผู้ป่วยลง คลุมผ้าผืนที่สามตามยาวบนตัวผู้ป่วยให้ขอบบนของผ้าอยู่ใต้คางผู้ป่วย พับขอบที่เหลือของผ้าผืนที่หนึ่ง และผืนที่สองคลุมทับผ้าผืนที่สาม เหน็บให้เรียบร้อย ถ้าจำเป็นอาจใช้เข็มกลัด รวมทั้งใช้สายรัดตัวผู้ป่วย

หมายเหตุ *วิธีการหุ้มเปลแบบนี้จะมีผ้าจำนวนสี่ผืนหุ้มตัวผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วย*

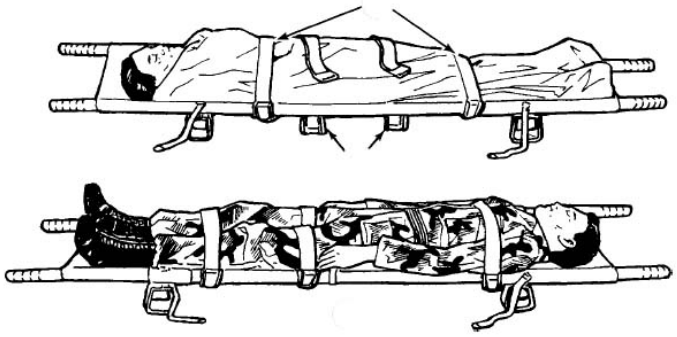


ภาพ ๔-๑๔ การหุ้มเปลด้วยผ้าห่มสามผืน

๔-๔ การใช้สายรัดตัวผู้ป่วย

เมื่อวางผู้ป่วยบนเปล และห่มผ้าเรียบร้อยแล้วจะใช้สายรัดตัวผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจำนวนของสายรัดตัว หรือตำแหน่งในการวางสายรัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศในการเคลื่อนย้าย (ภาพ ๔-๕)

- ถ้าจำเป็นต้องใช้สายรัดตัวสองเส้น ให้วางสายรัดบริเวณหน้าอก และขาที่ใต้เข่า อย่างละเส้น กางสายรัดออกแล้วสอดไปใต้เปล และรัดกับหัวเข็มขัดให้แน่นพอควรกับขาเปล
- ถ้าพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายขรุขระ ให้เพิ่มสายรัดอีกสองเส้นบริเวณเอวและต้นขา
- ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น ลงบันไดหรือทางลาด แยกรัดสายรัดที่ต้นขาด้วยสายรัดสองเส้น โดยรัดสายรัดเส้นที่หนึ่งที่ต้นขาข้างหนึ่งแล้วสอดไปใต้ต้นขาอีกข้างหนึ่งอ้อมใต้เปลไปรัดกับขาเปลอีกข้างหนึ่ง ใช้สายรัดเปลอีกเส้นรัดต้นขาอีกข้างโดยใช้วิธีเดียวกันในทางตรงกันข้าม



ภาพ ๓-๑๕ การใช้สายรัดตัวผู้ป่วย

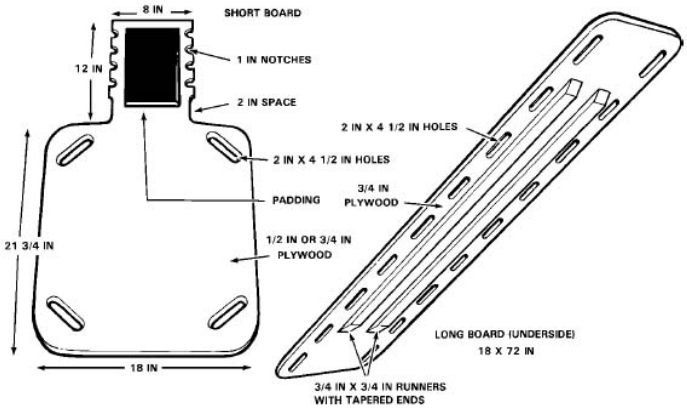
๔-๕ หลักการทั่วไปในการยกตัวผู้ป่วย

๔-๕-๑ การยกตัวผู้ป่วยตามย่อหน้าที่ ๔-๓ ให้ประยุกต์ใช้หลักการต่อไปนี้

- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องทำด้วยความนุ่มนวลเท่าที่จะทำได้เสมอ และใช้คำสั่ง “เตรียม”เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและป้องกันการเร่งรีบ
- ผู้ยกที่อยู่ด้านหลังจะต้องคอยมองการเคลื่อนไหวของคนยกที่อยู่ข้างหน้าตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
- ต้องพยายามยกเปลให้อยู่ในแนวราบเสมอโดยเฉพาะเมื่อข้ามสิ่งกีดขวาง
- โดยปกติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเปลจะต้องหันปลายเท้าไปข้างหน้าเสมอ ยกเว้นเมื่อยกผู้ป่วยขึ้น ลงบันได หรือทางลาดให้หันศีรษะไปทางด้านหน้าแทน แต่ถ้าผู้ป่วยมีกระดูกท่อนขาหักเมื่อจะเคลื่อนย้ายขึ้นบันไดหรือขึ้นเนินให้ปลายเท้าเป็นส่วนนำ แต่ถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายขึ้นบันไดหรือขึ้นที่สูง ให้ศีรษะของผู้ป่วยเป็นส่วนนำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยกดลงบนส่วนที่บาดเจ็บ
- สิ่งอุปกรณ์ประจำกายของผู้ป่วยที่ได้รับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเปลต้องนำติดตัวไปด้วย โดยอาจวางบนเปล หรือ ผู้หามเปล
-

๔-๖ การใช้กระดานรองกระดูกสันหลัง และ เครื่องดึง เคนดริก Kendrick’s Extrication Device (KED)

กระดานรองกระดูกสันหลัง และ KED ใช้ในการช่วยชีวิต และยึดตรึงผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังหัก หรือสงสัยว่าจะมีกระดูกสันหลังหัก (ภาพ ๔-๑๖)



ภาพ ๔-๑๖ กระดานรองหลัง

๔-๖-๑ กระดานรองกระดูกสันหลังแบบสั้นใช้ประคับประคองหลังหรือคอ โดยประคองจากเอวขึ้นไปที่กระดูกสันหลังก่อนที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ภาพ ๔-๑๗) กระดานแบบยาว (c) ผู้เคลื่อนย้ายจะต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ คือกระดานรองกระดูกสันหลังแบบสั้น แผ่นประคองคอ (Cervical Collar) สายรัดตัวผู้ป่วยขนาดยาว ๖ ฟุต ๒ เส้น และผ้าคราวาท ถ้าของตามรายการดังกล่าวมีไม่ครบ ผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาจต้องหาสิ่งของอื่นๆเพื่อใช้ทดแทน

● ผู้เคลื่อนย้ายคนที่หนึ่ง ใช้มือประคองศีรษะและขากรรไกรของผู้ป่วยไว้ ค่อยๆ ยกศีรษะผู้ป่วยขึ้น ดึงไปข้างหน้าเล็กน้อย ในขณะที่ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สองสอดแผ่นเฝือกอ่อนที่ใช้ประคองคอเข้ารอบคอของผู้ป่วย

● ผู้เคลื่อนย้ายคนที่หนึ่งอยู่ในท่ายกศีรษะผู้ป่วยขึ้น ดึงไปข้างหน้าเล็กน้อย ในขณะที่ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สองค่อยๆสอดไม้กระดานประคองหลังแบบสั้นเข้าไปใต้หลังผู้ป่วย และใช้ผ้าคราวาท และเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย ดังภาพ ๔-๑๗ ตามลำดับดังนี้

- พันผ้าคราวาทรอบศีรษะของผู้ป่วย โดยวางกึ่งกลางของผ้าคราวาทไว้ที่หน้าผากตามขวางพันอ้อมไปด้านหลังศีรษะ สอดปลายผ้าเข้าใต้ไม้กระดานและผูกเป็นปมไว้ด้านหลัง
- สายรัดตัวผู้ป่วยเส้นที่หนึ่ง วางส่วนโค้งของสายรัดไว้บนตักของผู้ป่วย ปลายอีกข้างหนึ่งสอดไปในรูด้านล่างของกระดานแล้วสอดข้ามไปยังรูด้านบน โดยสอดใต้เข็มขัดปืนเหนือไหล่ อ้อมใต้กระดานบริเวณคอ มาเชื่อมต่อกับสายรัดเส้นที่สอง
- สายรัดเส้นที่สอง ผูกต่อจากเส้นแรก ให้ปมอยู่ด้านข้างของกระดาน บริเวณคอของผู้ป่วย ปลายสายพาดผ่านไหล่ลอดใต้สายรัดปืน ไปยังห่วงด้านบนของกระดาน โยงอ้อมด้านหลังไปที่ห่วงด้านล่าง แล้วพันผ่านด้านหน้าตักมาผูกกับปลายสายของเส้นแรก

หมายเหตุ *ถ้าเป็นไปได้ ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สองเป็นคนใส่เฝือกเพื่อพยุงคอของผู้ป่วย*



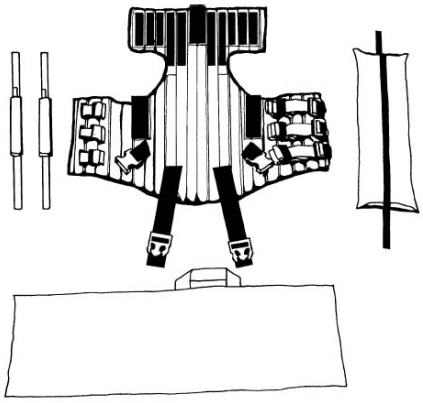
ภาพ ๔-๑๗ การใช้กระดานพยุงหลังแบบสั้น

๔-๖-๒ KED เป็นกระดานรองหลังแบบสั้น ใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง และ จำเป็นต้องอยู่ในท่านั่ง

(1) ผู้เคลื่อนย้ายคนที่หนึ่งยังคงรักษาประคองคอผู้ป่วยไว้จนกว่าจะใส่ KED เรียบร้อยแล้ว

(2) ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สองใส่เฝือกแข็งที่คอ วาง KED ไว้ใต้ตัวผู้ป่วย วางcushion ใต้ศีรษะตามยาวของ KED รัดสายรัดที่หน้าอก ขา สะโพก หน้าผาก และคาง

(3) ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สามผูกมือผู้ป่วยเข้าด้วยกัน แล้วยกผู้ป่วยวางบนกระดานยาว



ภาพ ๔-๑๘ ส่วนประกอบของเครื่องดึงเคนดริก (Kendrick extraction device)

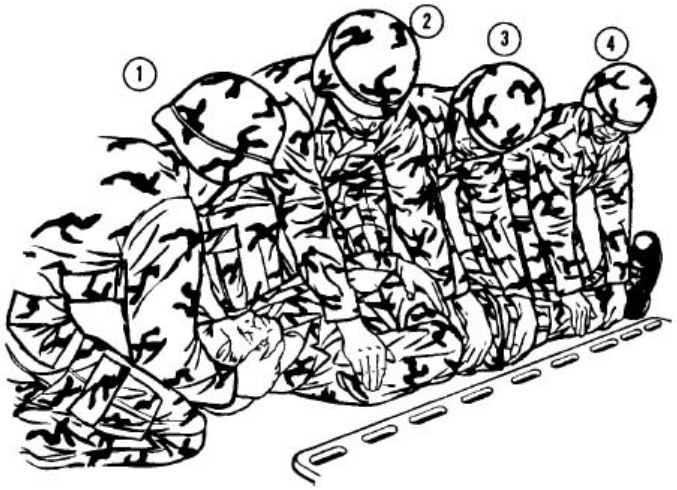
๔-๖-๓ กระดานรองหลังแบบยาว เมื่อผู้ป่วยมีกระดูกสันหลังหัก หรือสงสัยว่าอาจมีอันตรายที่กระดูกสันหลังและคอ (ดังได้กล่าวมาแล้ว) ผู้ป่วยจะต้องนอนบนกระดานรองหลังแบบยาว (ภาพ ๔-๑๙ และ ๔-๒๑) ซึ่งผู้เคลื่อนย้ายต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ กระดานรองหลังแบบยาว สายรัดตัวผู้ป่วย ขนาด ๖ ฟุต ๔ เส้น ผ้าคราวาท และ แผ่นรอง ๔ แผ่น ถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ให้ใช้อุปกรณ์แสวงเครื่องอื่นๆแทน

● ผู้เคลื่อนย้ายวางแผ่นกระดานรองหลังข้างๆตัวผู้ป่วย แล้ววางแผ่นรองที่บริเวณคอ หลัง เข่าและข้อเท้า แผ่นรองบริเวณหลังควรเป็นวัสดุบางๆ

● ผู้เคลื่อนย้ายคนที่หนึ่ง คุกเข่า ด้านศีรษะของผู้ป่วย ใช้มือทั้งสองข้างประคองศีรษะและขากรรไกรของผู้ป่วยไม่ให้เคลื่อนไหว พร้อมทั้งออกแรงดึงเบาๆ (ภาพ ๔-๑๙) ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สอง สาม และสี่ คุกเข่าด้านข้างของผู้ป่วย เอื้อมมือไปจับตัวผู้ป่วยด้านไกลตัว โดยคนที่หนึ่งจับที่ไหล่และเอว คนที่สองจับที่สะโพกและต้นขา ส่วนคนที่สามจับเข่า และข้อเท้า (ภาพ ๔-๒๐)



ภาพ ๔-๑๙ ตำแหน่งการวางมือ



ภาพ ๔-๒๐ ตำแหน่งของผู้เคลื่อนย้าย

● ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สอง สามและสี่ พลิกตัวผู้ป่วยเข้าหาตัวเอง ในขณะที่ผู้เคลื่อนย้ายคนที่หนึ่งประคองศีรษะผู้ป่วยพลิกตาม โดยพยายามให้ศีรษะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับกระดูกสันหลัง

● ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สามประคองผู้ป่วยด้วยมือข้างเดียว และดึงขอบกระดานด้านใกล้ตัวเข้าหาผู้ป่วย และทั้งหมดค่อยๆพลิกตัวผู้ป่วยกลับวางลงบนกระดาน โดยพยายามให้ศีรษะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับกระดูกสันหลัง

● ขณะที่ผู้เคลื่อนย้ายคนที่หนึ่งยังคงประคองศีรษะและขากรรไกรของผู้ป่วยไม่ให้เคลื่อนไหว พร้อมทั้งออกแรงดึงเบาๆ ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สอง สามและสี่ จะช่วยกันรัดตัวผู้ป่วยด้วยสายรัดตัวทั้งสี่เส้นด้วยการออกคำสั่ง ดังนี้

- คราวาท ให้วางกึ่งกลางของผ้าคราวาทบนผู้ป่วย ที่ศีรษะวางบนหน้าผากปิดตีนผม ดึงปลายผ้าทั้งข้างให้ตึง แล้วสอดเข้าไปที่รูของขอบกระดานทั้งสองข้างผูกให้แน่น

- สายรัดเส้นที่หนึ่ง สอดปลายสายรัดตัวผู้ป่วยไปในห่วงใต้เปลบริเวณใกล้กับหัวไหล่ พันอ้อมมาบนหน้าอกข้ามไปยังห่วงอีกด้านหนึ่ง แล้วย้อนข้ามแขนกลับมาผูกเข้ากับปลายสายอีกข้าง โดยให้หัวเข็มขัด อยู่บนกระดาน ห้ามไม่ให้ผูกบนตัวผู้ป่วย
- สายรัดเส้น ๓เส้นที่เหลือ เส้นแรกรัดบริเวณสะโพก เส้นต่อมารัดที่เหนือเข่า และเส้นสุดท้ายที่ข้อเท้า สอดปลายสายรัดของแต่ละเส้นเข้าไปในห่วงของกระดาน ใกล้ตัวและผูกเข้ากับปลายอีกข้างหนึ่งของให้หัวเข็มขัด อยู่บนกระดาน อย่าให้อยู่บนตัวผู้ป่วย



ภาพ ๔-๒๑ แสดงการยึดตรึงผู้ป่วยบนกระดานรองหลังแบบยาว

๔-๗ เลื่อน

เลื่อน เป็นเปลหยาบๆผูกติดกับหลังม้า หรือสัตว์อื่นแล้วลากไปกับพื้น บางครั้งอาจผูกพ่วงด้วยสัตว์ ๒ ตัว เปลนี้ทำขึ้นจากเสาไม้ยาวๆ ๒ เสาผูกติดกัน ด้วยคาน ๒ อันทางด้านหัวและท้าย โดยนำผ้าเปลมาขึงติดกับเสา และคาน ยึดตรึงให้ผู้ป่วยนอนบนเปล กรณีลากจูงด้วยสัตว์ตัวเดียว ผู้เคลื่อนย้ายยกส่วนหัวของผู้ป่วยให้สูงจากพื้นเมื่อขึ้นที่สูง ข้ามสิ่งกีดขวาง หรือลำธาร วิธีทำ เลื่อน

● ตัดไม้ยาวประมาณ ๑๖ฟุต ๒ ท่อน ปลายข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่ง ๘-๑๐นิ้ว ให้ส่วนปลายมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย ๒นิ้ว แล้วตัดไม้สำหรับทำคานยาวประมาณ ๓ฟุต

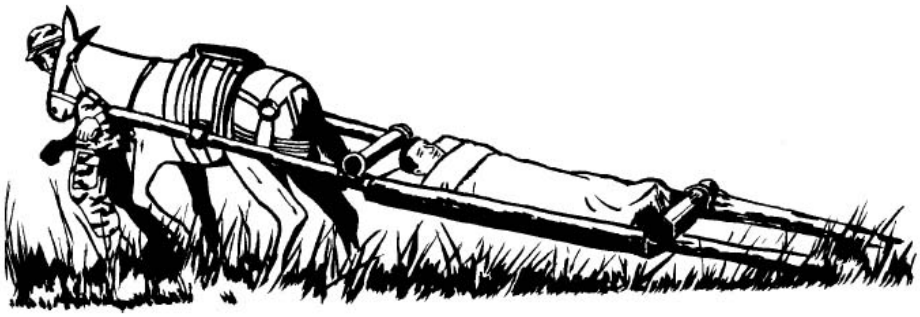
● วางเสา ๒ ข้างขนานกัน ห่างจากกันประมาณ ๒ ½ ฟุตโดยให้โคนข้างที่ใหญ่กว่าอยู่ข้างหัว ส่วนปลายซึ่งเรียวเล็กกว่าด้านท้าย วางห่างกัน ๓ฟุต และให้ปลายข้างหนึ่งยื่นยาวออกไปจากอีกข้างหนึ่ง ๘-๑๐ฟุต วิธีนี้จะช่วยให้โยกเยก ลดแรงกระแทกบนตัวผู้ป่วย

● ผูกคาน ๒ อันเข้ากับเสาให้แน่น โดยให้ห่างจากปลายส่วนหัวประมาณ ๖ฟุต และห่างจากปลายเท้าด้านสั้น ประมาณ ๖ฟุต

● ขึงผ้าใบขนาด ๖ฟุต ตามยาวระหว่างคานทั้งสองข้าง โดยผูกเข้ากับเสา และคานให้แน่น(อาจใช้ผ้าห่ม ผ้าใบ ผ้าเต็นท์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน)

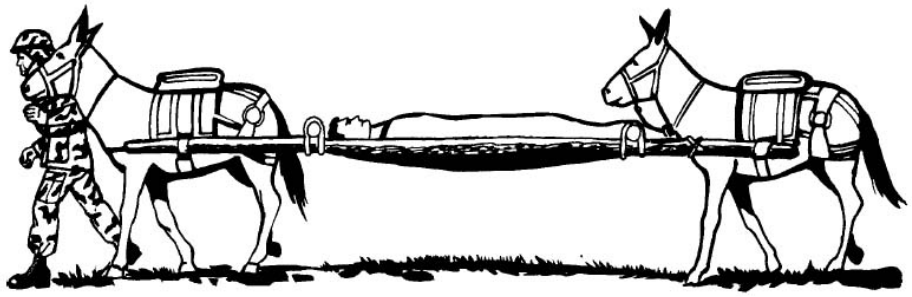
หมายเหตุ *ควรดึงเชือก หรือสายรัดระหว่างเสาให้ตึงและพันรอบเสาหลายๆรอบให้แน่น*

กรณีใช้สัตว์ตัวเดียว ผูกส่วนปลายด้านศีรษะ บนหลังของสัตว์และยึดให้แน่น ปล่อยส่วนปลายเท้าไว้บนพื้น(ภาพ ๔-๒๒)



ภาพ ๔-๒๒ การใช้ เลื่อนโดยสัตว์ตัวเดียว

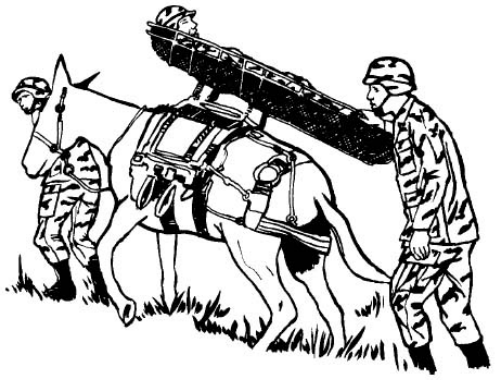
เมื่อใช้สัตว์ ๒ ตัว ให้วางส่วนปลายด้านศีรษะไว้บนหลังของสัตว์ตัวหน้าผูกให้แน่น และวางส่วนปลายเท้าไว้บนหลังของอีกตัวที่ตามหลัง (ภาพ ๔-๒๓)



ภาพ ๔-๒๓ การใช้ เลื่อน โดยสัตว์ ๒ ตัว

๔-๘ เปลบรรทุกบนอานม้า

เปลบรรทุกบนอานม้า สามารถทำขึ้นโดยยึดเปลให้ติดบนอานสัตว์ให้แน่น อาจใช้ม้า ล่อ หรือ สัตว์อื่นๆ (ภาพ ๔-๒๔) วิธีนี้จะใช้ได้ดีในการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ป่า ภูเขา หรือการเคลื่อนย้ายระยะไกล



ภาพ ๔-๒๔ เปลบรรทุกบนอาน

๔-๙ เปลที่ใช้ในการส่งกลับในสถานการณ์รบในพื้นที่ป่า ภูเขา

๔-๙-๑เจ้าหน้าที่หมู่เปลจะต้องได้รับการฝึกในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การปีนเขา
- การใช้เชือก
- การใช้อุปกรณ์ทั้งส่วนตัวและของหน่วยที่จำเป็นในภูมิประเทศที่เป็นที่สูง

๔-๙-๒ จำนวนเจ้าหน้าที่หมู่เปลต้องเพิ่มจาก ๔ เป็น ๖ คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๔-๑๐เทคนิคในการส่งกลับด้วยเปลในพื้นที่ป่า ภูเขา

เทคนิคนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสม แต่ก็ยังต้องการการพัฒนาอีกโดยมีหลักดังนี้

๔-๑๐-๑ เลือกเส้นทางที่เรียบที่สุดเท่าที่จะหาได้

๔-๑๐-๒ สวมเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยได้รับความอบอุ่นมากที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่า

๔-๑๐-๓ คลุมศีรษะของผู้ป่วยด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันไม่ให้โดนหินที่อาจกลิ้งลงมา

๔-๑๐-๔ ถ้าระยะทางไกลมาก ควรกำหนดจุดหรือสถานีพักเปล ซึ่งควรจะมี ทหารเหล่าแพทย์ ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น อาการช็อก เสียเลือด เป็นต้น

๔-๑๐-๕ ถ้าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงอาจต้องหยุดพักที่สถานีพักเปล และได้รับการรักษาพยาบาลจนกว่าอาการจะคงที่จึงทำการส่งกลับต่อไป

๔-๑๑ ชนิดของเปลที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ป่าภูเขา

เปลที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ป่าภูเขา มี ๔ชนิด ได้แก่ เปลมาตรฐานพับได้ (ภาพ ๔-๑) เปลไม่มีด้ามกึ่งแข็ง (ภาพ ๔-๔) เปลสโตก (ภาพ ๔-๖) และ เปล SKED (ภาพ ๔-๗) ในการใช้เปลมาตรฐานพับได้ถ้าไม่มีสายรัดตัวผู้ป่วย อาจใช้เชือกที่หาได้รัดตัวผู้ป่วยแทน

๔-๑๒ วิธีการเคลื่อนย้ายด้วยเปลในพื้นที่ป่าภูเขา

มีการประยุกต์ใช้ วิธีการเคลื่อนย้ายด้วยเปลในพื้นที่ป่าภูเขา หลายวิธี เช่น

๔-๑๒-๑ การใช้เลื่อน เลื่อนลง (ภาพ ๔-๒๕) วิธีนี้ใช้ในการเคลื่อนย้ายลงจากพื้นที่ราบเอียงและเรียบ สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ความเร็วในการเลื่อนไหลลง โดยเฉพาะเมื่อหน้าผามีความชัน ๔-๖ฟุต ซึ่งจะทำให้เคลื่อนย้ายได้ไม่ลำบากมากนัก

(๑) ตัดท่อนไม้ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓นิ้ว ยาวประมาณ ๑๘ ฟุต ๒ อัน ทำเป็นเสา ผูกเข้ากับขาเปล เสานี้จะเป็นตัวหมุนห่างออกไปจากเปลประมาณ ๕-๑๐ฟุต

(๒) ผู้เคลื่อนย้ายคนหนึ่งพยุงขาเปลด้วยเชือก อีกคนหนึ่งค่อยๆหย่อนเปลลง ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สามช่วยทหารดึงเชือกและค่อยๆหย่อนเปลลงช้าๆเป็นระยะสั้นๆ



ภาพ ๔-๒๕ การประยุกต์ใช้เลื่อน (ลงเขา)

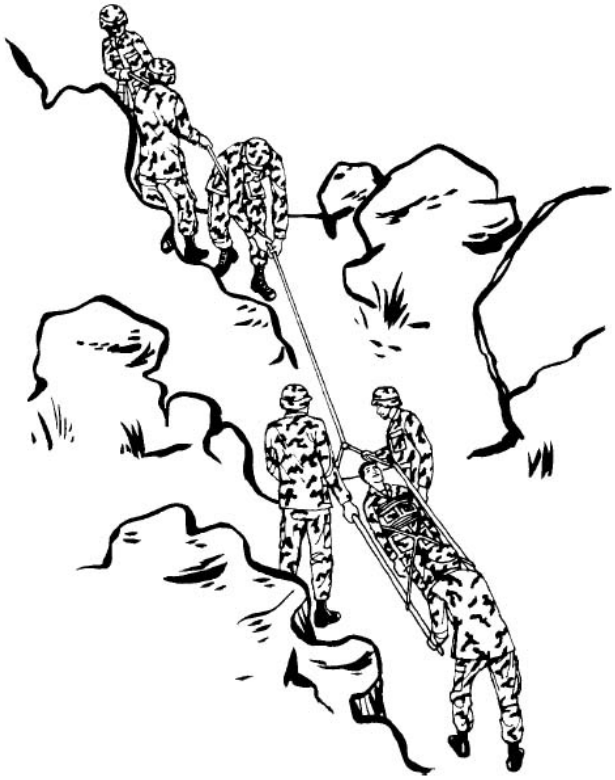
๔-๑๒-๒ การประยุกต์ใช้เลื่อน (ขึ้นเขาเป็นขั้นๆ) (ภาพ ๔-๒๖) เตรียมเปลเหมือน ๔-๑๒-๑

(๑) ใช้เชือกนิ่มๆผูกเข้ากับขาเปลด้านศีรษะ ผูกเสาให้ยื่นออกจากเปลทั้งสองข้างประมาณ ๑๘นิ้ว เพื่อให้ผู้เคลื่อนย้ายที่อยู่ด้านศีรษะใช้เป็นที่ยึด

(๒) ผู้เคลื่อนย้ายอยู่ที่ด้านศีรษะของเปล ๒นาย ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สามอยู่ด้านปลายเท้า ยึดเชือกพยุงที่แสวงได้

(๓) ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สี่และห้าอยู่ด้านศีรษะผู้เคลื่อนย้ายที่อยู่ด้านศีรษะ อยู่สูงขึ้นไปตามลำดับ ยึดเชือกไว้ ส่วนผู้เคลื่อนย้ายคนที่หกอยู่ปลายสุดของเชือกด้านศีรษะ

(๔) เมื่อได้รับคำสั่งให้ดึงเปลขึ้น ผู้เคลื่อนย้ายคนที่สี่ ห้า และหกดึงเชือก ในขณะที่ผู้เคลื่อนย้ายคนที่หนึ่ง สอง และสามยกเปลตามขึ้นไปอย่างช้าๆ ผู้เคลื่อนย้ายทุกคนจะต้องยกเปลขึ้นเหนือจากพื้นในขณะที่ปีนขึ้น และควรมีการเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยเพื่อป้องกันอาการอ่อนล้า



ภาพ ๔-๒๖ การประยุกต์ใช้เลื่อนขึ้นเขาเป็นขั้นๆ

๔-๑๒-๓ การประยุกต์ใช้เลื่อน (ลงเขาเป็นขั้นๆ ภาพ ๔-๒๗) ในขาลงควรใช้ทางตรงเตรียมเปลเหมือน ๔-๑๒-๑

(๑) ผู้เคลื่อนย้ายสองคนดึงเชือกเพื่อช่วยในการหย่อนเปล

(๒) ผู้เคลื่อนย้ายสามคนเข้าข้างเปล โดยให้สองคนอยู่ ด้านศีรษะ อีกหนึ่งคนอยู่ทางปลายเท้า

(๓) ผู้เคลื่อนย้ายคนที่หกอยู่ช่วยทางปลายเท้า หรือช่วยนำทีม โดย

- กำจัดสิ่งกีดขวางทาง เพื่อป้องกันไม่ให้หมู่เปลเดินซ้ำรอยเดิมไปยังหน้าผา
- ทำเส้นทางให้สะดวกโดยกำจัดเถาวัลย์หรือพุ่มไม้เล็กๆ



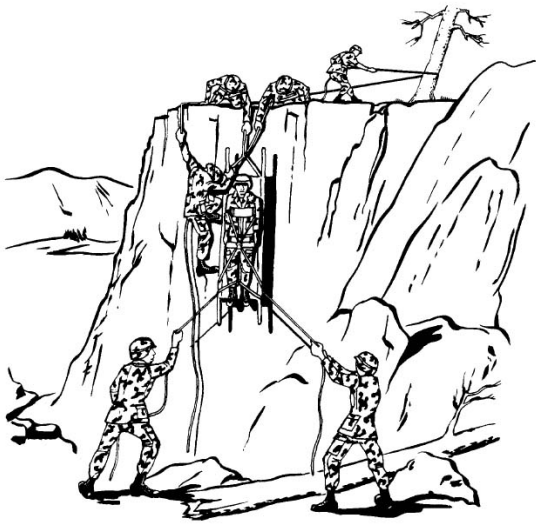
ภาพ ๔-๒๗ การประยุกต์ใช้เลื่อน ลงเขาเป็นขั้นๆ

๔-๑๒-๔ การประยุกต์ใช้เลื่อน (ลงจากหน้าผา ภาพ ๔-๒๘) ถ้าหน้าผานั้นกว้างมากหรือต้องอ้อมไกล อาจเลือกส่วนที่เรียบที่สุดในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลง โดยเตรียมเปลเลื่อน หรือใช้ เปล SKED ซึ่งจะต้องทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทำรอยบากที่เสาเพื่อใช้ในการผูกเชือก รวมทั้งป้องกันไม่ให้เชือกเสียดสีกับก้อนหิน ผูกเชือกเข้ากับห่วงใต้เปลทั้งสี่ห่วงเพื่อบังคับไม่ให้เปลหมุน

(๑) ผู้เคลื่อนย้ายคนหนึ่งผูกเชือกรอบๆต้นไม้หรือร่องหินก้อนใหญ่ ผู้เคลื่อนย้ายอีกสองคนค่อยๆหย่อนเปลผู้ป่วยลงจากขอบหน้าผา

(๒) ผู้เคลื่อนย้ายอีกคนหนึ่งไต่เชือกลงจากหน้าผาคู่ไปกับเปล และคอยระวังไม่ให้เปลติด สิ่งกีดขวาง

(๓) ผู้เคลื่อนย้ายที่เหลืออีกสองคน ดึงเชือกที่ผูกกับห่วงใต้เปลทางด้านปลายเท้าเพื่อให้เปลเลื่อนลงมายังตีนหน้าผา และรับเปลวางบนพื้น



ภาพ ๔-๒๘ การประยุกต์ใช้เลื่อนลงจากหน้าผา

๔-๑๓ การเคลื่อนย้ายโดยเลื่อนในแนวราบ

การดึงลากเลื่อนในแนวราบ (ภาพ ๔-๒๙) เป็นวิธีการส่งกลับอีกวิธีหนึ่ง ที่ต้องแยกมากล่าวถึงต่างหาก เพราะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า ใช้ในกรณีที่ความลาดชันของหน้าผาเป็นชั้นๆ หรือข้ามช่องเขาที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวอยู่เบื้องล่าง และอาจใช้กับพื้นที่บริเวณสะพานที่ถูกทำลายและมีรอยแยกกว้าง หรือใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามสิ่งกีดขวาง วิธีนี้ไม่นิยมใช้ในการส่งกลับผู้ป่วยคนเดียวหรือสองคน แต่จะใช้กับผู้ป่วยจำนวนมาก ณ จุดพักเปล

- อุปกรณ์ ได้แก่ เชือกขนาดใหญ่คล้ายสายเคเบิล คล้องต่อกันให้แน่นด้วยกุญแจสปริง สามารถขึงได้ยาวประมาณ ๑๐๐๐ ฟุต ระหว่างจุดปลายทางทั้งสองข้าง และมีความประมาณลาดเอียง ๑๐ องศา
- เปล Stoke ที่บรรทุกผู้ป่วยจะเลื่อนลงมาจากจุดปลายทางที่สูงกว่า และเปลเปล่าก็จะเลื่อนขึ้นไปจากปลายทางที่อยู่ต่ำกว่า
- เปลจากจุดปลายทางที่สูงกว่าจะเลื่อนลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก เชือกที่ผูกห้อยจากเปลจะทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายน้ำหนักให้เปลเคลื่อนที่ช้าลง ช่วยในการควบคุมการเลื่อนไหล ในขณะที่เปลเปล่าจากปลายทางด้านล่างก็จะถูกดึงขึ้นไปเพื่อรับผู้ป่วยคนใหม่
- ผู้เคลื่อนย้ายคนหนึ่งจะอยู่ที่ปลายทางด้านสูงทำหน้าที่ควบคุมเส้นทาง อีกคนหนึ่งจะอยู่ปลายทางด้านที่ต่ำกว่า คอยรับตัวผู้ป่วย
-

๔-๑๓-๑ การติดตั้ง ประกอบด้วยขั้นตอน ๔ ขั้นตอน ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามแนวทางในการเตรียมเชือกเบื้องต้น ผูกปลายเชือกมนิลาขนาด ๑๐เซนติเมตรเข้ากับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างจากหน้าผาประมาณ ๒-๓ เมตร เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอให้นายสิบพยาบาลทำงานด้วยความสะดวก

(๒) พันปลายเชือกอีกด้านหนึ่งกับวัตถุที่อยู่กับที่ เช่นต้นไม้ ก้อนหินที่มีร่อง หรือยานพาหนะทำเป็นปมที่เลื่อนได้เพื่อใช้ดึงเชือกให้ตึงตามความต้องการ เชือกที่ขึงตามขวางจะต้องมีความหย่อนตัวที่พอเหมาะโดยเฉพาะเชือกมนิลา ต้องหย่อนตัวอย่างน้อย ๕% เพื่อไม่ให้มีความตึงตัวมากเกินไปในการแขวนเปล

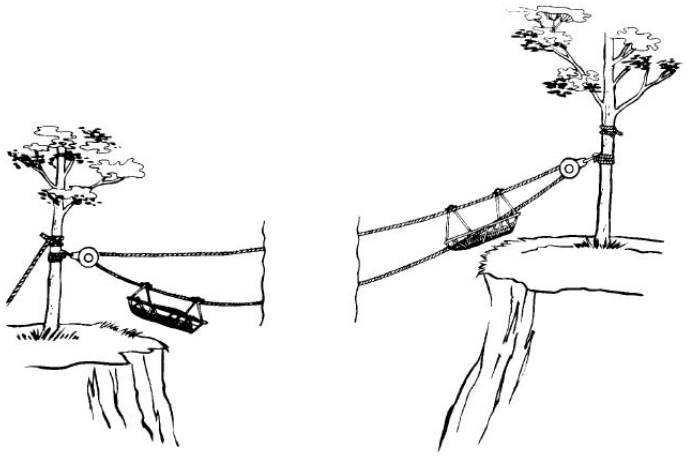
(๓) การเลื่อนเปล ใช้กุญแจสปริงสองอัน อันหนึ่งติดไว้กับเชือกที่ขึงตามขวาง และอีกอันหนึ่งติดไว้กับเชือกตามยาว ผูกเชือกเส้นล่าง และเส้นบนเข้ากับขาเปลทั้งสองข้าง และผูกปลายเชือกที่เหลือเข้าด้วยกันเหนือกึ่งกลางเปลเพื่อให้กุญแจสปริงทั้งสองอันเลื่อนตามกันอย่างสม่ำเสมอ

(๔) เมื่อบรรทุกผู้ป่วยบนเปลและใช้สายรัดผู้ป่วยให้ปลอดภัยแล้ว ยกเปลขึ้นให้สายโยงเลื่อนผ่านไปตามเชือกที่ผูกไว้อย่างมั่นคงอยู่กับขาเปลอีกด้านหนึ่ง

๔-๑๓-๒ การปฏิบัติ การลากเปลตามแนวราบ มีขั้นตอนดังนี้

(๑) ขาขึ้น ผู้เคลื่อนย้าย ๓คนสามารถยกเปลขึ้นตามยาวอย่างง่ายๆโดยดึงรอกด้านบน การดึงต้องค่อยๆ ดึงอย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้เปลเขย่า หรือแกว่ง

(๒) ขาลง ให้ดึงรอกด้านล่างอย่างเบามือ เพียงแค่ให้มีแรงเฉื่อยในการเลื่อนเปลลงตามแรงโน้มถ่วง โดยผู้เคลื่อนย้ายที่อยู่ด้านบนเป็นผู้ควบคุมความเร็วในการเลื่อนของเปล เมื่อใกล้ถึงพื้นราบ ๒-๓ เมตร อาจต้องช่วยดึงเปลตามขวางเพื่อให้เปลลงมายังจุดที่ต้องการ



ภาพ ๔-๒๙ การเคลื่อนย้ายโดยเลื่อนในแนวราบ

บทที่ ๕
เครื่องมือในการส่งกลับ

ตอนที่ ๑ รถยนต์พยาบาลกองทัพบก

๕-๑ กล่าวทั่วไป

๕-๑-๑ รถพยาบาลเป็นยานยนต์ที่ออกแบบหรือพัฒนาขึ้นมาเพื่อขนส่งผู้ป่วยในทางการแพทย์โดยเฉพาะ มีการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อยู่ในอัตราการจัดของหน่วยสนับสนุนการบริการทางการแพทย์เพื่อการส่งกลับผู้ป่วย ผู้ที่มีบาดแผล ทางภาคพื้นดิน

๕-๑-๒ รถพยาบาลประกอบด้วยพลขับ/นายสิบพยาบาล ที่ได้รับการฝึกการช่วยชีวิตฉุกเฉินเบื้องต้น ในการปฏิบัติการของรถพยาบาลแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยกำลังพลสายแพทย์ ๓ นาย คือ พลขับ ผู้ควบคุม และผู้ช่วยในการรักษาพยาบาล

๕-๑-๓ ตามอนุสัญญาเจนีวา รถพยาบาลจะต้องมีเครื่องหมายกาชาดสีแดงบนพื้นขาว การซ่อนพรางหรือการไม่แสดงเครื่องหมาย อาจเป็นสาเหตุให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญา คำแนะนำในการกำบังและซ่อนพรางหน่วยแพทย์ภาคพื้นดิน ยานยนต์และเครื่องบิน

๕-๒ รถยนต์พยาบาล

รถยนต์พยาบาลที่ได้รับการบรรจุ หรือดัดแปลงมาเป็นรถพยาบาลหมายถึงรถยนต์ รถโดยสารขนาดใหญ่ หรือรถสายพาน M113 ที่บรรทุกกำลังพลพร้อมอาวุธ

รถพยาบาลในสนามออกแบบมาเพื่อใช้กับภารกิจในสนามโดยเฉพาะ สามารถแล่นไปบนพื้นราบ ถนนรอง ทางเกวียนหรือในภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ชนบท ปฏิบัติภารกิจในส่วนหน้าของพื้นที่เขตหน้า ในการเคลื่อนที่เพื่อช่วยให้กำลังพลของหน่วยรับการสนับสนุนรอดชีวิต ซึ่งได้แก่ HMMWV (M996 และM997) และ M113 ปกติจะทำหน้าที่ส่งกลับผู้ป่วยจากเขตหน้ามายังที่พยาบาลกองพัน

๕-๓ พลขับรถพยาบาล

พลขับรถพยาบาล/อาจจะเป็นนายสิบพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบรถพยาบาลตลอดเวลา การปรนนิบัติบำรุงรถ รับผิดชอบการรายงานปัญหาสภาพความขาดแคลนที่สำคัญไปยังผู้บังคับหน่วย พลขับรถพยาบาลเป็นผู้ชำนาญเฉพาะสาขาสามารถทำการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตฉุกเฉินได้ นอกจากนั้นพลขับรถพยาบาลต้องรับผิดชอบดังนี้

- ความปลอดภัยของผู้ป่วยในความดูแล รวมทั้งการดูแลให้ผู้ป่วยปลอดภัยก่อนการบรรทุก
- แสดงความพร้อม และรับผิดชอบ โดยตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีในอัตราให้พร้อมใช้งาน ดังนี้

- เปล
- ผ้าห่ม
- เฝือกสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ทดแทน
- อุปกรณ์การให้ออกซิเจน
- ไฟฉาย
- เชื่อเพลิงสำรอง
- เครื่องมือล้างพิษ
- สิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษอื่นๆ

○ ตรวจสอบว่าได้รับข่าวสารที่จะนำไปยังจุดรับผู้ป่วย เครื่องมือ สิ่งอุปกรณ์ (รวมทั้งแผนที่ แผ่นบริวารทางยุทธวิธี แผนที่หน่วยข้างเคียง ที่ตั้งหน่วยทหาร และที่ตั้งของตำบลส่งกำลัง)

หมายเหตุ *แผนที่จะช่วยได้มาก เมื่อไปในพื้นที่โล่งที่ปราศจากเครื่องหมาย เช่น ทะเลทราย*

○ เตรียมรถพยาบาลให้พร้อมสำหรับการบรรทุกผู้ป่วยขึ้น หรือลง
○ ช่วยพลเปลในการบรรทุกผู้ป่วยขึ้น หรือลงรถ
○ ดูแลการแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์ในการบรรทุกผู้ป่วยขึ้น หรือลง
○ ขนส่งกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เลือด และผลิตภัณฑ์จากเลือด
○ ทำหน้าที่ผู้นำส่งสิ่งต่างๆในสายการแพทย์

๕-๔ การบรรทุกขึ้นและลงจากรถพยาบาล

ในการบรรทุกขึ้นและลงจากรถพยาบาล ต้องใช้เปลด้วยความระมัดระวัง รายละเอียดของการบรรทุกผู้ป่วยขึ้นหรือลงรถพยาบาลขึ้นอยู่กับเครื่องมือ จำนวนผู้ช่วยในการรักษาพยาบาล และชนิดของยานยนต์

๕-๔-๑ หลักการทั่วไป

● ยกศีรษะผู้ป่วยขึ้นไปก่อนเสมอ เพื่อป้องกันอาการ เมารถ หรืออาเจียน และลดความรำคาญจากเสียงดังขณะเปิด ปิดประตูหลัง หรือมีการกระแทกของประตูหลัง ยกเว้นผู้ป่วยบางสภาพที่ไม่แนะนำ

● ผู้ป่วยที่มีบาดแผลข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย และต้องการการพยาบาล อาจยกปลายเท้าขึ้นไปก่อนได้ เพื่อให้บาดแผลอยู่ด้านข้าง และง่ายต่อการพยาบาล ผู้ป่วยที่มีบาดแผลที่หน้าอกหรือหน้าท้อง ผู้ที่ได้รับการเข้าเฝือก ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำอาจต้องให้นอนชั้นล่าง เพื่อให้น้ำเกลือไหลตามแรงโน้มถ่วงได้สะดวก

๕-๔-๒ คำแนะนำในการบรรทุก การบรรทุกขึ้นและลงรถ พลเปลต้องได้รับการกำหนดหมายเลข และมีการใช้คำสั่ง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสามารถทำงานเป็นทีมได้

● การบรรทุกขึ้นบนรถ สำหรับการบรรทุกผู้ป่วย ๔ เปล ให้ยกเปลด้านขวาบนก่อน แล้วตามด้วยขวาล่าง ซ้ายบน และซ้ายล่าง ผู้ป่วยอาการสาหัสจะยกขึ้นหลังสุด เพื่อที่จะเป็นคนแรกที่ถูกยกลง การบรรทุกนี้ใช้หมู่เปลจำนวน ๕ นาย

● การยกผู้ป่วยลงจากรถ ทำย้อนขั้นตอนการบรรทุกขึ้นบนรถ จากหลังมาหน้า คือ ยกเปลล่างซ้าย บนซ้าย ล่างขวา และบนขวา โดยใช้หมู่เปลจำนวน ๓ นาย

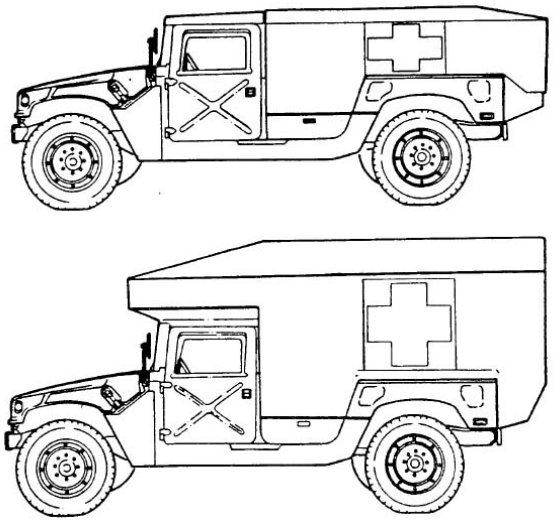
๕-๖ รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ (M996 และ M997)

รถพยาบาล M996 และ M997 เป็นรถพยาบาลที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อใช้ในสนามโดยเฉพาะ ซึ่งใช้ได้ในทุกสภาพถนน รวมทั้งการขับในยุทธบริเวณ และสามารถใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ (ภาพ ๕-๑) ขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งระบบห้ามล้อไฮดรอลิก ๔ ล้อ และยังสามารถปรับอุณหภูมิ และระบบระบายอากาศภายในตัวรถ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับรองรับเครื่องมือแพทย์ในการช่วยชีวิต (M997 สามารถติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้) การปฏิบัติการในสภาวะสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี รถยนต์พยาบาล M996 และM997 จะได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์กรองอนุภาคก๊าซ

๕-๑-๑ ขีดความสามารถในการบรรทุกผู้ป่วยเจ็บ (ตาราง ๕-๑)

๕-๑-๒ ลักษณะของการบรรทุก เปล ๒ เปล ใน M997 ลำดับการบรรทุกผู้ป่วยในตู้รถพยาบาล ให้นำเปลผู้ป่วยขึ้นติดตั้งทางด้านขวาก่อน แล้วตามด้วยด้านซ้าย ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดให้บรรทุกขึ้นรถหลังสุด เพื่อที่จะนำลงจากรถยนต์พยาบาลก่อน ส่วนลำดับขั้นตอนของการนำผู้ป่วยลง จะตรงกันข้ามขั้นตอนการบรรทุกขึ้น

หมายเหตุ *ลำดับตัวเลขที่ใช้ในการบรรยายลักษณะต่าง ๆ ของอะไหล่และอุปกรณ์ (แสดงในภาพ)*



ภาพ ๕-๑ รถบรรทุก รถพยาบาล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ M996 และ M997

๑) รางเปลผู้ป่วย (Assembling Litter rail extension: รูปที่ ๕-๒ และ ๕-๓)

(ก) หมุนหลัก (๑) ทวนเข็มนาฬิกา และเปิดประตูช่องเก็บอุปกรณ์ (๒)

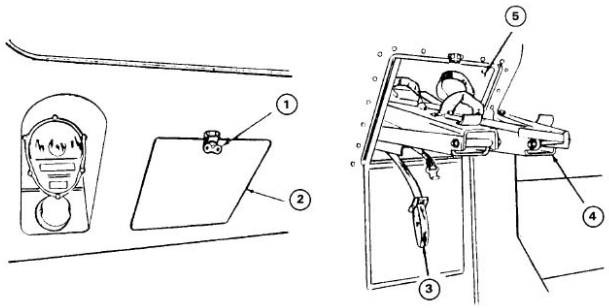
(ข) ปลดสายหนังนิรภัย (๓) ดันแผ่นเหล็กด้านบนของช่องเก็บอุปกรณ์ขึ้น จะปลดสลักช่องเก็บรางต่อเปลผู้ป่วยลงมา และดึงรางต่อเปลผู้ป่วย (๔) ซึ่งพับอยู่ออก จากช่องเก็บอุปกรณ์ (๕)

(ค) ดึงรางด้านซ้ายและขวา (๖) ให้แยกจากกัน (๑๑) และนำขาลงตั้งกับพื้น โดยให้ขาของราง(๑๒) วางเสมอกับพื้น

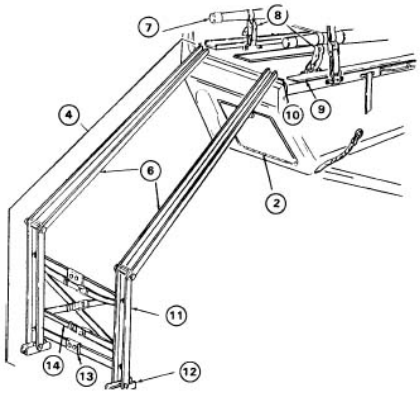
(ง) ยึดตรึงสายโยง (๑๓) และปรับสายหนัง (๑๔) ให้เหมาะสมตามความจำเป็น

ตารางที่ ๕-๑

รถบรรทุก รถพยาบาลขับเคลื่อน๔ ล้อ	
M996	M997
บรรทุกผู้ป่วยนอนได้ ๒ คน	บรรทุกผู้ป่วยนอนได้ ๔ คน
บรรทุกผู้ป่วยนั่งได้ ๖ คน	บรรทุกผู้ป่วยนอนได้ ๘ คน
บรรทุกผู้ป่วยนอนได้ ๑คน นั่งได้ ๓ คน	บรรทุกผู้ป่วยนอนได้ ๒ คน นั่งได้ ๔ คน



ภาพ ๕-๒ ส่วนประกอบของรางเปล M996



ภาพ ๕-๓ รางเปลเมื่อกางออก

๒) การติดตั้งเปลบนชั้นวาง (รูปที่ ๕-๓)

(ก) ยึดปลายรางทั้งสองข้างของส่วนต่อรางเปล (๔) ในช่องเสียบ (๑๐) บนชั้นวางเปล (๙)

(ข) วางเปล (๗) บนส่วนต่อรางเปลผู้ป่วย (๔)

คำเตือน

ต้องมั่นใจว่าสายหนังยึดเปลและอุปกรณ์ ไม่กีดขวางการบรรทุกเปลผู้ป่วยขึ้นรถ การบรรทุกผู้ป่วยขึ้นรถต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย

ค) เลื่อนไถลเปล (๗) ตามรางไปยังชั้นวางเปล (๙)

ง) ยึดเปล (๗) กับชั้นวางเปล (๙) ด้วยสายหนังยึดหัวท้าย (๘)

๓) การนำเปลลงจากชั้นวางเปล (รูปที่ ๕-๓)

ก) คลายสายหนังยึดเปลหัว-ท้าย (๘) ซึ่งยึดติดเปล (๗) กับชั้นวางเปล (๙)

ข) ยึดรางทั้งสองข้าง (๖) ของรางเปลผู้ป่วย (๔) ในช่องเสียบ (๑๐) บนชั้นวางเปลล่าง (๙)

ค) เลื่อนไถลเปล (๗) จากชั้นวางเปลอันล่าง (๙) ไปบนส่วนต่อรางเปล (๔) ยกและเคลื่อนเปล (๗) จากส่วนต่อรางเปล (๔)

๔) การพับเก็บส่วนต่อรางเปล (รูปที่ ๕-๒ และ ๕-๓)

ก) ปลดสายโยง (๑๓)

ข) พับรางซ้าย-ขวา (๖) เข้าหากัน

ค) พับขาตั้งรางเปลซ้าย-ขวา (๑๑) และ กางส่วนเท้าของขาตั้ง (๑๒)

ง) เก็บส่วนต่อรางเปลที่พับแล้ว (๔) ในช่องเก็บอุปกรณ์ (๕) ยึดด้วยสายรัด (๓)

จ) ปิดประตู (๒) และหมุนสลัก (๑) ตามเข็มนาฬิกา

๕) การกางที่นั่งสำหรับผู้ป่วยนั่ง (รูปที่ ๕-๔ และ ๕-๕)

ก) ต้องมั่นใจว่าเปลอยู่ในตำแหน่งพับเก็บเรียบร้อย

ข) ดึงสลักยึดที่นั่งและพับที่รองพนักพิง (๒) ในช่องของระหว่างเบาะที่นั่ง

ค) สายโยงที่นั่งจะต้องกางออกจนตึงและถูกยึดแน่น

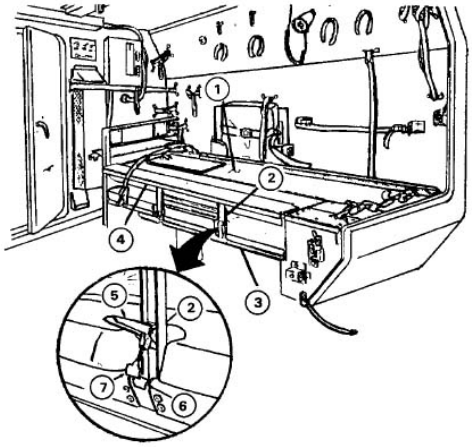
๖) การเก็บที่นั่งผู้ป่วย

ก) กดปุ่มล๊อก (๑๒) บนสายโยงที่นั่ง (๘) พับเก็บสายโยงไปทางพนักพิง (๔)

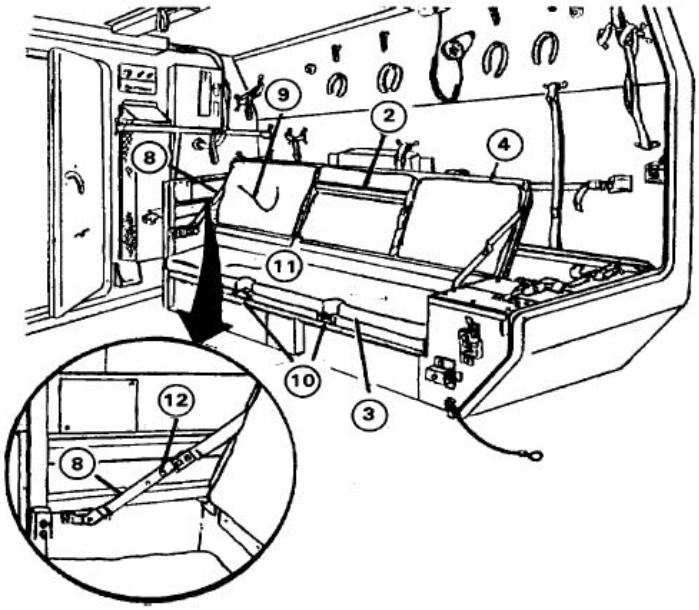
ข) พับที่รองพนักพิง (๒) ออกและพับเก็บพนักพิง (๔) และ โดยให้หมุด (๑๑) บนที่รองพนักพิงเข้าในรูใต้ฐานที่นั่งพอดี

ค) เก็บพนักพิง (๔) ในฐานที่นั่ง (๓) ด้วยสลักยึด (๗), (๕) และปรับสลักยึดที่นั่ง (๗) ให้มีความยาวเหมาะสม ได้โดยหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกาถ้าจำเป็น

๕-๑-๓ ลักษณะการบรรทุกเปล ๔ เปลบน M997



ภาพ ๕-๔ ชั้นใส่เปลและตำแหน่งของที่นั่งขณะพับเก็บ



ภาพ ๕-๕ ชั้นใส่เปลและตำแหน่งของที่นั่งขณะกางออก

ลำดับของการบรรทุกเปลผู้ป่วย ๔ เปล ให้เริ่มจาก บนขวา-ล่างขวา-บนซ้ายและล่างซ้าย ผู้ป่วยหนัก จะต้องขึ้นบรรทุก ทีหลังสุดเพื่อที่จะสามารถนำออกจากรถพยาบาลได้ก่อน

ในทางตรงกันข้าม ลำดับของการเคลื่อนย้ายเปลฯ ผู้ป่วยลง ให้ย้อนกลับจากกระบวนการบรรทุก กล่าวคือ เริ่มจาก ล่างซ้าย-บนซ้าย-ล่างขวา และ บนขวา ในกรณีที่มีผู้ป่วย ๒ เปล ให้บรรทุกในตำแหน่ง บน และล่างขวา ของตัวรถ โดยปล่อยให้ด้านซ้ายของตัวรถว่างสำหรับบรรทุกผู้ป่วยนั่งหรือเพิ่มเติมเปลผู้ป่วย

หมายเหตุ เมื่อต้องรับผู้ป่วยจากหลาย ๆ ที่ การบรรทุกผู้ป่วยจากบาดเจ็บน้อยที่สุดไปยังบาดเจ็บมากที่สุด อาจไม่สามารถปฏิบัติได้ ในกรณีนี้การขนย้ายผู้ป่วยลงจากรถ จะต้องคำนึงถึงความรุนแรง *ของอาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยอาการหนักจะต้องได้รับการขนย้ายลงจากรถก่อน*

คำเตือน เมื่อบรรทุกผู้ป่วยนอนมากกว่า ๒ คน ให้บรรทุกเปลชั้นบนให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ป่วยเปลล่างขณะบรรทุกผู้ป่วยเปลบน

(๑) การเตรียมชั้นวางเปลชั้นบน (รูปที่ ๕-๖)

ก.) ปลดขอเกี่ยวสายโยง (๒๓) จากห่วงฟุตแมน (๓๐) บนชั้นวางเปลชั้นล่าง (๙)

ข.) ดึงหูจับ (๑๗) และแผ่นพื้น (๒๑) ของชั้นวางเปลบนออก

คำเตือน ปลายด้านหลังของ เปล ชั้นบนจะต้องได้รับการรองรับไว้ก่อนที่จะปลดตะขอที่แขวน เนื่องจากหากไม่ได้รองรับน้ำหนักไว้อาจจะเป็นอันตรายต่อกำลังพลได้

ค.) ปลดตะขอที่แขวน (๒๗) จากห่วง (๒๒) บนชั้นวางเปล (๒๑) แล้วเกี่ยวตะขอ (๒๗) เข้าหาที่เกี่ยว (๒๖)

ง.) คลายสลักที่รองรับเตียง (๒๕) ดันสลัก (๒๔) เข้า และปรับชั้นวางตัวบนลงมาบนชั้นวางเปลตัวล่าง

จ.) เลื่อนที่จับรางเปล (๑๗) ไปบนรางเปลชั้นบน (๒๑)

(๒) การประกอบส่วนต่อรางเปล (รูปที่ ๕-๓ และ ๕-๗)

ก.) หมุนสลัก (๑) ทวนเข็มนาฬิกา และเปิดช่องเก็บอุปกรณ์ (๒)

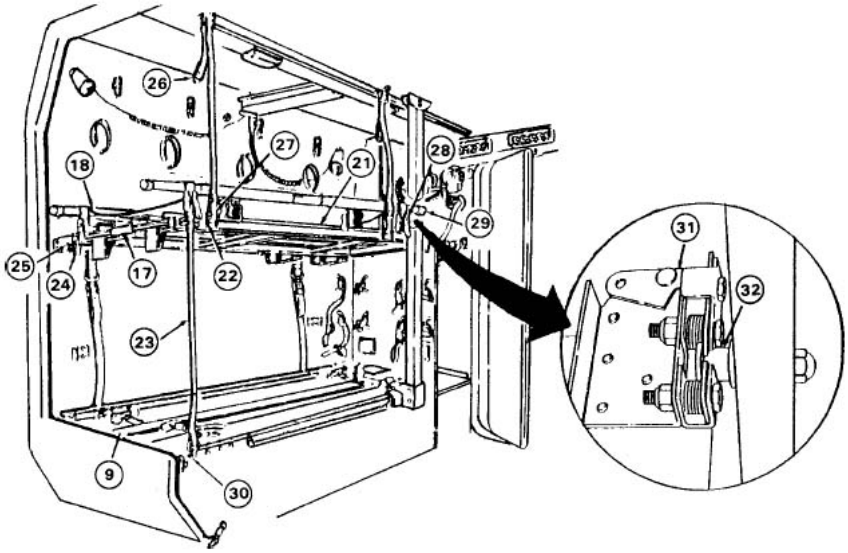
ข.) คลายสายรัด (๓) และ นำเอาส่วนต่อรางเปล (๔) ออกจากช่องเก็บอุปกรณ์ (๕)

ค.) ยกถาด (๑๕) ขึ้นเล็กน้อย และดันขาตั้ง (๑๖) เข้าไปใต้ถาด (๑๕) เพื่อเก็บเตียงไว้

ง.) ดึงรางซ้าย-ขวา ออกจากกัน โดยกางขา (๑๑) ออก และตรวจสอบให้มั่นใจว่าส่วนฐานของราง (๑๒) วางราบเสมอกับพื้น

จ.) ยึดสายโยงให้แน่นและปรับสายให้เหมาะสม

(๓) การบรรทุกเปลบนชั้นวางเปลอันบน (รูปที่ ๕-๖ และ ๕-๘)

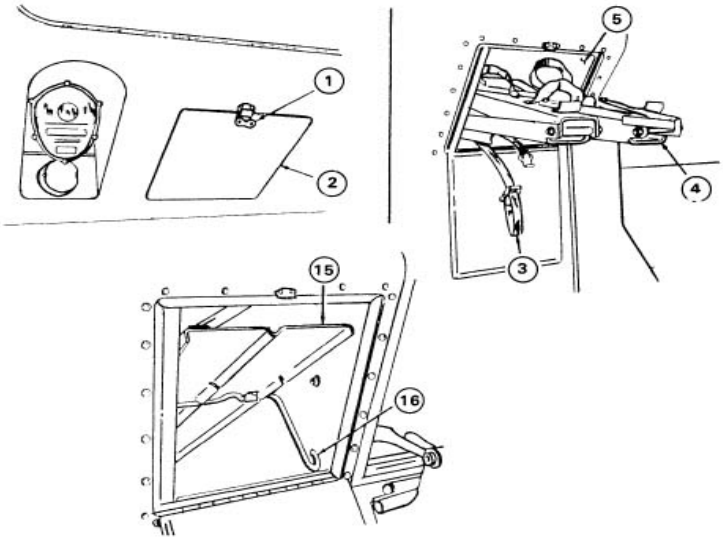


ภาพ ๕-๖ ภาพด้านในของรถพยาบาล M997

ก.) ยึดรางของส่วนต่อรางเปล (๔) ในช่องเสียบในชั้นวางเปลชั้นบน (๒๑)

ข.) วางเปล (๑๘) บนส่วนต่อรางเปล (๔)

ค.) เลื่อนเปล (๑๘) บนรางจนกระทั่งเปลพ้นจากส่วนต่อรางเปล (๔)



ภาพ ๕-๗ รางเปลและการกางรางเปลของรถพยาบาล M997

ง.) ยึดคานเปลด้านหลัง (๑๙) กับชั้นวางเปลบน (๒๑) ด้วยสายยึดคานเปลหลัง (๒๐)

จ.) ปลดส่วนต่อรางเปล (๔) ออกจาก ชั้นวางเปลบน (๒๑)

ฉ.) ปลดขอเกี่ยว (๒๗) จากที่เกี่ยว (๒๖)

ช.) ยกรางเปลบน (๒๑) แล้วดันเข้าไปในสลักยึดเตียง (๒๔) และยึดตรึงด้วยสลักยึด (๒๕)

ซ.) เกี่ยวขอแขวน (๒๗) ที่ห่วง (๒๒) บนชั้นรางเปลบน (๒๑)

ฌ.) ยึดคานเปลด้านหน้า (๒๙) กับชั้นวางเปลบน (๒๑) ด้วยสายรัดคานเปลด้านหน้า (๒๘)

ญ.) เกี่ยวสายโยง (๒๓) กับห่วง (๓๐) บนชั้นวางเปลล่าง (๙) และปรับสาย

ฎ.) เลื่อนด้ามจับรางเปล (๑๗) ไปในชั้นวางเปลบน (๒๑)

(๔) การบรรทุกเปลบนรางเปลล่าง (รูปที่ ๕-๓)

ก.) ยึดรางทั้งสอง(๖) ของส่วนต่อรางเปล (๔) ในช่องเสียบ (๑๐) บนชั้นวางเปลล่าง (๙)

ข.) วางเปล (๗) บนส่วนต่อรางเปล (๔)

ค.) เลื่อนเปล (๗) ไปตามชั้นวางเปลล่าง (๙)

ง.) ยึดเปล (๗) ชั้นวางเปลล่าง (๙) ด้วยสายยึดคานเปลหน้า-หลัง (๘)

คำเตือน
๑. เมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอน มากกว่า ๒ คน ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเปลล่างลงก่อน ๒. ตรวจสอบสายรัดและอุปกรณ์ต่าง ๆไม่ให้ขัดขวางการขนย้ายผู้ป่วยลง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วย

(๕) การนำเปลลงจากรางเปลล่าง (รูปที่ ๕-๓)

ก.) คลายสายหนังยึดคานเปลหน้า-หลัง (๘) ซึ่งยึดเปล (๗) กับชั้นวางเปลล่าง (๙)

ข.) ยึดรางทั้งสอง(๖) ของส่วนต่อรางเปล (๔) ในช่องเสียบ (๑๐) บนชั้นวางเปลล่าง (๙)

ค.) เลื่อนเปล (๗) ไถลจากชั้นวางเปลล่าง (๙) ไปบนส่วนต่อรางเปล (๔) ยกและเอาเปล (๗) ออกจากส่วนต่อรางเปล (๔)

(๖) การนำเปลลงจากชั้นวางเปลบน (รูปที่ ๕-๖ และ ๕-๘)

ก.) คลายสายหนังยึดคานเปลหน้า (๒๘) จากคานเปล (๒๙)

ข.) ปลดตะขอ (๒๓) จากห่วง ฟุตแมน (๓๐) บนชั้นวางเปลล่าง (๙)

ค.) ดึงที่จับรางเปลบน (๑๗) ออก และพยุงน้ำหนักของชั้นวางเปลบน (๒๑)

ง.) ปลดตะขอตัวหลัง (๒๗) จากห่วง (๒๒) บนชั้นวางเปลบน (๒๑) เกี่ยวตะขอ (๒๗) เข้ากับห่วง (๒๖)

จ.) ปลดกลอนยึดเปล (๒๕) ดันกลอน (๒๔) เข้าข้างใน และดันด้านล่างของชั้นวางเปลบน (๒๑) ไปบนชั้นวางเปลด้านล่าง (๙)

ฉ.) เลื่อนที่จับคานเปล (๑๗) เข้าไปในชั้นวางเปลบน (๒๑)

ช.) ยึดรางของส่วนต่อรางเปล (๔) เข้าในช่องเสียบในชั้นวางเปลบน (๒๑)

ซ.) คลายสายหนังยึด เปลตัวหลัง (๒๐) จากที่จับคานเปล (๑๙)

ฌ.) เลื่อนเปล (๑๘) ลงตามส่วนต่อรางเปล (๔) จนกระทั่งเปล ออกจากชั้นวางเปลบน (๒๑)

ญ.) ยกและเคลื่อนเปล (๑๘) จากส่วนต่อรางเปล (๔)

ฎ.) ถอดส่วนต่อรางเปล (๔) ออกจากชั้นวางเปลบน (๒๑)

(๗) การพับและเก็บส่วนต่อรางเปล (รูปที่ ๑๐-๓ และ ๑๐-๗)

ก.) ปลดสายโยง (๑๓)

ข.) พับรางด้านซ้ายและขวา (๖) เข้าหากัน

ค.) พับขารางเปลซ้าย และขวา (๑๑) และส่วนฐาน (๑๒) ไปทางตรงข้ามกับราง (๖)

ง.) ยกถาด (๑๕) และดันที่รองถาด (๑๖) เข้าด้านในทางด้านล่างของถาด (๑๕)

จ.) เลื่อนไถลเปลเข้าไปในช่องเก็บอุปกรณ์ (๕) บนด้านบนของถาด (๑๕) ดึงที่รองถาด (๑๖) ในตำแหน่งที่ทำให้ถาด (๑๕) ยกขึ้น

ฉ.) วางส่วนต่อรางเปล (๔) ที่พับแล้วเข้าไปในช่องเก็บ (๕) และยึดด้วยสายยึด (๓)

ช.) ปิดประตู (๒) และหมุนกลอน (๑) ตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิดประตู (๒)

(๘) การพับ เก็บชั้นวางเปลบนเพื่อเป็นพนักพิงหลัง (รูปที่ ๑๐-๖)

ก.) ปลดตะขอของสายยึดเปล (๒๓) จากห่วงฟุตแมน (๓๐) ของชั้นวางเปลล่าง

ข.) ปลดตะขอ (๒๗) ทั้งสองตัวของสายยึดชั้นวางเปลบนจากห่วง (๒๒) บนชั้นวางเปลบน (๒๑) แล้วค่อยใส่ตะขอ (๒๗) กลับเข้าไปในห่วง (๒๖)

ค.) ปลดกลอนยึดชั้นวางเปล-บน (๓๑) และแยกตัวเกี่ยว (๓๒) จากกลอน (๓๑)

ง.) พับเก็บชั้นวางเปล (๒๑) ลงด้านล่าง บนชั้นวางเปลล่าง (๙) ก็จะกลายเป็นพนักพิง

(๙) การกางพนักพิงหลังให้เป็นชั้นวางเปลบน (รูปที่ ๕-๖)

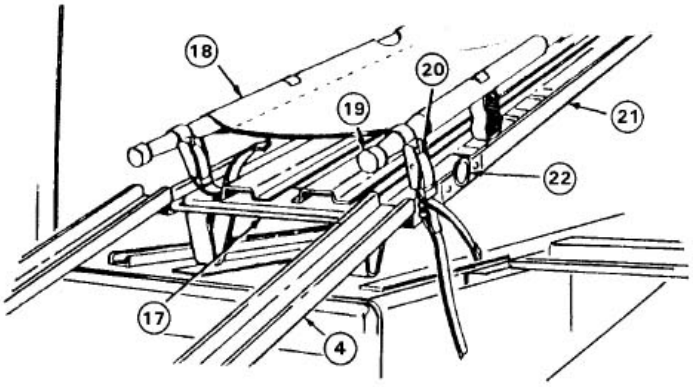
ก.) ยกชั้นวางเปลบน (๒๑) ขึ้น และยึดตัวเกี่ยว (๓๒) กับกลอนยึดชั้นวางเปล (๓๑) สอดที่เกี่ยว (๓๒) กับกลอนให้แน่น ตรวจดูให้แน่ใจว่า ที่เกี่ยว (๓๒)

ข.) ยึดแน่นกับกลอน (๓๑) แล้ว

ค.) ปลดตะขอทั้งสองอันของสายยึดชั้นวางเปล (๒๗) ออกจากห่วง (๒๖) และเกี่ยวเข้ากับห่วง (๒๒) บนชั้นวางเปลบน (๒๑)

ง.) เกี่ยวสายยึดชั้นวางเปลบน (๒๓) กับห่วงฟุตแมน (๓๐) บนชั้นวางเปลล่าง (๙)

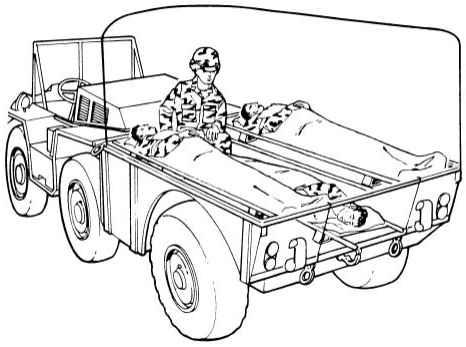
จ.) ปรับสายยึด (๒๓ และ ๒๗) ให้ตึงพอดี



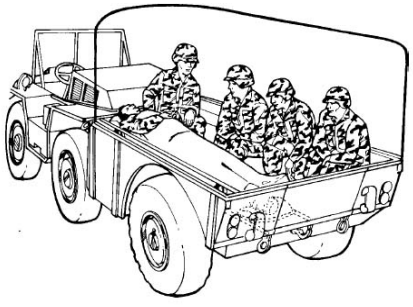
ภาพ ๕-๘ ชั้นวางเปลชั้นบน

๕-๗ รถบรรทุกพยาบาล ๑ ๑/ ๔ ตัน ขับเคลื่อน ๖ ล้อ M792

รถบรรทุกพยาบาล ๑ ๑/ ๔ ตัน M792 สามารถบรรทุกผู้ป่วยนอน ได้ ๓ เปล และนายสิบพยาบาล (ภาพ ๕-๙) หรือ ผู้ป่วยนอน ๒ เปล นั่ง ๓ คน และ นายสิบพยาบาล หรือ ผู้ป่วยนั่ง ๖ คน เนื่องจากเป็นรถที่แล่นได้เร็ว เปลทุกเปลต้องมัดแน่นกับที่ยึดเปลในรถ การบรรทุกต้องใช้หมู่เปล ๒ นาย โดย เริ่มจากบนขวา บนซ้าย และข้างล่าง และการขนลงทำย้อนขั้นตอนบรรทุกขึ้น



ภาพ ๕-๙ รถบรรทุกพยาบาล ๑ ๑/ ๔ ตัน M792
บรรทุกผู้ป่วยนอน ๓ คนและนายสิบพยาบาล



ภาพ ๕-๑๐ รถบรรทุกพยาบาล ๑ ๑/ ๔ ตัน M792

บรรทุกผู้ป่วยนอน ๑คน นั่ง ๓ คน และนายสิบพยาบาล

๕-๘ รถสายพานลำเลียง หุ้มเกราะ M113 T113E2

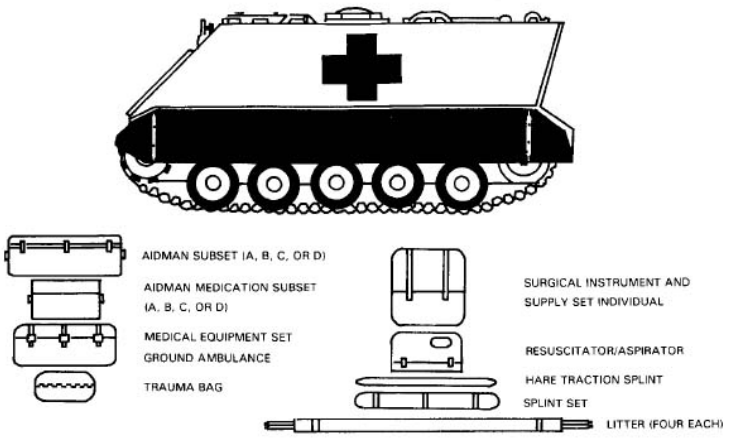
รถสายพานลำเลียงหุ้มเกราะ M113 (ภาพ ๕-๑๑) เป็นรถส่งกลับมาตรฐาน ซึ่งติดอาวุธเบา เพื่อใช้ในการปกป้องผู้ป่วยจากการโจมตีด้วยกำลังขนาดเล็ก ขับเคลื่อนไปข้างหน้าและหมุนซ้ายขวา มีโครงสร้างของตัวรถต่ำ การสวมหมวกเหล็กในรถจะช่วยปกป้องอันตราย โดยเฉพาะเมื่อรถวิ่งอยู่ในพื้นที่ขรุขระ นอกจากนั้นยังมีลักษณะอื่นๆ ดังนี้

- เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่วิ่งได้บนพื้นดินในชนบท และในลำธาร
- วิ่งตามพื้นที่ขรุขระข้ามประเทศได้
- วิ่งได้เร็วบนถนนที่ได้รับการปรับปรุง หรือบนทางด่วน

รถสายพานลำเลียง หุ้มเกราะ M113 สามารถบรรทุกผู้ป่วยนั่งได้ ๑๐ คน และมีกล่องอุปกรณ์ในการปรับให้บรรทุกผู้ป่วยนอนได้ ๔ คน

การบรรทุกผู้ป่วยขึ้น และลงรถ ต้องใช้พลเปลจำนวน ๔ นาย มีลำดับการบรรทุก ดังนี้ บนขวา ล่างขวา บนซ้าย และล่างซ้าย ตามลำดับ

ข้อควรระวัง *เปลจะไม่ปลอดภัยหากไม่มีการติดตั้งเครื่องมือในการปรับเพื่อวางเปลจำเป็นต้องปลดชิ้นส่วนบางอย่างออก*



ภาพ ๕-๑๑ ภาพ รถสายพานลำเลียงหุ้มเกราะ M113 และสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตอนที่ ๒ การส่งกลับทางการแพทย์โดยไม่ใช้รถทางการแพทย์

๕-๙ กล่าวทั่วไป

บ่อยครั้งที่ไม่มีรถพยาบาลในยุทธบริเวณ หรือมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถส่งกลับผู้ป่วยในสภาพภูมิประเทศเฉพาะได้ จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะชนิดอื่นในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ต้องมีการดัดแปลงหรือดัดแปลงบางส่วน

หมายเหตุ *หน่วยจะต้องพิจารณาร่องหรือโครงที่จะใช้ในการวางเปลเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในรถที่ไม่ใช่รถพยาบาล*

บางครั้งอาจใช้เส้นทางและบุคลากร ที่สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งขีดความสามารถในการบรรทุกก็จะแตกต่างกันออกไป

เมื่อผู้บาดเจ็บเข้ามาสู่ระบบการบริการทางการแพทย์ ก็จะจัดว่าเป็นผู้ป่วย ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลระหว่างการส่งกลับ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ได้รับการเคลื่อนย้ายด้วยรถที่ไม่ใช่รถพยาบาลและไม่มีการให้การรักษาพยาบาลขณะเดินทาง ผู้ป่วยไม่อยู่ในสายการส่งกลับทางการแพทย์ คงเป็นเพียงการขนส่งเท่านั้น

๕-๑๐ การขนส่งและการส่งกลับผู้ป่วยในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่

เพื่อให้สามารถสนองตอบภารกิจการส่งกลับ หรือการขนส่งผู้ป่วย ผู้วางแผนทางการแพทย์จะต้องวางแผนเผชิญเหตุในภาวะมีผู้ป่วยจำนวนมากไว้ล่วงหน้า ดังนี้

- สิ่งที่ต้องระบุในแผนเผชิญ ได้แก่
  - เครื่องมือในการขนส่งที่ไม่ใช่สายแพทย์
  - ทีมในการยกเปลผู้ป่วยที่ไม่ใช่สายแพทย์
  - เส้นทางการส่งกลับ
  - จุดแลกเปลี่ยนผู้ป่วย
  - กำลังพลสายแพทย์ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยในรถที่ไม่ใช่รถพยาบาลระหว่างทาง
  - ขีดความสามารถและที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์
  - การสื่อสารความถี่ และนามเรียกขาน ด้านการข่าว
  - ขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์
- บุคคลสำคัญในการประสานงานการใช้รถที่ไม่ใช่รถพยาบาลในการส่งกลับทางการแพทย์หรือการขนส่งผู้ป่วย

เมื่อระบบการส่งกลับทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ ยานพาหนะ ภาคพื้นดินทุกชนิดจะได้รับการพิจารณาในการสนธิกำลังร่วมกับสิ่งอุปกรณ์ในการส่งกลับทางการแพทย์ฉุกเฉิน กุญแจแห่งความสำเร็จ คือ การระบุยานพาหนะ คนขับ นายสิบพยาบาล หรือผู้กู้ชีพในสนาม ซึ่งสามารถติดตาม

ไปกับผู้ป่วยได้ การประสานเพื่อให้บรรลุภารกิจเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการมากกว่าการรอให้เกิดสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเจ็บจำนวนมาก และลักษณะของยานพาหนะก็จะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่หน่วยที่ให้การสนับสนุน ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ รถบรรทุกขนาดกลาง

สภาพภูมิประเทศในเขตยุทธบริเวณ การติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายเสนาธิการด้านกิจการพลเรือนจะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่มี ซึ่งอาจรวมอยู่ในแผนปฏิบัติการแล้วก็ได้ สิ่งของบางอย่างที่อาจมีไว้สนับสนุน ได้แก่

- รถโดยสาร
- เรือ หรือยานพาหนะทางน้ำ
- รถขนส่งสินค้าของพลเรือน

โอกาสที่จะใช้รถที่ไม่ใช่รถพยาบาลในการส่งกลับมีมาก ดังนั้นการจัดกำลังพลไปกับรถเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งกลับร่วมกับกำลังพลสายแพทย์ รวมทั้งการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรถ จำเป็นต้องมีการวางแผน และการประสานงานที่ดี มีการจัดชุดรักษาพยาบาลชุดเล็กๆที่ประกอบด้วยทีมรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ๔ นาย พร้อมด้วยสิ่งอุปกรณ์ในอัตรากองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนหน้า กองร้อยสนับสนุนส่วนหลัก และ กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนเป็นพื้นที่ ผู้บริหารของหน่วยสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ต้องวางแผนนำหน่วยแพทย์เล็กๆดังกล่าวนี้มาใช้เป็นการชั่วคราว ทำฝึกการช่วยชีวิตในสนามเพื่อให้สามารถส่งกำลังพลไปช่วยดูแลผู้ป่วย รักษาชีวิตตลอดจนป้องกันความพิการที่อาจเกิดขึ้น

การบริหารจัดการการส่งกลับทางการแพทย์โดยรถที่ไม่ใช่รถพยาบาลเป็นเรื่องที่ควบคุมยาก ปกติแล้วการส่งกลับที่เกินความจำเป็นสามารถควบคุมได้ โดยการแยกประเภทผู้ป่วย ความรับผิดชอบในการส่งกลับมีความสำคัญมาก หากละเลยการควบคุมกำกับดูแลและไม่มีการคัดแยกผู้ป่วยตามลักษณะทางแพทย์เพื่อการส่งกลับ จะเป็นผลให้อัตราการตายของผู้บาดเจ็บสูงขึ้น หรือมีการส่งกลับทหารที่สามารถส่งคืนไปปฏิบัติหน้าที่มากเกินความจำเป็น ผู้ป่วยกลุ่มเร่งด่วน เร่งด่วนเพื่อการผ่าตัดต้องได้รับการส่งกลับก่อนกลุ่มเร่งรีบหรือกลุ่มธรรมดา ในขณะเดียวกันต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นจนเปลี่ยนเป็นกลุ่มเร่งด่วน หรือเร่งด่วนเพื่อการผ่าตัด วิถีทางแรกในการส่งกลับผู้ป่วยกลุ่มเร่งด่วน หรือเร่งด่วนเพื่อการผ่าตัด คือ เครื่องบินพยาบาล แต่ถ้าเป็นการส่งกลับทางภาคพื้นดินผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินอาการบ่อยๆ เพื่อให้มั่นใจว่าอาการจะไม่ทรุดลงจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ผู้วางแผนควรพิจารณาและประสานไปกับแผนยุทธการในการใช้เครื่องมือในการส่งกลับทางเครื่องบินที่ไม่ใช่สายแพทย์ จัดรถพยาบาลเพื่อส่งกลับผู้ป่วยกลุ่มเร่งรีบ และใช้รถที่ไม่ใช่รถพยาบาลส่งกลับผู้ป่วยกลุ่มธรรมดาในกรณีที่ไม่มีรถพยาบาล ทุกๆส่วนจะต้องร่วมมือในการจัดกำลัง และเครื่องมือสำหรับรถที่ไม่ใช่รถพยาบาลร่วมกับกำลังพลสายแพทย์แม้จะเป็นเพียงการส่งกลับผู้ป่วยกลุ่มธรรมดา

ผนวก ก
ขั้นตอนสำหรับการฝึกฝนการส่งกลับด้วยเปล

ก-๑ กล่าวทั่วไป

เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งด้วยเปลไม่ให้มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นจากการยกเปลที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นพลเปลจึงต้องมีการฝึกฝน ในผนวกนี้เป็นการอธิบายขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งเทคนิคในการยกเปลที่จำเป็นเพื่อช่วยในการส่งกลับ

ก-๒ พื้นฐานของการฝึกพลเปล

โดยปกติพลเปลจะอยู่ในรูปแบบเป็นหมู่ๆละ ๔ นาย ดังนั้นการยกเปลที่มีประสิทธิภาพจำต้องมีการฝึกฝน โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

- โดยทั่วไปจะมีการฝึกเป็นรายบุคคล และ เป็นหมู่เปล ในแต่ละหมู่อาจจะถูกแยกฝึกโดยครูฝึก
- ในขั้นตอนเริ่มต้นการฝึก จะฝึกเปลเปล่าๆ เพื่อให้พลเปลมีความคุ้นเคยกับเปล
- ขั้นตอนถัดมา จะมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ป่วยเจ็บ
- การฝึกให้เสมือนจริงจะมีการฝึกสำหรับการบาดเจ็บในหลายๆรูปแบบ ผู้ป่วยเจ็บอาจจะใส่ชุดฝึก ผ้าพันแผล และ เฝือก
- ผู้ป่วยสมมติอาจจะถูกกำหนดให้อยู่ตามที่ต่างๆบนพื้นดิน ในตำแหน่งที่หันศีรษะให้เปล หันเท้าให้เปล การฝึกจะกระทำในท่าต่างๆ ท้ายสุดอาจจะให้มีการกระจายผู้ป่วยเจ็บอยู่ทั่วไป

ก-๓ คำสั่งในการยกเปล

ขั้นตอนในการยกเปลไม่จำเป็นต้องกระทำเหมือนกับการฝึกฝน เพราะในขั้นตอนการยกจริงจะถูกกำหนดจากผู้นำทีม โดยมีคำสั่งเตรียมพร้อม การเคลื่อนย้ายหรือ รูปแบบในการยกจะกระทำเมื่อได้รับคำสั่งให้กระทำ สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เปลสำหรับการบาดเจ็บแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน

หมายเหตุ *การใช้คำสั่งในการยกสำหรับการฝึกฝน และ การใช้ไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะต้องใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสนาม*

ก-๔ รูปแบบของการฝึก

ขั้นตอนแรก ผู้เข้ารับการฝึกจะยืนเรียงแถว หลังจากนั้นจึงออกคำสั่งไปยังหมู่เปล

ก. ผู้เข้ารับการฝึก จะนับจาก ๑ ถึง ๔ โดยนับจากข้างหน้าไปข้างหลัง หลังจากนั้นจะทำกา จัดเป็นหมู่เปล ในแต่ละหมายเลขจะยืนในตำแหน่งที่เฉพาะตัว จะมีหน้าที่รับผิดชอบตาม หมายเลข โดยที่หมายเลข ๑ คือ ผู้นำหมู่เปล

ข. ผู้นำหมู่เปลจะนับจากขวา มายัง ซ้าย เป็นการกำหนดหมายเลขให้แต่ละคน

ค. หลังจากที่จัดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว จัดบริเวณให้มีที่เพียงพอกับการฝึก

ง. ในสถานการณ์ที่จำเป็นอาจจะต้องใช้พลเปล ๒ นาย ในการยกเปล คำแนะนำจะรวม ตั้งแต่ขั้นตอนของการลดจำนวนพลเปล และ การใช้พลเปลหมายเลข ๒ และ ๓

ก-๕ ขั้นตอนของการเตรียมตัว การวางเปล การคลี่เปล การม้วนเปล และ การเก็บเปล

ก. การเตรียมเปล คำสั่งในการเตรียมเปล ผู้นำหมู่เปล (หมายเลข ๑) จะยืนอยู่ด้านหน้า เดินไปยังที่ให้รวมเปล หยิบเปลขึ้นมา และ ส่งคืนเปลยังตำแหน่งที่มีหมายเลข ๒ ๓ และ ๔ ยืนอยู่

(๑) ยืนให้ใกล้เปล ในตำแหน่งที่อยู่สูง ยกเว้นในกรณีที่อยู่ใกล้กับเฮลิคอปเตอร์ต้องรักษาระดับให้อยู่ห่างจากใบพัด การยกเปลจะยกให้เปลทำมุมกับลำตัวโดยใช้มือซ้ายจับอยู่ที่ทาวด้านบนใกล้กับหัวไหล่ มือขวาอยู่ใกล้กับสะโพก ตามภาพ ต-๑



Figure J-1. Carrying litter at high port.

ภาพ ก-๑ การถือเปลให้อยู่ในตำแหน่ง

(๒) หลังจากที่หมายเลข ๑ เดินกลับไปยืนในตำแหน่งเดิมแล้ว เขาจะถือเปลไว้ในตำแหน่งตั้ง และ ถือเปลไว้ที่ด้านซ้ายมือ ตามภาพ ก-๒



Figure J-2. Litter squad with litter.

ภาพ ก-๒ หมู่เปล พร้อมด้วยเปล

ข. การวางเปล เมื่อมีคำสั่งวางเปล หมายเลข ๑ จะทำการวางเปลลงต่ำโดยการก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าว และ วางเปลต่ำลงบนพื้น ตามภาพ ก-๓ คำสั่งประจำที่สำหรับพลเปลอีกสามนายจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งของตัวเอง หมายเลข ๒ จะเคลื่อนที่ไปยังด้านหน้าขวา หมายเลข ๓ จะเคลื่อนที่ไปยังด้านหลังซ้าย และ หมายเลข ๔ จะเคลื่อนไปยังด้านหน้าซ้าย ตามภาพ ก-๔



Figure J-3. Grounding litter (step one).

ภาพ ก-๓ การวางเปลลงบนพื้น (ขั้นตอนที่หนึ่ง)



Figure J-4. Grounding litter (step two) (position of Litter, POSTS).

ภาพ ก-๔ การวางเปลลงบนพื้น (ขั้นตอนที่สอง)

ค. การคลี่เปล เมื่อมีคำสั่งคลี่เปล พลเปลทั้งหมดจะหันหน้าเข้าหาเปล และ ทำตามคำสั่ง พลเปลหมายเลข ๑ และ ๔ จะทำการคลายสายรัดเปล ตามภาพ ก-๕ พลเปลหมายเลข ๒ และ ๓ จะทำการขยายเปลโดยการดึงด้ามจับขึ้น หมายเลข ๒ จะทำการใช้เท้า ส่วนหมายเลข ๓ ใช้มือยก

จนกระทั่งเปลอยู่ในแนวตั้ง การใช้เท้า หมายเลข ๓ จะกระทำโดยการขยายส่วนแท่นด้านล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ล็อก กลับเปล และ ขยายส่วนแท่นอีกด้าน หมายเลข ๓ จะทำการวางเปลบนพื้น ตามภาพ ก-๖

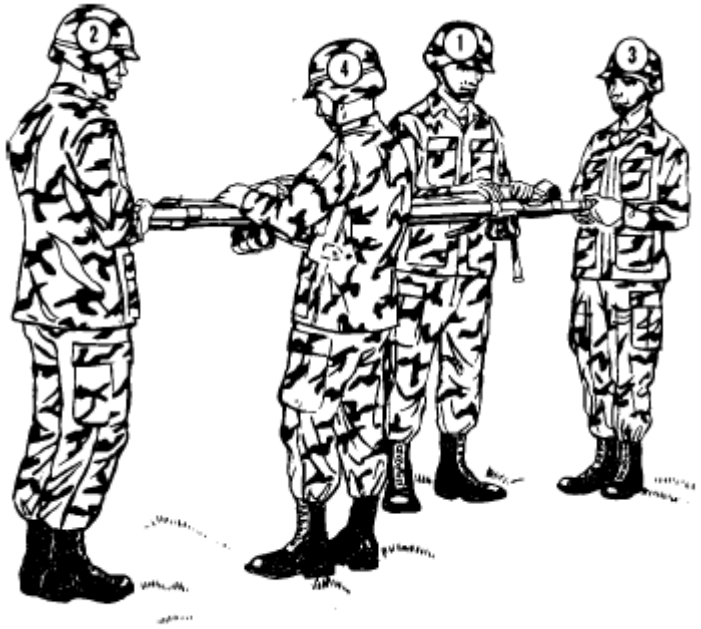


Figure J-5. Opening litter (step one).
ภาพ ก-๕ การคลี่เปล (ขั้นตอนที่หนึ่ง)

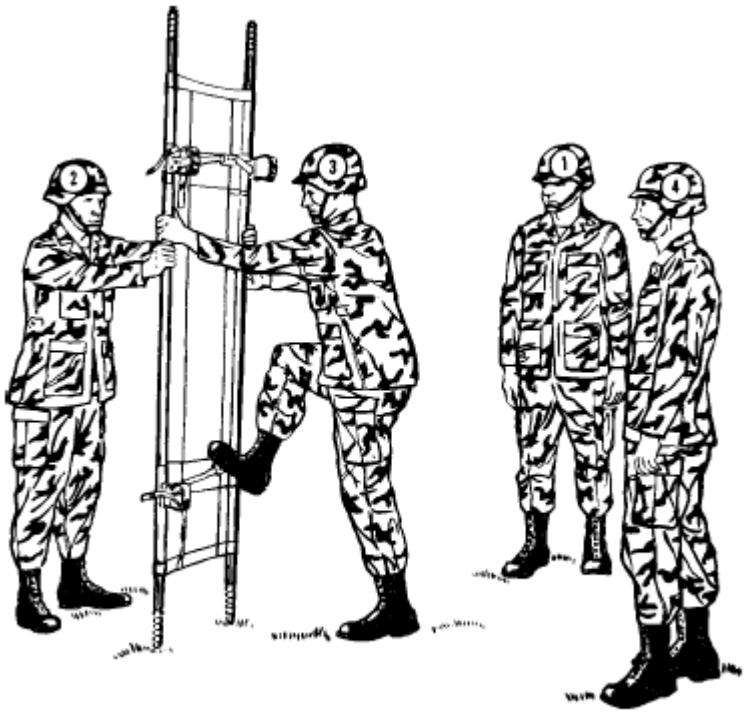


Figure J-6. Opening litter (step two).
ภาพ ก-๖ การคลี่เปล (ขั้นตอนที่สอง)

ง. การคลี่เปล ตามคำสั่งเก็บเปล หมายเลข ๒ จะทำการประคองเปลในขณะที่หมายเลข ๓ จะทำการปล่อยแท่นขยาย และ หมุนให้แท่นอยู่คานกับด้ามจับเปล หมายเลข ๒ และ ๓ จะทำการยกเปล เคลื่อนด้ามจับเปลพร้อมกัน และ ประคองเปล หมายเลข ๑ และ ๔ คลี่ผ้าเปลช้าๆ จากส่วนบน และ ทำให้เปลอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน

จ. การม้วนเปล เมื่อทำตามขั้นตอนต่างๆแล้ว ให้ใช้คำสั่งม้วนเปล หมายเลข ๑ จะทำหน้าที่ในการส่งม้วนเปล

ก-๖ ขั้นตอนสำหรับการยกผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล

หลังจากที่ผู้ป่วยเจ็บในตำแหน่งแล้ว ต้องพิจารณาบาดแผลของผู้ป่วยเจ็บ ให้การรักษาอย่างเร่งด่วน และ วางเปลที่กางแล้วให้อยู่ในตำแหน่ง พลเปลจะทำการวางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล

ก. วางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล (พลเปล ๔ นาย) ปฏิบัติตามคำสั่ง พลเปลจะยืนอยู่ในตำแหน่งทำการยกผู้ป่วยเจ็บ และ วางลงบนเปล

(๑) คำสั่งในการประจำตำแหน่ง พลเปลจะยืนทั้งด้านซ้าย และ ขวา ของผู้ป่วยเจ็บพลเปลจะหันหน้าเข้าหาผู้ป่วยเจ็บ หมายเลข ๒ จะอยู่ที่ด้านขวา(ข้อเท้า) หมายเลข ๓ อยู่ที่ไหล่ขวา และ หมายเลข ๔ และ ๑ จะอยู่ที่สะโพกขวา และ ซ้าย ตามลำดับ ตามภาพ ก-๗



Figure J-7. Squad at right side, POSTS.

ภาพ ก-๗ หมู่เปลยืนประจำตำแหน่ง

(๒) คำสั่งยกผู้ป่วยเจ็บ พลเปลแต่ละนายจะคุกเข่าลงให้อยู่ตำแหน่งที่ใกล้กับผู้ป่วยเจ็บมากที่สุด หมายเลข ๒ จะผ่านแขนไปที่ใต้ขาของผู้ป่วยเจ็บ ประคองด้วยความระมัดระวัง หมายเลข ๑ และ ๔ จะวางแขนไว้ที่ใต้หลัง และ ต้นขา ของผู้ป่วยเจ็บ หมายเลข ๓ จะทำการผ่านมือไปที่คอของผู้ป่วยเจ็บ และ ใช้มืออีกข้างประคองไว้ที่หัวไหล่ พลเปลทั้งหมดทำการยกผู้ป่วยเจ็บอย่างช้าๆ และวางด้วยความระมัดระวัง ตามภาพ ก-๘



Figure J-8. Lifting patient to load litter (step one).

ภาพ ก-๘ การยกผู้ป่วยเจ็บวางลงบนเปล (ขั้นตอนที่หนึ่ง)



Figure J-9. Lifting patient to load litter (step two).

ภาพ ก-๙ การยกผู้ป่วยเจ็บวางลงบนเปล (ขั้นตอนที่สอง)

(๓) การเตรียมผู้ป่วยเจ็บวางลงบนเปล หมายเลข ๑ จะคุกเข่าลงตรงข้ามกับพลเปลทั้งสามนาย เตรียมในการวางผู้ป่วยเจ็บลง ทันทีที่ผู้ป่วยเจ็บอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำการวางผู้ป่วยเจ็บลงบนเข่าของพลเปลทั้งสาม หมายเลข ๑ จะทำการวางเปลลงจนใกล้ถึงตัวผู้ป่วยเจ็บ ตามรูป ก-๙ จะวางเปลลงใต้ตัวผู้ป่วยเจ็บ และ ทำมุมกับข้อเท้าของพลเปลคนอื่นๆ เมื่อมีคำสั่งวางผู้ป่วยเจ็บลง จะทำการวางผู้ป่วยเจ็บลงอย่างนุ่มนวลบนเปล ตามภาพ ก-๑๐ พลเปลทั้งหมดทำการยืนขึ้นประจำตำแหน่งโดยไม่ต้องออกคำสั่ง

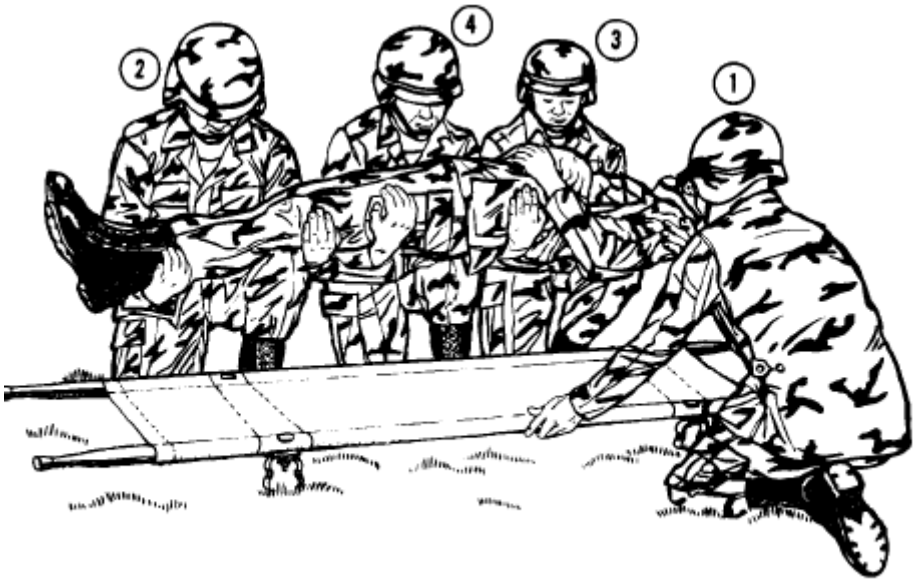


Figure J-10. Lifting patient to load litter (step three).

ภาพ ก-๑๐ การยกผู้ป่วยเจ็บวางลงบนเปล (ขั้นตอนที่สาม)

ข. การวางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล (พลเปล ๓ นาย) ถ้าขาดพลเปลไปหนึ่งนาย หมายเลข ๒ และ ๓ จะทำการช่วยเหลือหมายเลข ๑ ในการยกและวางผู้ป่วยเจ็บ การยกด้วยพลเปลสามนาย หมายเลข ๒ จะทำการวางแขนไว้ที่ใต้ขา และ ต้นขาของผู้ป่วยเจ็บ หมายเลข ๓ จะวางแขนใต้หลัง และ ไหล่ของผู้ป่วยเจ็บ หมายเลข ๑ จะอยู่ตรงข้ามกับเปล วางแขนใต้เข่าและหลังผู้ป่วยเจ็บ ผู้ป่วยเจ็บจะได้รับการประคองบนเข่าของหมายเลข ๒ และ ๓ ในขณะที่หมายเลข ๑ จะวางเปลในตำแหน่งตามภาพ ก-๑๑ พลเปลทั้งสามนายจะวางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล ภาพ ก-๑๒ ขั้นตอนจะกระทำตามคำสั่งในย่อหน้า ก.

ค. การยกผู้ป่วยเจ็บ (พลเปล ๒ นาย) ขั้นตอนของการยกผู้ป่วยเจ็บวางลงบนเปลด้วยพลเปลสองนายโดยยืนอยู่ข้างเดียวกัน ตามภาพ ก-๑๓ ถึง ก-๑๖

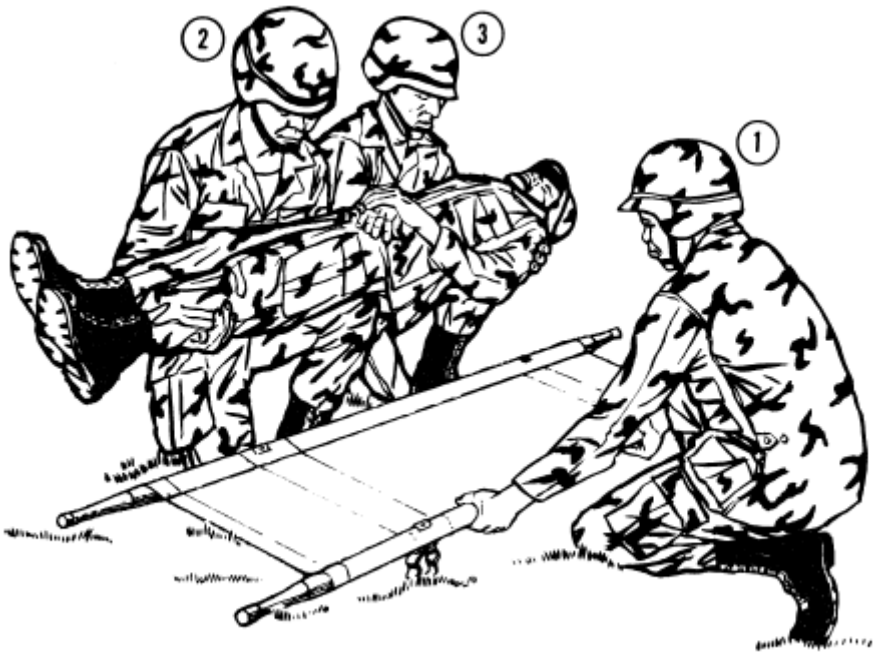


Figure J-11. Lifting patient to load litter (three bearers).

ภาพ ก-๑๑ การยกผู้ป่วยเจ็บวางลงบนเปล (พลเปล ๓ นาย)

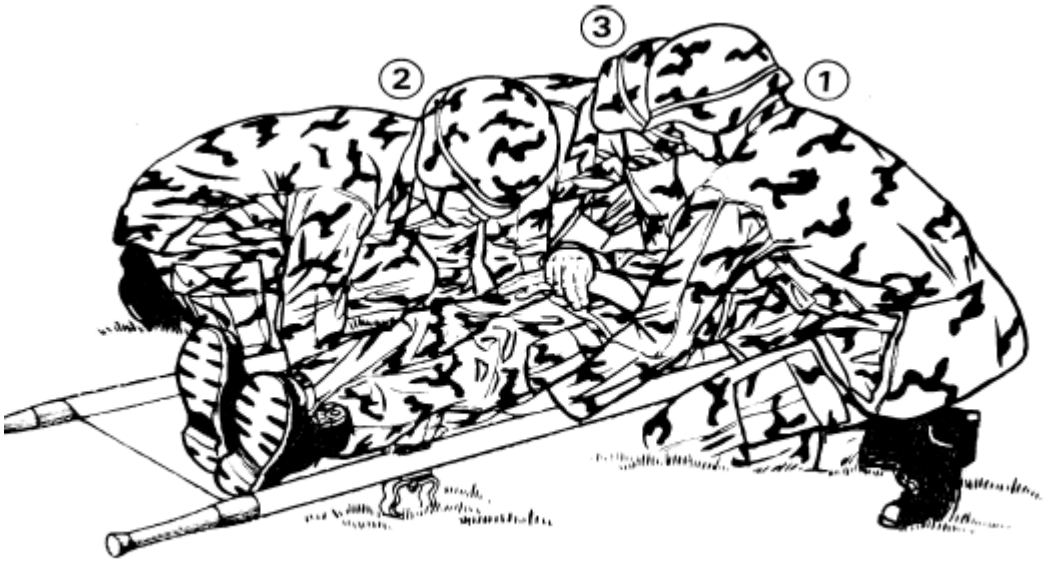


Figure J-12. Lowering patient onto litter (three bearers).

ภาพ ก-๑๒ การวางผู้ป่วยเจ็บวางลงบนเปล (พลเปล ๓ นาย)

(๑) คำสั่งในการประจำที่ให้ยืนทางด้านขวา หมายเลข ๑ และ ๒ ยืนอยู่ที่ต้นขาขวา และหัวไหล่ตามลำดับ ก-๑๓



Figure J-13. Two bearers at right side, POSTS.

ภาพ ก-๑๓ ตำแหน่งประจำที่ของพลเปล ๒ นาย ที่ด้านขวาของผู้ป่วยเจ็บ

(๒) คำสั่งเตรียมยก ผู้ป่วยเจ็บแต่ละคนจะทำการคุกเข่าลงให้อยู่ใกล้กับผู้ป่วยเจ็บ หมายเลข ๑ จะผ่านแขนไว้ที่ใต้สะโพก และ เข่าของผู้ป่วยเจ็บ หมายเลข ๒ จะผ่านแขนไว้ที่ใต้หลังผู้ป่วยเจ็บตามภาพ ก-๑๔

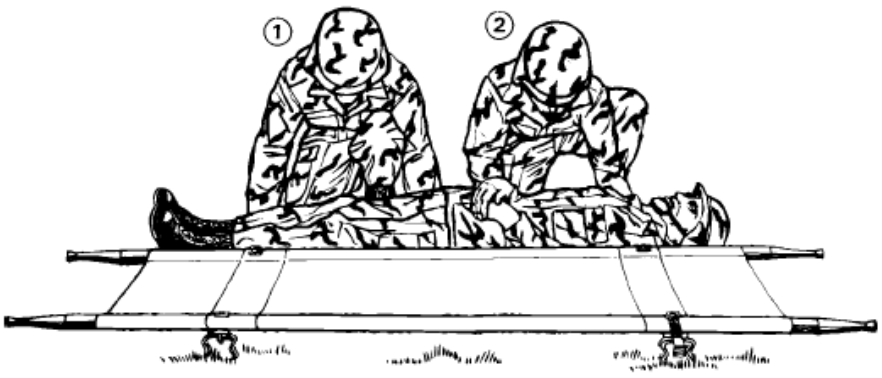


Figure J-14. Lifting patient with two bearers on the same side (step one).

ภาพ ก-๑๔การยกผู้ป่วยเจ็บด้วยพลเปล ๒ นาย ที่ด้านข้างเดียวกัน (ขั้นตอนที่หนึ่ง)

(๓) คำสั่งปฏิบัติในการยกผู้ป่วยเจ็บ พลเปลจะทำการยกผู้ป่วยเจ็บไว้ด้วยกัน ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นวางไว้บนเข่า ทำการปรับให้เหมาะสม ยกเท้าขึ้น และ เคลื่อนที่เข้าไปให้ใกล้เปล ตามภาพ ก-๑๕

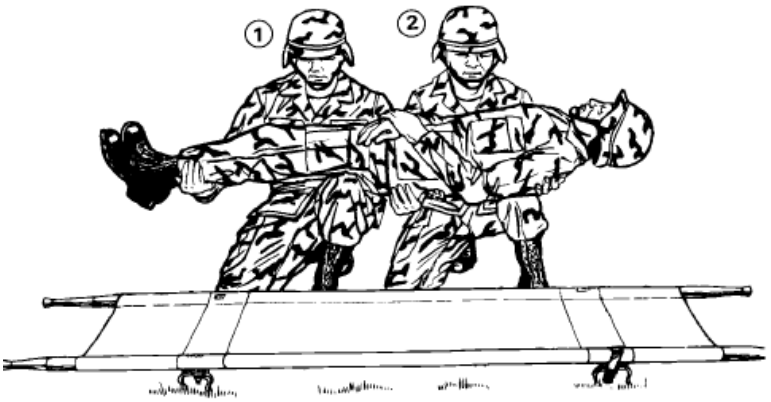


Figure J-15. Lifting patient with two bearers on the same side (step two).

ภาพ ก-๑๕การยกผู้ป่วยเจ็บด้วยพลเปล ๒ นาย ที่ด้านข้างเดียวกัน (ขั้นตอนที่สอง)

(๔) คำสั่งในการเตรียมวางผู้ป่วยเจ็บลง พลเปลจะคุกเข่าลง และวางผู้ป่วยเจ็บบนเข่า เมื่อมีคำสั่งในการวางผู้ป่วยเจ็บ พลเปลจะวางผู้ป่วยเจ็บลงอย่างนุ่มนวลบนเปล ภาพ ก-๑๖ หลังจากวางผู้ป่วยเจ็บลงแล้วให้กลับขึ้นมายืนประจำที่โดยไม่ต้องทำออกคำสั่งอีก



Figure J-16. Lowering patient onto litter with two bearers on the same side.

ภาพ ก-๑๖ วางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปลด้วยพลเปล ๒ นาย ที่อยู่ข้างเดียวกัน

ง. การยกผู้ป่วยเจ็บที่มีสติ ด้วยพลเปล ๒ นาย ถ้าผู้ป่วยเจ็บมีสติสามารถทำการยึดตัวพลเปลได้ มีการยกตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(๑) คำสั่งประจำที่ ให้ยืนอยู่ที่ด้านข้างแต่ละด้านของผู้ป่วยเจ็บ หมายเลข ๑ และ ๒ หันหน้าเข้าหาผู้ป่วยเจ็บ ยืนอยู่ที่สะโพกของผู้ป่วยเจ็บ ด้านขวา และ ซ้าย ตามลำดับ ตามภาพ ก-๑๗



Figure J-17. Two bearers, one on each side, POSTS.

ภาพ ก-๑๗ พลเปล ๒ นาย ประจำที่ในแต่ละด้านของผู้ป่วยเจ็บ

(๒) เมื่อสั่งให้ยกผู้ป่วยเจ็บ พลเปลจะเข้าหาผู้ป่วยเจ็บในแต่ละด้าน โดยให้ผู้ป่วยเจ็บอยู่ตรงกลางของเปล ตาม ภาพ ก-๑๘ และ ก-๑๙



Figure J-18. Lifting patient with two bearers, one on each side (step one).

ภาพ ก-๑๘ การยกผู้ป่วยเจ็บด้วยพลเปล ๒ นาย ในแต่ละด้านของผู้ป่วยเจ็บ (ขั้นตอนที่หนึ่ง)

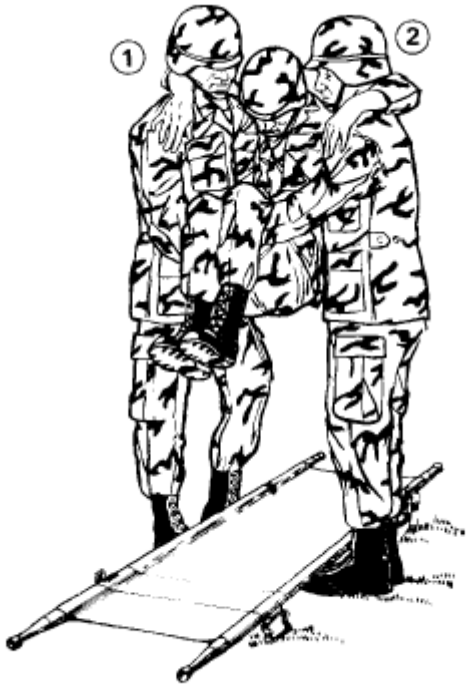


Figure J-19. Lifting patient with two bearers, one on each side (step two).

ภาพ ก-๑๙ การยกผู้ป่วยเจ็บด้วยพลเปล ๒ นาย ในแต่ละด้านของผู้ป่วยเจ็บ (ขั้นตอนที่สอง)

(๓) คำสั่งในการวางผู้ป่วยเจ็บลง พลเปลจะทำการวางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปลในท่าที่นั่งลง หลังจากนั้นจะทำการปล่อยตัวผู้ป่วยเจ็บลงในขณะที่ผู้ป่วยเจ็บเกาะคอของพลเปลอยู่ พลเปลทั้งสองนายจะวางผู้ป่วยเจ็บลง และจะลุกยืนขึ้นประจำตำแหน่งโดยไม่ต้องออกคำสั่ง ตามภาพ ก-๒๐

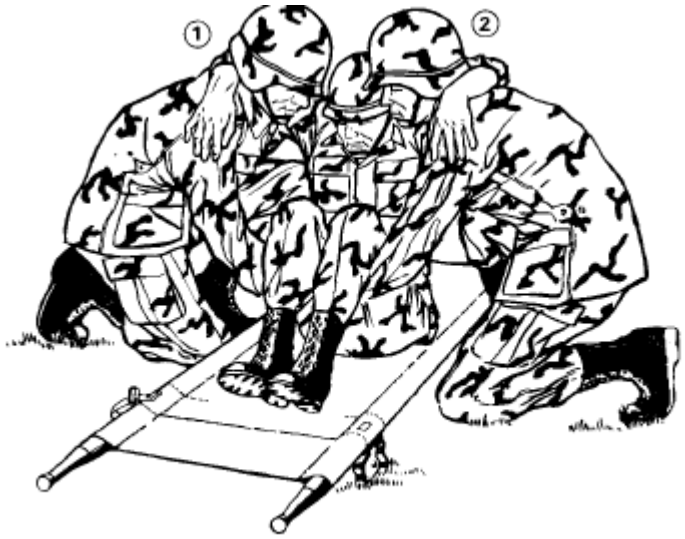


Figure J-20. Lowering patient onto litter (two bearers,one on each side).

ภาพ ก-๒๐ การวางผู้ป่วยเจ็บ(ด้วยพลเปล ๒ นาย ในแต่ละด้าน)

จ. การวางผู้ป่วยเจ็บที่บาดเจ็บที่หลัง ควรหลีกเลี่ยงการทำให้อาการผู้ป่วยเจ็บแย่ลงจากการยก มีขั้นตอนต่างๆตามภาพ ก-๒๑ ดังนี้

(๑) พลเปลแต่ละคนคุกเข่าลงให้ใกล้กับเท้าของผู้ป่วยเจ็บ (ถ้าผู้ป่วยเจ็บไม่สามารถยึดจับได้ ให้วางแขนไว้ที่ด้านหน้า ข้อมือควรจะจับมัดไว้ให้หลวมๆก่อนที่จะทำการวางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล เป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่แขน

(๒) พลเปลหมายเลข ๑ วางผ้าห่ม เสื้อโค้ท หรือ เสื้อแจ็กเก็ท ในตำแหน่งที่ประคองหลังของผู้ป่วยเจ็บ พลเปลหมายเลข ๓ วางมือใต้หัวของผู้ป่วยเจ็บ และ มืออีกข้างวางบนไหล่ พลเปลหมายเลข ๔ วางมือใต้หลัง และ ก้น ส่วนหมายเลข ๒ วางมือใต้ต้นขา และ น่อง พลเปลหมายเลข ๑ ช่วยหมายเลข ๔ ในการประคองหลังของผู้ป่วยเจ็บ

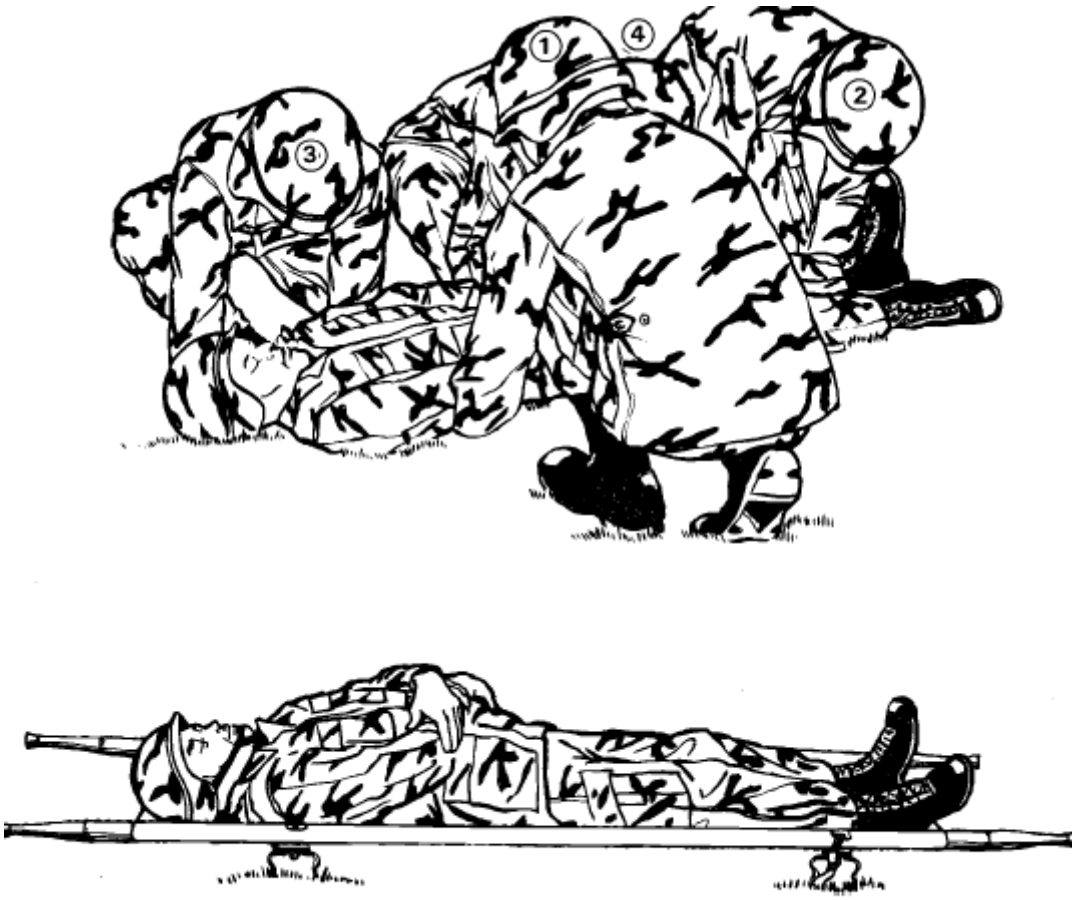


Figure J-21. Lifting patient with back injury.

ภาพ ก-๒๑ การยกผู้ป่วยเจ็บที่บาดเจ็บที่หลัง

(๓) คำสั่งในการยกผู้ป่วยเจ็บ พลเปลทั้งหมดจะทำการยกอย่างนุ่มนวลและยกให้สูงขึ้นประมาณ ๘ นิ้ว พลเปลทั้งหมดจะทำการจัดท่าให้อยู่ในท่าที่เหมาะสม หมายเลข ๑ จะวางเปลไว้ที่ใต้ผู้ป่วยเจ็บ และ ม้วนหลังผู้ป่วยเจ็บ

(๔) คำสั่งในการวางผู้ป่วยเจ็บลง พลเปลสามนายจะเอียงตัวไปด้านหน้า และ ช่วยหมายเลข ๑ วางผู้ป่วยเจ็บลงบนเปล

ก-๗ ขั้นตอนการยกผู้ป่วยเจ็บวางลงบนเปล

หลังจากที่ผู้ป่วยเจ็บถูกวางลงบนเปลแล้ว ขั้นตอนในการยกเปลมีดังต่อไปนี้

ก. ขั้นตอนการยกผู้ป่วยเจ็บวางบนเปล เมื่อพลเปลประจำที่ และ หันหน้าไปในทิศทางที่จะเคลื่อนที่ พลเปลจะทำการยกผู้ป่วยเจ็บเมื่อได้รับคำสั่งยก ตามภาพ ก-๒๒

(๑) คำสั่งเตรียมยก พลเปลแต่ละนายจะคุกเข่าลงให้อยู่ใกล้กับเปลมากที่สุด จับที่ด้ามจับเปลให้อยู่ใกล้กับเปลมากที่สุด และ วางมืออีกข้างลงบนเข่า

(๒) ออกคำสั่งปฏิบัติให้ยก พลเปลทั้งหมดจะทำการยกโดยให้เปลอยู่ในระดับ พลเปลควรใช้กล้ามเนื้อขา ไม่ใช้กล้ามเนื้อหลังในการยก



Figure J-22. Lifting the loaded litter.

ภาพ ก-๒๒ การยกผู้ป่วยเจ็บที่นอนอยู่บนเปล

ข. การยกเปลที่มีผู้ป่วยเจ็บที่นอนอยู่ การส่งกลับด้วยเปลจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง ซึ่งอาจจะมีการยกหลายวิธี

(๑) หลังจากที่พลเปลยกเปลที่มีผู้ป่วยเจ็บนอนอยู่ จะต้องใช้พลเปล ๔ นาย ตามภาพ ก-๒๓ ซึ่งจะใช้ในภูมิประเทศที่ราบเรียบ การออกคำสั่งคือ เคลื่อนที่ อาจจะมีการปรับด้วยการใช้ผ่านลอดสิ่งกีดขวาง

(๒) การออกคำสั่งให้เคลื่อนย้ายด้วยพลเปล ๒ นาย แต่มีพลเปล ๔ นาย ในการข้ามผ่านทางที่แคบ เช่น ทางเดิน สะพาน ไม้กระดาน ตามภาพ ก-๒๔ หลังจากพลเปลผ่านมาจนถึงทางเดิน ต้องทำการเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้สามารถข้ามผ่านสิ่งกีดขวางเช่น อุโมงค์ ท่อน้ำ เป็นต้น พลเปลจะหันนหน้าเข้าหาผู้ป่วยเจ็บ และ คลานเข่าข้ามผ่านสิ่งกีดขวางผ่านสิ่งกีดขวาง ต้องมีพลเปลหนึ่งนายคลานทางย้อนไปด้านหลัง

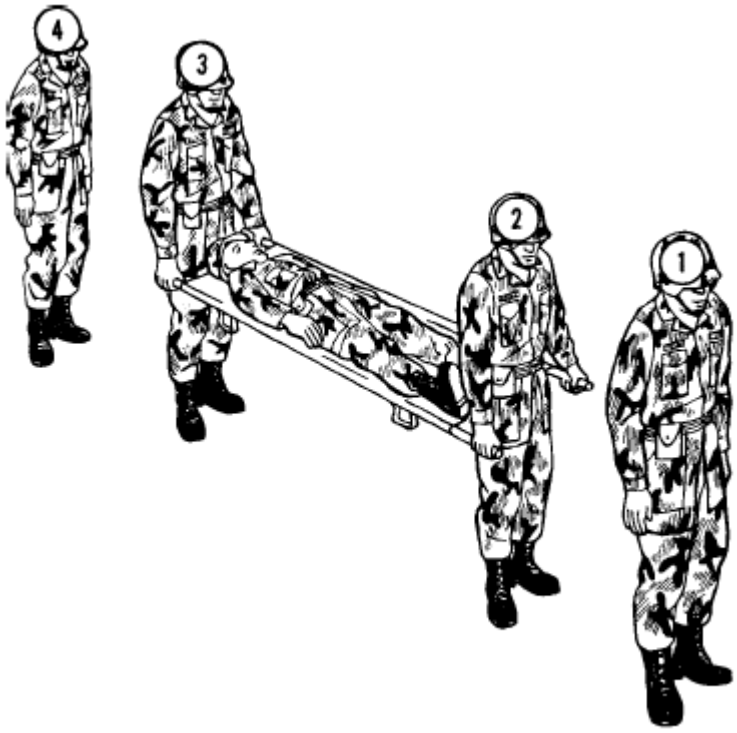


Figure J-24. Two-man carry for narrow trails and passages.

ภาพ ก-๒๔ การยกเปลด้วยพลเปล ๒ นายในการเดินผ่านทางเดิน หรือ ทางผ่าน

(ก) หมู่เปลประจำตำแหน่ง ๔ นาย คำสั่งในการเตรียมยก พลเปล ๒ นายทำการยก หมายเลข ๒ และ ๓ จะจับที่ด้ามเปล โดยก้าวไปแทนที่และ ประคองเปลในตำแหน่งของหมายเลข ๑ และ ๔

(ข) พลเปลหมายเลข ๑ ก้าวไปด้านหน้าหนึ่งก้าวเพื่อนำทีม หมายเลข ๔ จะก้าวไปทางด้านหลังหนึ่งก้าว

(ค) ออกคำสั่งในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผ่านทางเดิน

(๓) คำสั่งในการยก และ ทำการเคลื่อนย้าย ในกรณีที่ข้ามผ่านเส้นทางที่ขรุขระลำบากด้วยพลเปล ๔ นาย ตามภาพ ก-๒๕

(ก) หมู่เปลอยู่ในตำแหน่งพลเปลทั้ง ๔ นาย ออกคำสั่งในการเตรียมยกเปล พลเปลหมายเลข ๒ และ ๓ ก้าวไปอยู่ระหว่างเปล และ ถือด้ามเปลไว้ ส่วนหมายเลข ๑ และ ๔ ปล่อยมือ

(ข) หมายเลข ๑ และ ๔ เคลื่อนมายังด้านข้างของเปล และจับไว้ที่ด้ามเปล

(ค) ออกคำสั่งเคลื่อนที่ ด้วยพลเปล ๔ นาย ด้วยความระมัดระวังบนเส้นทางที่ขุรขระนั้น

(๔) ยกเว้น เมื่อผู้ป่วยเจ็บมีการหัก หรือ แตกที่ขา จะทำการยกเปลขึ้นเขา หรือ บันได โดยหันศีรษะของผู้ป่วยเจ็บไปข้างหน้า จากตำแหน่งใน ภาพ ก-๒๓ หมู่เปล จะเคลื่อนที่มาประจำในตำแหน่งตามภาพ ต-๒๕ เมื่อมีการคำสั่งให้เตรียมหมุน ให้หมุนตามภาพ ก-๒๖ และ ทำการเคลื่อนย้ายขึ้นเขา หรือ บันไดตามภาพ ก-๒๗



Figure J-25. Litter post carry for rough terrain.

ภาพ ก-๒๕ การยกเปล ให้ข้ามผ่านภูมิประเทศที่ขุรขระ

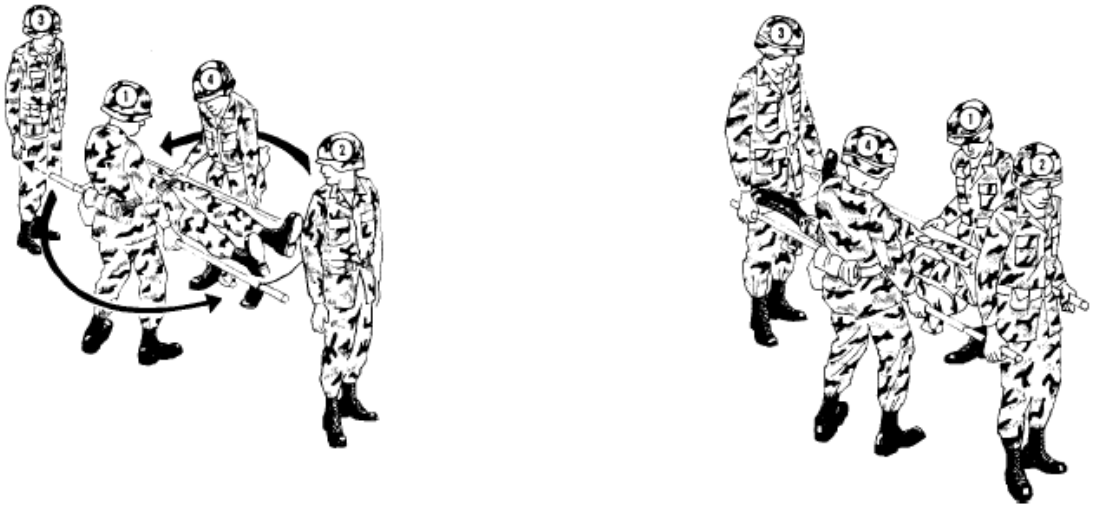


Figure J-26. Rotation of the litter for uphill or upstairs carry and for ambulance loading.

ภาพ ก-๒๖ การหมุนของเปล สำหรับการขึ้นเขา และ การขึ้นบันได

(ก) หมู่เปลประจำการในตำแหน่ง และใช้คำสั่งในการเตรียมหมุน หมายเลข ๒ และ ๓ ปล่อยมือ และ ก้าวหนึ่งก้าวไป ปล่อยให้หมายเลข ๑ และ ๔ ประคองเปลด้านข้าง

(ข) ออกคำสั่งในการหมุน หมายเลข ๑ และ ๔ เคลื่อนที่ ๑๘๐ องศา ทวนเข็มนาฬิกา วางผู้ป่วยเจ็บโดยหันศีรษะไปทางด้านที่จะทำการเคลื่อนย้าย พลเปลหมายเลข ๑ ยังคงอยู่ที่ด้านข้าง

(ค) หลังจากที่หมุนเปลแล้ว ศีรษะผู้ป่วยเจ็บจะอยู่ในตำแหน่งที่หันไปทางที่จะเคลื่อนที่

(ง) ทันทีที่หมายเลข ๒ และ ๓ สังเกตว่ามีการหมุนเรียบร้อยแล้ว จะทำการประจำตำแหน่งในการยกเปล การหมุนของเปลหมายเลข ๒ จะอยู่ตำแหน่งศีรษะของผู้ป่วยเจ็บ

(จ) คำสั่งในการเตรียมยก ขึ้นเขา หรือ บันได หมายเลข ๔ จะเคลื่อนย้ายมาทางเท้าของผู้ป่วยเจ็บ และ จับเปลไว้ด้วยมือ และ ปล่อยมืออีกมือให้หมายเลข ๓ ช่วยถือ หมายเลข ๑ จะนำขึ้นไปข้างหน้าเป็นผู้นำทีม

(ฉ) ออกคำสั่งในการเคลื่อนที่ หมายเลข ๑ จะนำหน้า หมายเลข ๓ และ ๔ จะทำการรักษาเปลให้ได้ระดับ

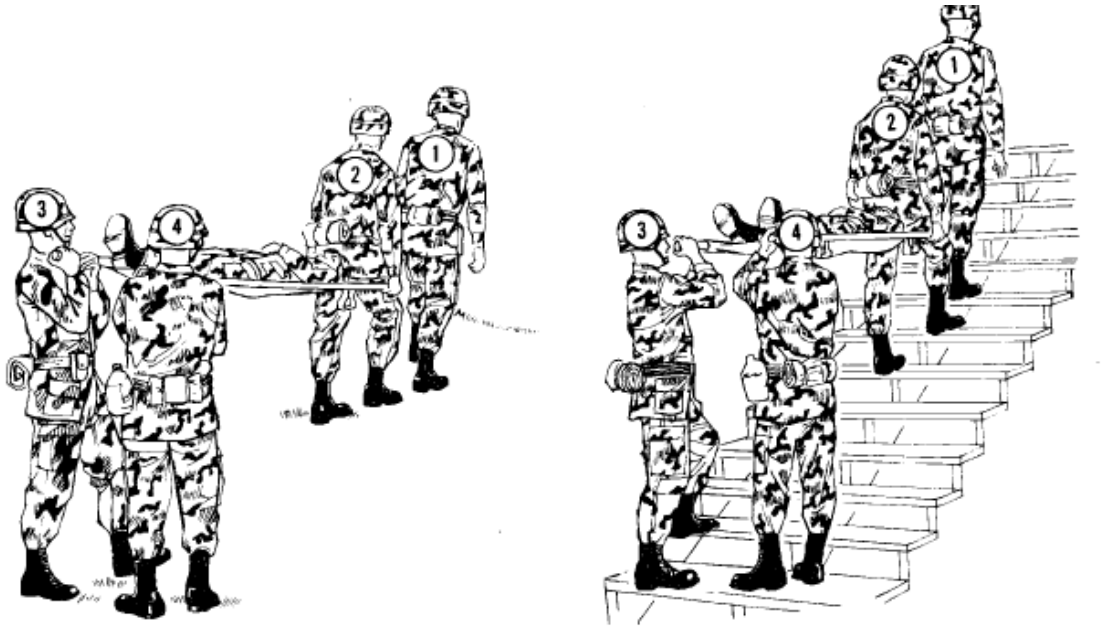


Figure J-27. Uphill and upstairs carry.

ภาพ ก-๒๗ การถือขึ้นเขา และ บันได

(๕) ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยเจ็บมีการบาดเจ็บที่ส่วนล่าง พลเปลควรจะถือในลักษณะลงเขา หรือ ลงบันไดโดยให้เท้าของผู้ป่วยเจ็บหันไปทางที่จะทำการเคลื่อนย้าย ลักษณะการย้ายจะเหมือนภาพ ก-๒๘ โดยให้หมู่เปลอยู่ในตำแหน่ง ๔ นาย ตามภาพ ก-๒๓ หรือ ภาพ ก-๒๕ และ เตรียมการเคลื่อนย้ายลงเขา

(ก) เมื่อหมู่เปลอยู่ในตำแหน่ง จะมีการเตรียมการเคลื่อนย้ายลงเขา หมายเลข ๓ จะทำการประคองเปลที่ตำแหน่งศีรษะ และ หมายเลข ๒ และ ๔ จะอยู่ที่ตำแหน่งด้านเท้า

(ข) หมายเลข ๑ จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้า โดยหันหน้าหาหมู่เปล ทำการสนับสนุนพลเปลหมายเลข ๒ และ ๔ เพื่อรักษาเปลให้อยู่ในระดับ

(ค) ทำการลดระดับเปลลง ก่อนที่จะทำการลดระดับเปลลงบนพื้น พลเปลต้องอยู่ในตำแหน่งประจำที่ทั้ง ๔ นาย หลังจากนั้นให้เตรียมคำสั่งในการวางลง พลเปลแต่ละนายจะทำการคุกเข่าลงอย่างช้าๆ วางเปลลงอย่างนุ่มนวลบนพื้น พลเปลแต่ละนายปล่อยมือให้เป็นอิสระจากเปล มืออีกข้างวางบนเข่าและยืนขึ้น

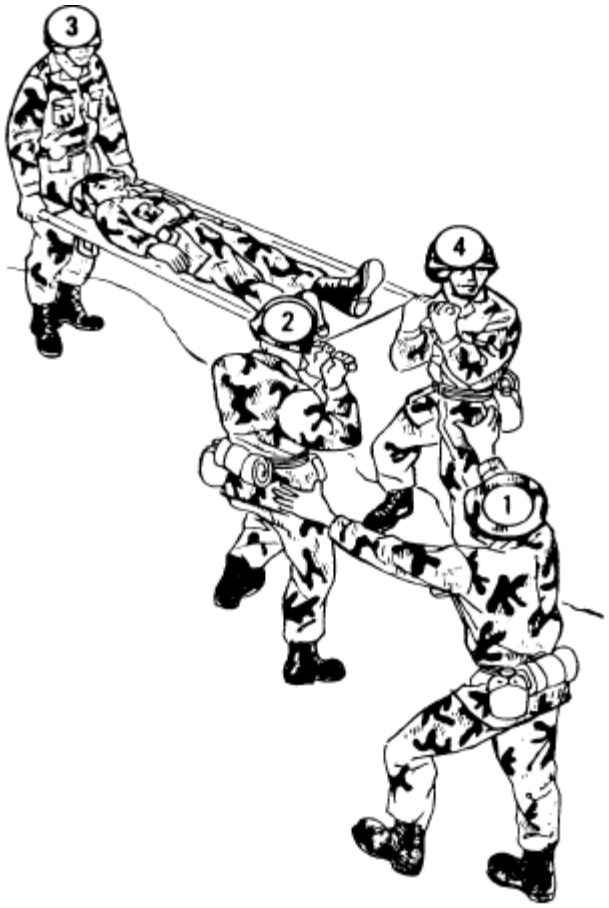


Figure J-28. Downhill or downstairs carry.

ภาพ ก-๒๘ การถือลงเขา หรือ ลงบันได

ก-๘ ขั้นตอนการข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง

การส่งกลับด้วยเปล พลเปลสามารถข้ามเครื่องกีดขวางที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ เช่น รั้ว กำแพงสูง คูลึก แม่น้ำกว้าง และทางแคบที่มีลักษณะเป็นขั้นบันได ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งเฉพาะสำหรับการข้ามสิ่งกีดขวาง แต่จะต้องมีคำสั่งที่เหมาะสมในการยก การใช้ความรู้สึกจะต้องรู้จักปรับให้เข้ากับสถานการณ์

ก. หลักสูตรการฝึกอบรมการยกเปลข้ามสิ่งกีดขวาง หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือฝึกสำหรับการข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง หลักสูตรนี้จะเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยตามธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้พลเปลคุ้นเคย หรืออาจจะเป็นการจำลองอุปสรรคที่พบได้บ่อยจากสถานที่ต่างๆ

ข. วิธีข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง มีหลายวิธีในการปรับปรุงการยกเปลซึ่งจะทำให้สามารถข้ามผ่านสิ่งกีดขวางที่แตกต่างกันได้

(๑) การข้ามผ่านสิ่งกีดขวางที่เป็นรั้ว หรือ กำแพงต่ำ

(ก) หมู่เปลจะประจำที่เพื่อทำการยก หมายเลข ๒ จะปล่อยมือที่อยู่ด้านเท้าของผู้ป่วยเจ็บและทำการข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง รักษาตัวไว้ที่ระดับต่ำ หมายเลข ๑ ๓ และ ๔ จะประคองเปลไว้จนกว่าหมายเลข ๒ จะสามารถจับที่ด้ามจับไว้ได้ที่ด้านหน้า ตามภาพ ก-๒๙

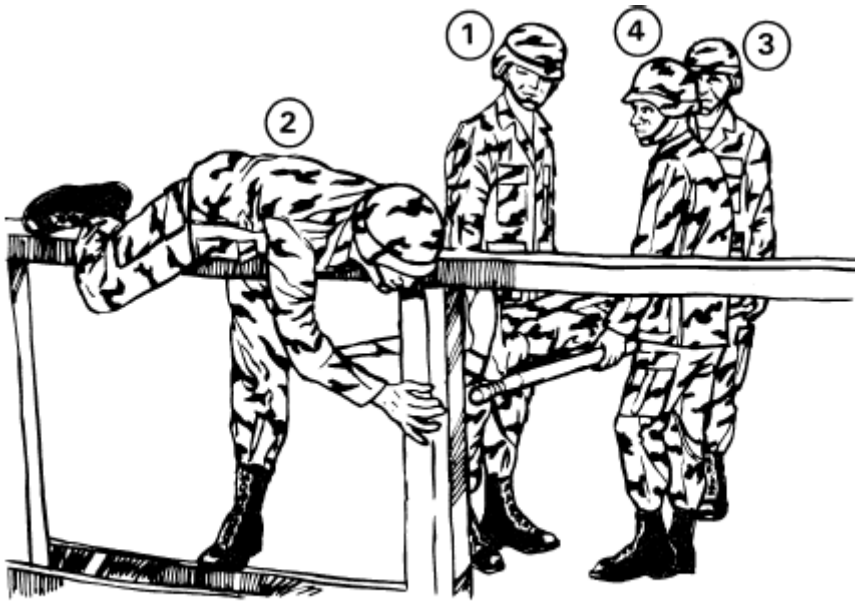


Figure J-29. Surmounting a fence or low wall (step one).

ภาพ ก-๒๙ การข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง หรือ กำแพงต่ำ (ขั้นตอนที่หนึ่ง)

(ข) เปลจะถูกวางไว้บนสิ่งกีดขวาง หมายเลข ๒ และ ๓ จะประคองเปลไว้ที่ด้านหน้าและ ด้านหลังตามลำดับ ส่วนหมายเลข ๑ และ ๔ ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางโดยรักษาตัวไว้ที่ระดับต่ำ การข้ามผ่านสิ่งกีดขวางหมายเลข ๑ และ ๔ จะจับที่ด้ามเปลไว้ที่ด้านหลังเปลส่วนที่ใกล้หมายเลข ๓ จับอยู่หลังจากนั้นหมายเลข ๓ จะปล่อยมือและทำการข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง หลังจากนั้นหมายเลข ๓ จะกลับมาจับเปลไว้ที่ด้ามเปลตามเดิม หมายเลข ๑ และ ๔ จะกลับไปจับที่ตำแหน่งเดิม ตามภาพ ก-๓๐

หมายเหตุ *เปลควรจะถูกยก ไม่ควรถูกลากข้ามผ่านส่วนบนของสิ่งกีดขวาง*

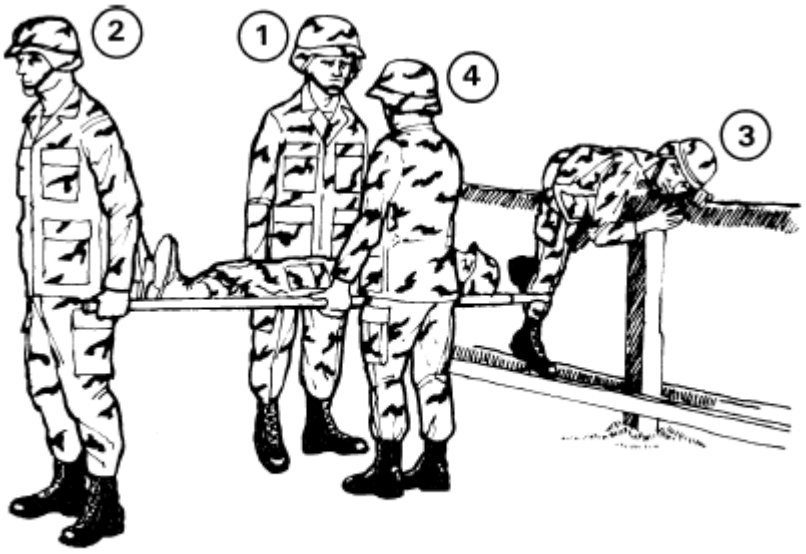


Figure J-30. Surmounting a fence or low wall (step two).

ภาพ ก-๓๐ การข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง หรือ กำแพงต่ำ (ขั้นตอนที่สอง)

(๒) การข้ามสิ่งกีดขวางที่เป็นกำแพงสูง การยกด้วยพลเปล ๔ นาย พลเปลจะหันหน้าเข้าหากัน ทำการยกเปลไว้ที่ระดับอก ก้าวเข้ามาให้ชิดเปล งอแขนให้ชิดกับหน้าอก พลเปลคนที่อยู่ข้างหน้าวางตัวลงบนสิ่งกีดขวางบนกำแพงวางเปลไว้บนกำแพง และหย่อนตัวลงที่อีกข้างของกำแพง พลเปลทั้ง ๔ นาย จะทำการเคลื่อนย้ายเปลไปข้างหน้าจนกระทั่งด้านหลังวางตัวและหย่อนตัวลงที่อีกข้างของกำแพง หลังจากนั้นจะยกเปลออกจากกำแพง ตามภาพ ก-๓๑ พลเปลจะกลับมายืนอยู่ในตำแหน่งถือเปลทั้ง ๔ นาย



Figure J-31. Surmounting a high wall.

ภาพ ก-๓๑ การข้ามผ่านสิ่งกีดขวางผ่านกำแพงสูง

(๓) การข้ามผ่านแม่น้ำ และ การข้ามผ่านคูลึก

(ก) หมู่เปลประจำตำแหน่ง ๔ นาย พลเปลจะทำการหมุน และ หันหน้าเข้าหากัน พลเปลที่สูงกว่าควรจะยืนอยู่ทางด้านท้ายเปล ยกเปลเหนือศีรษะรักษาระดับไว้ หลังจากนั้นจะลงไปในคู จะทำการยกเปลไว้ให้อยู่เหนือระดับคู ตามภาพ ก-๓๒

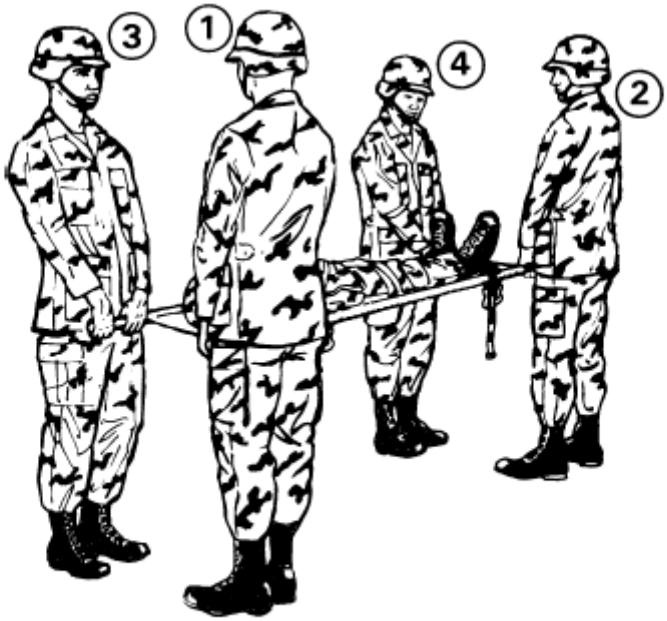


Figure J-32. Fording streams and crossing deep trenches (overhead carry, step one).

ภาพ ก-๓๒ การข้ามผ่านลำน้ำ และ การข้ามผ่านคูลึก (การยกขึ้นเหนือหัว ขั้นตอนที่หนึ่ง)

(ข) พลเปลที่สูงกว่าจะอยู่ที่ท้ายเปลจับที่ด้ามเปล หันหน้าไปทางทิศที่จะเดินไป มือจับที่ด้ามให้อยู่ใกล้กับผ้าเปลมากที่สุด พลเปลที่ต่ำกว่าในแต่ละข้างจะทำการเคลื่อนตัวเข้ามาที่ใต้เปล หันหน้าไปยังทิศทางที่จะเดินไป ถ้าพลเปลสูงเท่าๆกันพลเปลที่อยู่ด้านใต้เปลจะจับที่สุดด้ามเปล ตามภาพ ก-๓๓



Figure J-33. Fording streams and crossing deep trenches (overhead carry, step two).

ภาพ ก-๓๓ การข้ามผ่านแม่น้ำ และ การข้ามผ่านคูลึก (การยกขึ้นเหนือหัว ขั้นตอนที่สอง)

หมายเหตุ *พลเปลที่อยู่ด้านหน้าควรที่จะก้าวข้ามแม่น้ำ และ ทำการปล่อยมือ ให้พลเปลอีก ๓ นายรักษาระดับเปลไว้*

(๔) การถือเปลผู้ป่วยเจ็บเดินขึ้นบันได หรือ พื้นที่แคบ ขั้นตอนสำหรับขั้นตอนนี้ให้พิจารณาตามภาพ ก-๓๔

(ก) หมู่เปลจะเคลื่อนที่ขึ้นบันได โดยหมายเลข ๑ และ ๓ ประคองด้านหัวเปล และหมายเลข ๒ และ ๔ จะประคองที่ด้านท้ายเปล

(ข) การวางลงที่พื้นดิน พลเปลหมายเลข ๓ หันหน้าเข้าหาทางหัวเปลและ ประคองไว้ในขณะที่หมายเลข ๑ ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปหลายก้าว พลเปลหมายเลข ๒ และ ๔ จะยกไว้จนกระทั่งหมายเลข ๑ สามารถจับที่ด้ามที่หมายเลข ๒ ปล่อยมือออกไป พลเปลหมายเลข ๒ จะทำการเคลื่อนย้ายผ่านไปทางด้านข้างของเปล

(ค) พลเปลหมายเลข ๒ จะช่วยหมายเลข ๑ ในการประคองเปล หมายเลข ๑ จะจับที่ด้ามจับที่หมายเลข ๔ ปล่อยมือออก

(ง) หมายเลข ๔ จะทำการจับที่ด้ามเปลต่อไปเพื่อประคองเปลที่ด้านข้างในการเคลื่อนที่ขึ้นบันได

(จ) หมายเลข ๔ จะช่วยหมายเลข ๓ ในการถือเปลที่ส่วนหัวเปล ในขณะที่หมายเลข ๒ จะทำการช่วยเหลือหมายเลข ๑ ในการถือที่ด้านท้ายเปลเพื่อทำการวางที่พื้นต่อไป

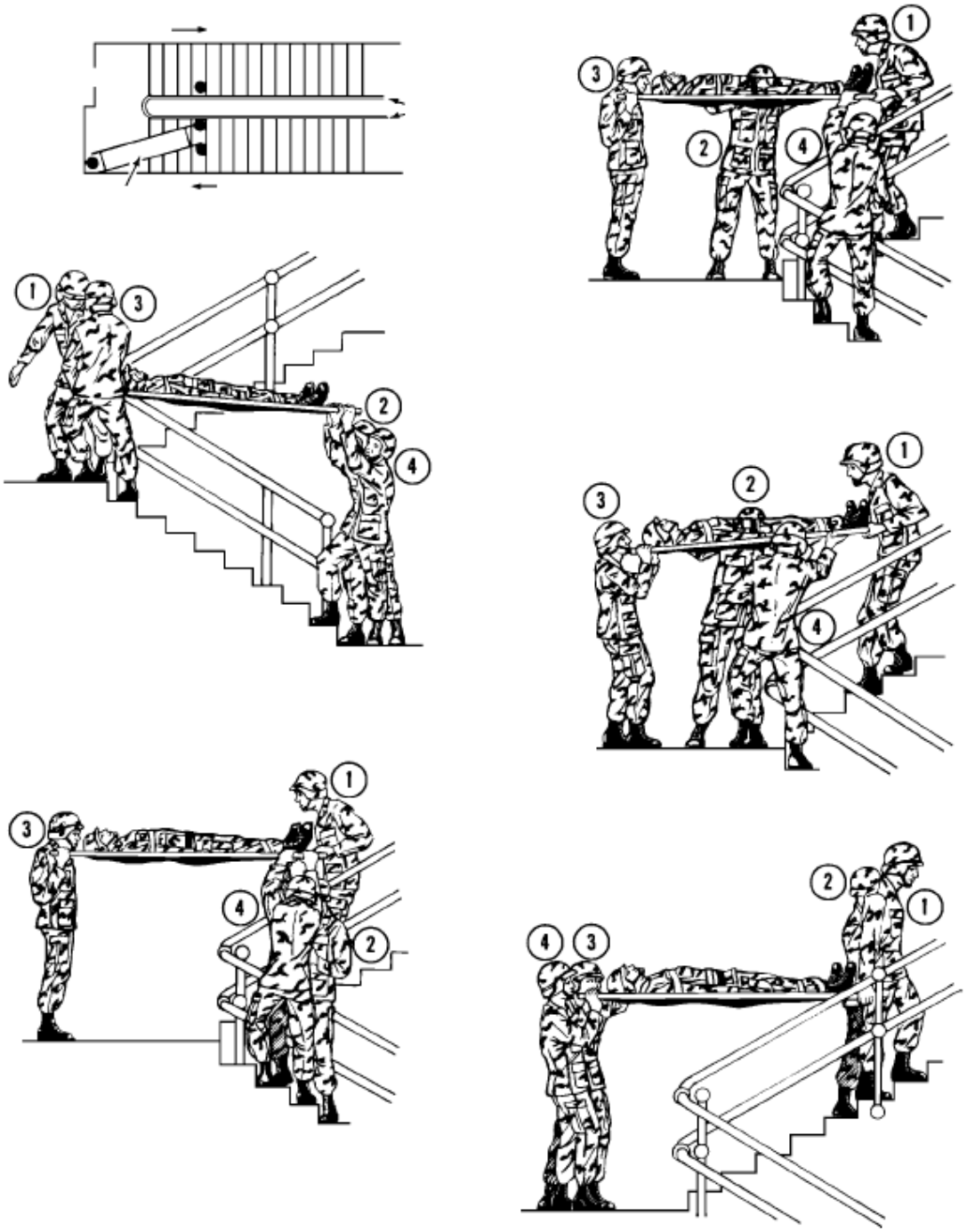


Figure J-34. Carrying a litter patient up a stairwell with small landings.

ภาพ ก- ๓๔ การถือเปลยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นบันไดภายในพื้นที่แคบ

(๕) การถือเปลผู้ป่วยเจ็บเดินลงบันได มีขั้นตอนต่างๆ ตามภาพ ก-๓๕

(ก) หมู่เปลจะทำการก้าวลงบันไดไปที่พื้น หมายเลข ๑ และ ๓ จะทำการประคองที่หัวเปล และ หมายเลข ๒ และ ๔ จะประคองที่ท้ายเปล

(ข) การเดินลงมายังพื้น หมายเลข ๔ จะหมุนตัว และ หันหน้าไปทางเปลและประคองด้านท้ายเปลไว้ในขณะที่หมายเลข ๓ จะประคองที่หัวเปล หมายเลข ๑ และ ๒ จะทำการก้าวลงบันได ๒-๓ ก้าว รับทางด้านหัวเปลจากหมายเลข ๓

(ค) หมายเลข ๓ จะทำการเคลื่อนที่ไปยังด้านท้ายเปลเพื่อช่วยหมายเลข ๔ ในขณะที่หมายเลข ๑ และ ๒ สนับสนุนทางด้านหัวเปล จะทำการเคลื่อนย้ายลงบันไดไปยังพื้นดิน

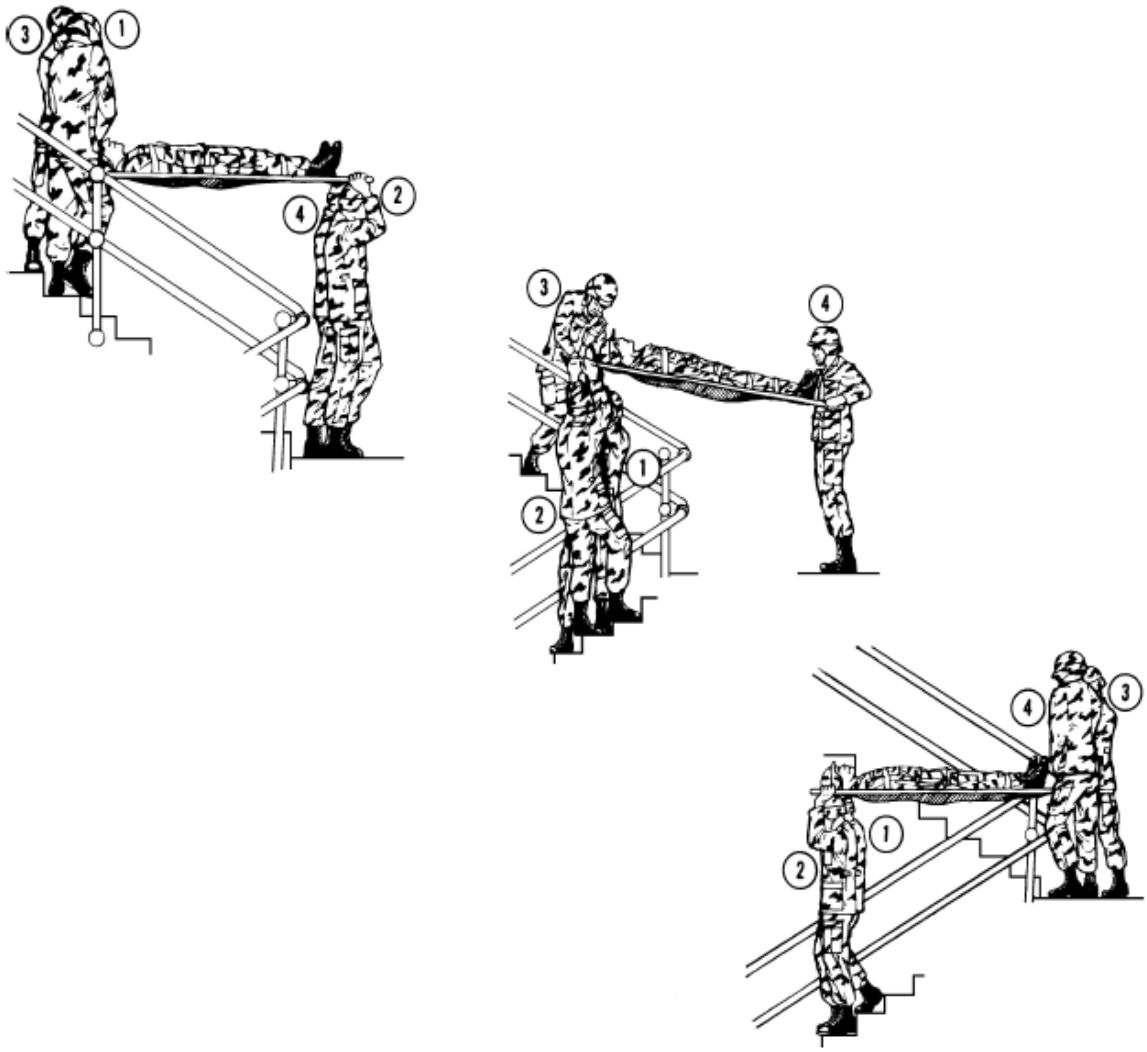


Figure J-35. Carrying a litter patient down a stairwell with small landings.

ภาพ ก- ๓๕ การถือเปลยกผู้ป่วยเจ็บลงบันไดภายในพื้นที่แคบ